

Bunga Rampai **PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL**

Model Asuhan, Kompetensi Klinis, dan Implementasi Evidence-Based Nursing

Okti Rahayu Asih • Imelda Rahmayunia Kartika • Asri Bashir • Fitria Nola Rezkiki
Editor: Hardono



BUNGA RAMPAI

**PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL:
MODEL ASUHAN, KOMPETENSI KLINIS, DAN
IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED NURSING**

Penulis:

Ns. Okti Rahayu Asih, S.Kep., M.Kep.
Ns. Imelda Rahmayunia Kartika, S.Kep., M.Kep.
Ns. Asri Bashir, S.Kep., M.Kep.
Ns. Fitria Nola Rezkiki, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Dr. Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.



Bunga Rampai Praktik Keperawatan Profesional: Model Asuhan, Kompetensi Klinis, dan Implementasi Evidence-Based Nursing

Penulis:

Ns. Okti Rahayu Asih, S.Kep., M.Kep
Ns. Imelda Rahmayunia Kartika, S.Kep., M.Kep.
Ns. Asri Bashir, S.Kep., M.Kep
Ns. Fitria Nola Rezkiki, S. Kep, M. Kep

Editor:

Dr. Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-55-4

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya buku **“Bunga Rampai Praktik Keperawatan Profesional: Model Asuhan, Kompetensi Klinis, dan Implementasi Evidence-Based Nursing”** ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa, perawat klinis, pendidik, serta pengelola pelayanan kesehatan. Buku ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan praktik keperawatan profesional yang semakin menuntut mutu, keselamatan pasien, dan akuntabilitas layanan. Melalui penyajian yang sistematis, setiap bab diharapkan mampu memperkaya pemahaman pembaca sekaligus mendorong penerapan ilmu keperawatan yang relevan dengan dinamika pelayanan di rumah sakit maupun komunitas.

Secara khusus, **Bab 1** membahas **Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)** dan penerapannya di rumah sakit, mulai dari definisi, pertimbangan pemilihan model, tingkat/spesifikasi, hingga ragam model yang dapat diimplementasikan sesuai konteks organisasi. Selanjutnya, buku ini menegaskan pentingnya pengambilan keputusan klinis berbasis bukti melalui **Bab 2** yang mengulas **manajemen nyeri berbasis bukti**—baik farmakologis, nonfarmakologis, maupun pendekatan **patient-centered care**—serta strategi implementasi di praktik klinis. Pembahasan kemudian diperluas pada **Bab 3**, yaitu praktik keperawatan pada pasien penyakit kronis (diabetes melitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung) dengan penekanan pada proses keperawatan, edukasi, self-management, dukungan keluarga-psikososial, serta tantangan dan isu etik yang kerap muncul dalam pelayanan jangka panjang.

Sebagai penguat kompetensi inti perawat dalam membangun hubungan terapeutik, **Bab 4** memaparkan **komunikasi terapeutik dan patient engagement**—fitur utama, luaran yang diharapkan, mekanisme komunikasi dalam mendorong keterlibatan pasien, hingga hambatan dan faktor pendukungnya di lapangan. Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis atas kontribusi ilmiah dan pengalaman praktik yang dituangkan, serta kepada semua pihak yang mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai pegangan pembelajaran dan acuan praktik, serta menjadi pemantik bagi peningkatan kualitas asuhan keperawatan profesional yang konsisten, manusiawi, dan berbasis bukti.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 MODEL ASUHAN KEPERAWATAN PROFESIONAL DAN PENERAPANNYA DI RUMAH SAKIT 1

Ns. Okti Rahayu Asih, S.Kep., M.Kep.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi Model Asuhan Keperawatan Profesional	2
C. Unsur Pertimbangan Pemilihan Model Metode Asuhan Keperawatan Profesional.....	2
D. Tingkat dan Spesifikasi Makp	3
E. Macam Model Asuhan Keperawatan Profesional	4
F. Referensi.....	12
G. Glosarium.....	13

CHAPTER 2 MANAJEMEN NYERI BERBASIS BUKTI: FARMAKOLOGIS, NONFARMAKOLOGIS, DAN *PATIENT-CENTERED CARE* 15

Ns. Imelda Rahmayunia Kartika, S.Kep., M.Kep.	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Konsep Dasar Nyeri dan <i>Evidence-Based Practice</i>	17
C. <i>Evidence-Based</i> Manajemen Nyeri Farmakologis.....	19
D. <i>Evidence-Based</i> Manajemen Nyeri Non Farmakologis	24
E. <i>Patient-Centered</i> dalam Manajemen Nyeri.....	26
F. Implementasi di Praktik Klinis.....	28
G. Simpulan.....	29
H. Referensi.....	30
I. Glosarium.....	36

CHAPTER 3 PRAKTIK KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS (DM, HIPERTENSI, PPOK, GAGAL JANTUNG) 37

Ns. Asri Bashir, S.Kep., M.Kep.....	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Konsep Dasar Penyakit Kronis.....	38

C. Peran dan Fungsi Perawat dalam Asuhan Pasien Penyakit Kronis.....	40
D. Proses Keperawatan pada Pasien Penyakit Kronis.....	41
E. Praktik Keperawatan pada Pasien Diabetes Mellitus	44
F. Praktik Keperawatan pada Pasien Hipertensi	46
G. Praktik Keperawatan pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)	48
H. Praktik Keperawatan pada Pasien Gagal Jantung	50
I. Edukasi dan Self-Management pada Pasien Penyakit Kronis.....	52
J. Dukungan Keluarga dan Psikososial pada Pasien Penyakit Kronis.....	54
K. Tantangan dan Isu Etik dalam Praktik Keperawatan Penyakit Kronis	55
L. Simpulan.....	56
M. Referensi.....	57

CHAPTER 4 KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN PATIENT ENGAGEMENT

DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN61

Ns. Fitria Nola Rezkiki, S.Kep., M.Kep.	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Komunikasi Terapeutik: Core Features & Outcomes	62
C. Bagaimana Komunikasi Terapeutik Mendorong Patient Engagement	66
D. Hambatan dan Fasilitator.....	78
E. Simpulan.....	81
F. Referensi.....	82

PROFIL PENULIS87

CHAPTER 1

MODEL ASUHAN KEPERAWATAN PROFESIONAL DAN PENERAPANNYA DI RUMAH SAKIT

Ns. Okti Rahayu Asih, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kualitas rumah sakit di mata masyarakat tercermin dari kualitas pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan di rumah sakit mencakup aktivitas asuhan keperawatan bermutu, membantu klien mencapai derajat kesehatan optimal, memfasilitasi rehabilitasi klien dan meningkatkan kepuasan terhadap rumah sakit. Praktik profesional keperawatan didukung oleh sistem pemberian asuhan keperawatan yang memiliki pedoman serta standar yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Model asuhan keperawatan merupakan suatu cara yang profesional dan sistematis dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Metode ini bertujuan agar asuhan keperawatan yang diberikan efektif, efisien serta berkualitas (Nursalam, 2020). Sistem Model Asuhan Keperawatan Profesional memiliki empat unsur yakni standar, proses keperawatan, pendidikan keperawatan dan praktik keperawatan. Perawat harus memiliki unsur dan nilai-nilai tersebut agar dapat memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan meningkatkan kepuasan pasien (Nursalam, 2015).

Penelitian Bloemhof et al (2021) menunjukkan bahwa kualitas asuhan keperawatan dapat ditingkatkan melalui penerapan Model Asuhan Keperawatan Profesional. Model Asuhan Keperawatan Profesional meningkatkan ketepatan intervensi serta efektivitas komunikasi antar tenaga kesehatan.

Keberhasilan dalam pelayanan keperawatan berbanding lurus dengan keberhasilan proses manajemen keperawatan. Untuk menciptakan layanan berkualitas tinggi maka dibutuhkan suatu sistem layanan profesional keperawatan. Hasil penelitian Harahap et al (2025) menunjukkan bahwa Model Asuhan Keperawatan Profesional meningkatkan kinerja perawat. Sementara itu penelitian Rupisa, Rosdiana & Mudayatiningsih (2018) hasil penelitian sebanyak 87.3% responden puas dengan Model Asuhan Keperawatan Profesional yang diterapkan di rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian layanan keperawatan yang

sistematis dan terstruktur melalui Model Asuhan Keperawatan Profesional dapat menunjang layanan keperawatan yang berkualitas.

B. Definisi Model Asuhan Keperawatan Profesional

Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) adalah suatu kerangka kerja yang mencakup empat unsur, yaitu standar, proses keperawatan, pendidikan keperawatan dan sistem MAKP (Nursalam, 2015). Perawat harus memiliki empat unsur tersebut agar kepuasan pasien dalam mendapatkan layanan asuhan keperawatan yang berkualitas tercapai.

C. Unsur Pertimbangan Pemilihan Model Metode Asuhan Keperawatan Profesional

Suatu rumah sakit sudah seharusnya mempertimbangkan unsur-unsur dalam memilih model metode asuhan keperawatan profesional yang akan diterapkan di rumah sakit masing-masing. Pertimbangan ini bisa menjadikan satu ruangan akan berbeda model penugasan keperawatan dengan ruangan yang lain. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu

1. Sesuai dengan visi misi institusi
Model asuhan keperawatan, dasar utamanya adalah visi dan misi organisasi atau institusi pelayanan kesehatan
2. Proses keperawatan dapat diterapkan dalam asuhan keperawatan
Kesinambungan asuhan keperawatan adalah unsur penting dalam proses keperawatan. Pendekatan proses keperawatan merupakan kunci keberhasilan asuhan keperawatan.
3. Penggunaan biaya efektif dan efisien
4. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk berkaitan dengan pembiayaan setiap model. Hal ini menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan oleh institusi.
5. Kepuasan pasien, keluarga dan masyarakat dapat dipenuhi
Tujuan utama asuhan keperawatan adalah kepuasan pelanggan, termasuk pelanggan eksternal dalam hal ini pasien terhadap asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat. Model asuhan keperawatan yang baik adalah yang dapat menunjang kepuasan pasien.
6. Kepuasan dan kinerja perawat
Keefektifan dan kelancaran terlaksananya suatu model sangat ditentukan oleh motivasi dan kinerja perawat. Model yang diterapkan diharapkan dapat

meningkatkan kepuasan dan kinerja perawat sehingga menciptakan asuhan keperawatan yang berkualitas.

7. Komunikasi yang adekuat perawat dan tim kesehatan lainnya terlaksana
Komunikasi profesional yang disesuaikan dengan area tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan, menjadi unsur penentu dipilihnya suatu model asuhan keperawatan. Model asuhan keperawatan yang dipilih hendaknya dapat meningkatkan hubungan komunikasi dan interpersonal yang baik antara perawat dan tenaga kesehatan yang lain.

D. Tingkat dan Spesifikasi Makp

1. MAKP Pemula

- a. Mampu memberikan asuhan keperawatan profesi tingkat pemula.
- b. Metode pemberian askep yaitu dengan modifikasi keperawatan primer
- c. Ketenagaan D-3 Keperawatan sebagai PP Pemula

2. MAKP I

- a. Mampu memberikan asuhan keperawatan profesional tingkat I
- b. Metode pemberian askep yaitu modifikasi keperawatan primer
- c. PP adalah Skep/Ners, agar PP dapat memberikan asuhan keperawatan berdasarkan ilmu dan teknologi diperlukan kemampuan seorang ners spesialis yang akan berperan sebagai clinical manager (CCM). D-3 keperawatan sebagai PA

3. MAKP II

- a. Mampu memberikan asuhan keperawatan tingkat II
- b. Metode pemberian asuhan keperawatan yaitu manajemen kasus
- c. Jumlah ketenagaan sesuai kebutuhan. Pendidikan magister keperawatan (M.Kep) atau perawat spesialis (Sp.Kep). tugas dan tanggung jawab memberikan asuhan keperawatan lanjutan kepada pasien dengan masalah kesehatan kompleks atau kritis, berperan sebagai konsultan bagi perawat lain dalam pengambilan keputusan klinis, memimpin penelitian keperawatan dan pengembangan praktik berbasis bukti di lingkungan kerja

4. MAKP III

- a. Mampu memberikan asuhan keperawatan tingkat II
- b. Metode pemberian asuhan keperawatan yaitu manajemen kasus
- c. Jumlah tenaga sesuai kebutuhan, doktor keperawatan (PhD) atau pendidikan dengan pengalaman klinis yang luas. Tugas dan tanggung jawab merancang kebijakan dan strategi untuk pengembangan asuhan keperawatan di tingkat institusional atau nasional, membimbing dan mengawasi pengembangan

profesional perawat di semua tingkat meningkatkan kualitas layanan keperawatan melalui inovasi, penelitian, dan pelatihan lanjutan

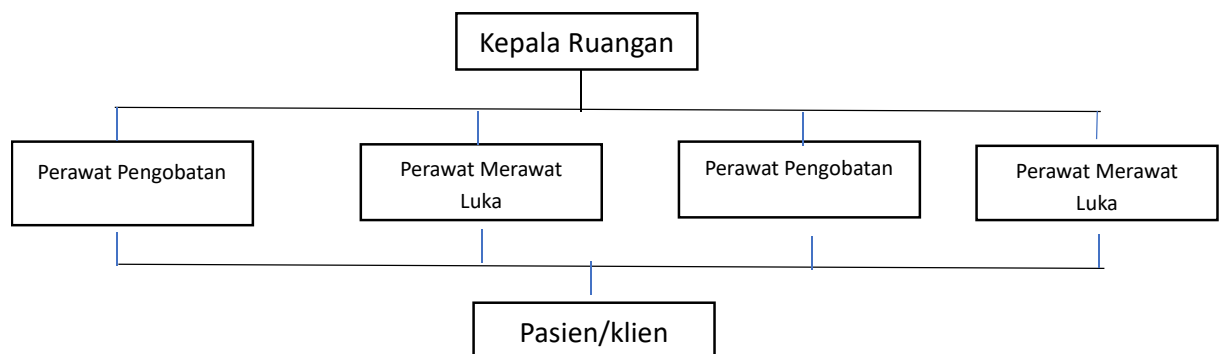
E. Macam Model Asuhan Keperawatan Profesional

1. Model Asuhan Keperawatan Fungsional

Model asuhan keperawatan fungsional dikenal sejak Perang Dunia ke-2. Saat itu jumlah dan kemampuan perawat terbatas. Adanya kekurangan tenaga ini menyebabkan rekrutmen petugas tambahan yang tidak terlatih untuk mengerjakan pekerjaan sederhana, bukan bersifat khusus merawat pasien yang. Sebagai contoh, mereka melakukan pengukuran tekanan darah, memberikan obat, serta memandikan pasien Sementara itu, perawat yang terdaftar tidak langsung melakukan asuhan keperawatan pada pasien.

Praktik model asuhan keperawatan fungsional ini kemudian diteruskan dengan alasan pertimbangan hemat biaya. Rumah sakit masih memperkerjakan perawat dengan berbagai level pendidikan dan dan tingkat keterampilan. Pada model asuhan keperawatan fungsional, perawat yang bertugas pada satu unit/ruangan dibagi tugasnya berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Misal satu perawat bertugas menyuntik/injeksi, sementara perawat yang lain bertugas memeriksa tanda-tanda vital.

Tidak banyak penelitian mengenai penerapan Model Asuhan Keperawatan Profesional dengan metode fungsional. Menurut hasil penelitian Hastono dan Pratiwi (2009) bahwa terdapat kepuasan pasien terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan dengan metode fungsional. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa selain metode asuhan keperawatan fungsional terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien seperti fasilitas pelayanan kesehatan.



Gambar 1.1: Sistem Asuhan Keperawatan dengan Model Fungsional

Sumber: Marquis & Huston, 1998

Sistem metode keperawatan fungsional memiliki kelebihan dan kelemahan, yakni:

Kelebihan:

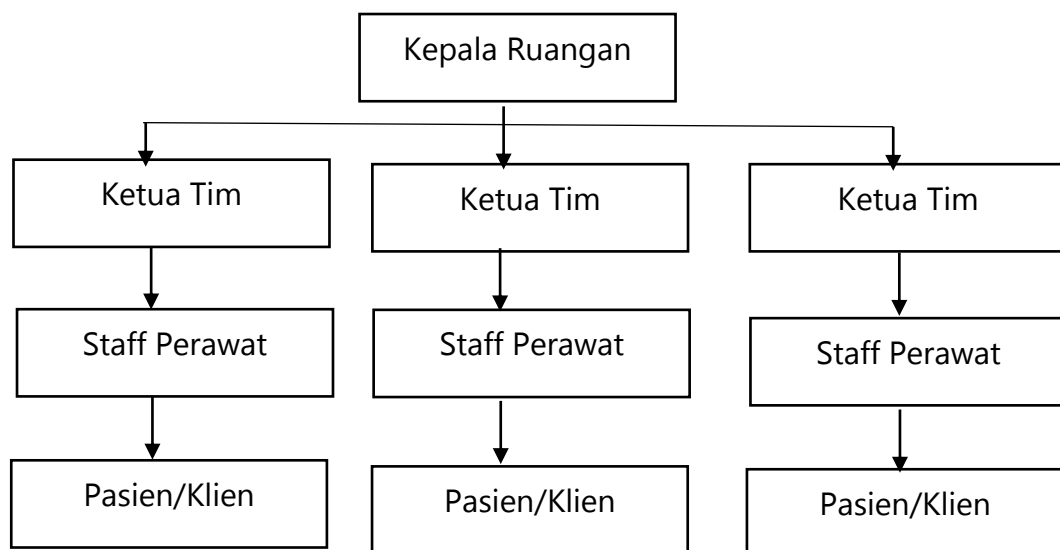
- Efisien untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga perawat
- Perawat senior fokus pada tugas manajerial dan perawat junior fokus merawat pasien
- Masing-masing perawat memiliki keahlian tertentu dalam merawat pasien

Kelemahan:

- Kepuasan kerja rendah, kurang menstimulasi kemampuan perawat
- Tidak menerapkan asuhan keperawatan secara utuh
- Tidak efektif biaya karena membutuhkan banyak koordinator
- Perawat hanya fokus dengan tindakan yang sesuai keterampilannya saja

2. Model Asuhan Keperawatan Tim

Model Asuhan Keperawatan Profesional Tim yaitu dalam satu tim memiliki anggota yang berbeda memberi asuhan keperawatan kepada sekelompok pasien. Teknisnya, perawat dalam satu ruangan dibagi menjadi 2-3 tim di bawah arahan perawat profesional. Ketua tim memerlukan keterampilan *leadership* serta seluruh anggota tim perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik.



Gambar 1.2: Sistem asuhan keperawatan metode tim

Sumber: Marquis & Huston, 1988

Kelebihan:

- a. Pelayanan keperawatan yang menyeluruh memungkinkan untuk dilaksanakan
- b. Proses keperawatan dapat dilaksanakan
- c. Memerlukan keterampilan koordinasi dan komunikasi yang baik

Kekurangan:

Sering tidak tersedia waktu yang cukup untuk komunikasi antar anggota tim

Model Asuhan Keperawatan Profesional Tim telah dilakukan di rumah sakit seluruh dunia termasuk di Indonesia (Hasibuan, 2018). Hasil penelitian Sihura et al (2021), pelaksanaan Metode Asuhan Keperawatan Profesional Tim belum optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Muryani (2019), bahwa pelaksanaan metode tim di RS Muhammadiyah Babat belum sesuai dengan standar Metode Asuhan Keperawatan Profesional tim. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional Tim di rumah sakit di Indonesia masih memiliki hambatan. Hambatan tersebut antara lain ketidakseimbangan pembagian tugas, tidak ada atau kurangnya koordinasi, peran masing-masing anggota yang belum dipahami sepenuhnya. Kurang optimalnya pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional Tim berpotensi mempengaruhi kinerja perawat (Harahap et al, 2025).

Menurut hasil penelitian Harahap (2005) terdapat pengaruh implementasi Metode Asuhan Keperawatan Profesional Tim di RSUD Kota Padangsidimpuan terhadap kinerja perawat. Hal ini meliputi aspek tugas rutin, kemampuan adaptif dan perilaku profesional. Hasil serupa ditemukan di RS Ernaldi Bahar Sumatera bahwa terdapat hubungan antara penerapan Metode Asuhan Keperawatan Profesional Tim dengan kinerja perawat (Fitriana & Fadila, 2023).

Penerapan Model Asuhan Perawatan Profesional yang tepat akan memiliki pengaruh pada kinerja perawat. Hal ini selanjutnya akan berefek pada meningkatnya angka pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau *Bed Occupancy Rate* (BOR). Pada akhirnya akan memiliki pengaruh menurunnya angka *Average Length of Stay* (AVLOS) yang merupakan indikator mutu pelayanan di rumah sakit.

3. Model Asuhan Keperawatan Primer

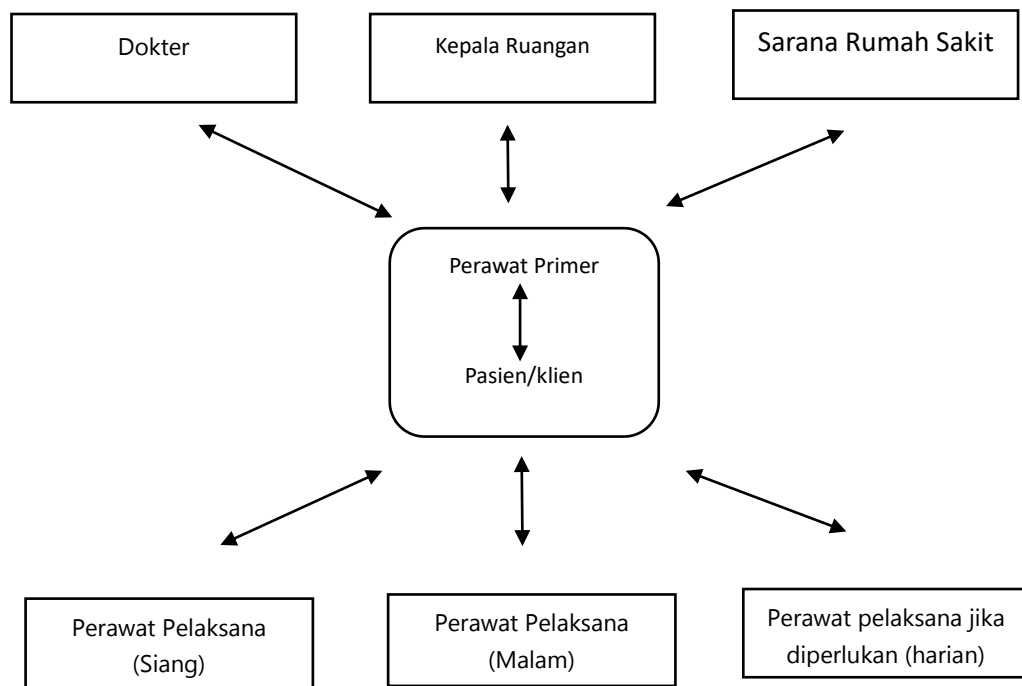
Model asuhan keperawatan primer adalah suatu metode penugasan, yang mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien. Selain dirancang digunakan di rumah sakit, Model

Asuhan Keperawatan Primer juga dapat digunakan di keperawatan keluarga maupun lembaga pemberi layanan keperawatan lainnya seperti *homecare*.

Metode asuhan ini merupakan pemberian asuhan langsung terhadap pasien, di mana perawat primer mengelola sekelompok pasien selama perawatan dengan berfokus pada pasien, bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan, perencanaan dan pelaksanaan suatu tindakan (otonomi), dan bertanggung jawab terhadap kualitas asuhan pasien.

Perawat profesional pada metode ini disebut sebagai perawat primer (*registered nursed*) yang berpendidikan minimal sarjana keperawatan (Murray, 2017). Tanggung jawab perawat primer (RN) sejak pengkajian hingga evaluasi keperawatan dari mulai pasien masuk rumah sakit sampai pasien pulang. Dalam melaksanakan tugasnya, perawat primer dibantu oleh perawat asosiet. Pemberian asuhan keperawatan model ini dilakukan secara komprehensif yang berorientasi pasien.

Model asuhan keperawatan primer menstimulasi praktik kemandirian perawat. Perawat primer mengelola sekelompok pasien, membuat rencana asuhan keperawatan, pelaksanaan termasuk memberi edukasi kepada pasien, dan bertanggung jawab terhadap kualitas asuhan keperawatan. Perawat primer juga bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan, perencanaan dan pelaksanaan tindakan otonomi. Pada model asuhan keperawatan primer terdapat keterkaitan yang terus menerus antara pasien dan perawat yang ditugaskan untuk merencanakan, melakukan dan mengkoordinasi asuhan keperawatan pasien yang dirawat. Selain itu, perawat memiliki tanggung jawab utama dalam membuat komunikasi yang jelas antara pasien, perawat, dokter dan tenaga kesehatan yang lain.



Gambar 1.3: Sistem Asuhan Keperawatan dengan Model Keperawatan Primer
Sumber: Marquis & Huston, 1998)

Kelebihan:

- a. Bersifat terus menerus dan menyeluruh
- b. Perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil serta memungkinkan pengembangan diri
- c. Keuntungan lain terhadap pasien, perawat, dokter dan rumah sakit

Adapun keuntungan diterapkannya Model Asuhan Keperawatan Profesional Primer bagi pasien yakni pasien terpenuhi kebutuhan individualnya. Selain itu terbentuknya hubungan saling percaya antara perawat dan pasien sehingga memudahkan perawat dalam merawat pasien yang bisa berdampak pada berkurangnya hari rawatan pasien. Dokter merasa puas karena mendapatkan informasi tentang pasien yang selalu diperbaharui dan menyeluruh. Di lain sisi, perawat mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi, perawat merasa mendapatkan tantangan serta dapat mengembangkan keterampilan asuhan keperawatan.

Kelemahannya yaitu

- a. Model asuhan keperawatan ini hanya dapat dilaksanakan oleh perawat yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang memadai, dengan kriteria asertif, *self direction*, kemampuan mengambil keputusan yang tepat,

menguasai keperawatan klinis, penuh pertimbangan dan mampu berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu

- b. Biaya lebih besar karena dibutuhkan tenaga profesional yang lebih banyak
- c. Ada kemungkinan perawat kurang kompeten, kurang siap dan tidak mampu mengkoordinasikan masalah dan kebutuhan pasien pada tenaga kesehatan yang lain sehingga menyebabkan terhambatnya proses asuhan keperawatan

Hasil penelitian Sirait (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara penerapan model asuhan keperawatan primer dengan peningkatan kepuasan kerja perawat. Adapun faktor yang dominan yang mempengaruhi hasil tersebut yakni pendekatan manajemen dan hubungan profesional. Di lain sisi, studi yang dilakukan oleh Fanny Noviany, dkk (2022) menemukan bahwa terdapat hubungan kinerja perawat dalam menerapkan model praktik keperawatan profesional terhadap kepuasan pasien.

Sementara itu kajian Orienti, T. N., Indracahyani, A., & Rayatin, L. (2020) menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman terhadap metode asuhan keperawatan primer merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan metode asuhan. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan model asuhan tim secara berkala. Selain itu faktor latar belakang pendidikan formal, kompetensi atau keahlian keperawatan yang belum sesuai, belum optimalnya peran dan fungsi manajemen yang belum optimal, dan penggunaan teknologi keperawatan yang belum memadai menjadi faktor-faktor yang menyebabkan metode asuhan keperawatan primer belum optimal diterapkan di rumah sakit.

4. Model Asuhan Keperawatan Kasus

Model penugasan kasus adalah masing-masing perawat memiliki tugas melayani seluruh kebutuhan pasien. Satu perawat bertanggung jawab pada satu pasien. Metode penugasan ini biasanya diterapkan untuk perawatan khusus seperti *intensive care* dan ruang isolasi.

Kelebihan :

- a. Perawat lebih mengenal dan memahami kasus per kasus
- b. Sistem evaluasi dan manajerial lebih mudah

Kekurangan:

- a. Perawat penanggung jawab belum dapat teridentifikasi
- b. Perlu tenaga yang cukup banyak dengan kemampuan dasar yang sama



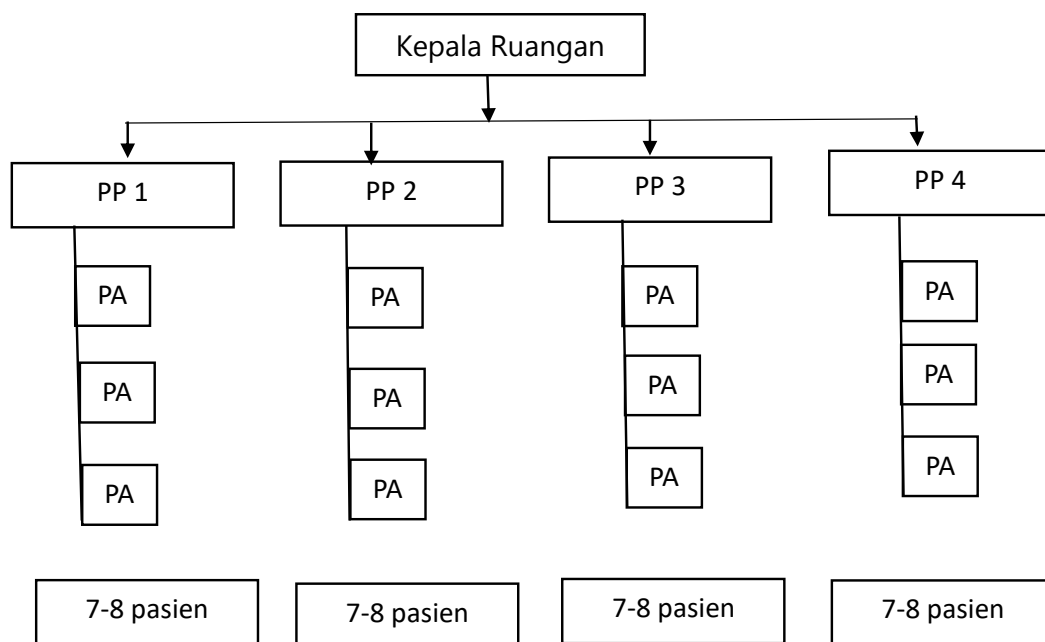
Gambar 1.4: Sistem Asuhan Keperawatan dengan Model Manajemen Kasus (Marquis & Huston, 1988)

Studi di Instalasi Rawat Intensif RS Panti Waluya Sawahan Malang menunjukkan bahwa sebanyak 66,6% perawat melakukan prosedur pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional Kasus dengan kategori baik. Penelitian tersebut juga menunjukkan terdapat korelasi positif antara penerapan metode penugasan kasus dengan kepuasan pasien (Oktavia, Ngesti, Neni, 2017).

5. Model Asuhan Keperawatan Tim-Primer

Model Asuhan Keperawatan Profesional Tim-Primer merupakan perpaduan antara dua sistem, yaitu keperawatan tim dan primer. Alasan penetapan metode ini menurut Ratna S Sudarsono (2000 dalam Nursalam 2015), yaitu:

- Metode keperawatan primer tidak bisa murni dilaksanakan. Hal ini disebabkan metode keperawatan primer memerlukan latar belakang pendidikan S1 yang setara
- Metode tim tidak bisa dilaksanakan secara murni karena tanggung jawab asuhan keperawatan primer terbagi dalam beberapa tim
- Melalui kombinasi keperawatan primer dan tim diharapkan komunitas asuhan keperawatan dan akuntabilitas asuhan keperawatan terdapat pada primer.



Jadwal diatur pagi, siang, malam, cuti
Gambar 1.5: Metode Tim Primer Modifikasi
Sumber: Nursalam, 2014

Pada Model Asuhan Keperawatan Profesional Tim-Primer, perawat perlu memiliki pengetahuan, terampil dan memiliki kemampuan kepemimpinan. Dalam metode ini, tim terdiri dari 2-3 orang perawat yang bertanggung jawab terhadap 8-12 orang pasien. Salah satu syarat metode ini dapat digunakan adalah peralatan yang dibutuhkan cukup memadai.

Kepala ruangan berperan membuat jadwal dinas, dengan pertimbangan kesesuaian anggota untuk saling bekerjasama. Selain itu kepala ruangan juga memiliki peran sebagai fasilitator, pembimbing dan motivator dan mengevaluasi kinerja perawat. Perawat Primer (PP) memiliki peran membuat perencanaan asuhan keperawatan, mengadakan tindakan kolaborasi, memimpin timbang terima, mendelegasikan tugas, memimpin ronde keperawatan, mengevaluasi pemberian asuhan keperawatan, bertanggung jawab pada pasien dan mengisi resume keperawatan. Sementara itu, Perawat Associate (PA) bertugas memberikan asuhan keperawatan, mengikuti timbang terima, melaksanakan tugas yang didelegasikan, serta melakukan dokumentasi keperawatan.

Hasil penelitian Andung, Ni, Neni (2017) menunjukkan bahwa rata-rata total kinerja perawat Ruang Dahlia RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Sumba Timur yang menerapkan Model Asuhan Keperawatan Profesional Tim-Primer adalah cukup yaitu sebanyak 58 %. Hal ini ditandai dengan perawat sebanyak

75% melakukan kegiatan timbang terima dengan baik, sebanyak 42% perawat melakukan pre conference dengan baik, sebanyak 42% perawat melakukan *post conference* dengan baik, sebanyak 100% perawat melakukan ronde keperawatan dengan baik, sebanyak 50% perawat cukup melaksanakan *discharge planning*, serta sebanyak 67 % perawat melakukan dokumentasi keperawatan dengan baik.

F. Referensi

-
- Andung, Pendrita Jeffri Ratu Andung, Ni Luh Putu Eka Sudiwati, Neni Maemunah. (2017). Gambaran Kinerja Perawat Dalam Penerapan Metode Asuhan Keperawatan Profesional (Makp) Modifikasi Tim-Primer di Ruang Dahlia RSUD Umu Rara Meha Waingapu Sumba Timur. *Jurnal Nursing News*, 2 (3), 746-758
- Fitriana, M., & Fadila, N. (2023). Pengaruh Penerapan Manajemen Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) Tim terhadap Kinerja Perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 11(1), 55–63. <https://doi.org/10.32583/jiki.v11i1.1747>
- Harahap, Putri Pameliah, et al. (2025). Hubungan Implementasi Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) Tim dan Kinerja Perawat di RSUD Padangsidempuan. *Jurnal Ners* 9 (4), 6025 – 6032
- Hasibuan, Y. M. (2018). Hubungan Metode Penugasan Asuhan Keperawatan Tim Dengan Kinerja Perawat Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2017. Universitas Sumatera Utara.
- Hastono, H. P., & Pratiwi, A. (2017). Analisis Perbedaan Kepuasan Pasien terhadap Asuhan Keperawatan antara Metode Fungsional dan Alokasi Pasien di Rumah Sakit Islam Surakarta. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 2(2)
- Murray, E. (2017). *Nursing Leadership and Management for patient safety and quality care*. F.A, Davis Company, Philadelphia. Philadelphia: F.A.Davis company. <https://doi.org/LCCN2016052944>
- Muryani. (2019). Upaya Optimalisasi Penerapan Metode Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) Model Tim Dalam Meningkatkan Kinerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. Universitas Airlangga.
- Nursalam. 2015. *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Keperawatan Profesional, Edisi 5*. 2015. Jakarta : Salemba Medika.
- Nursalam.2002. *Manajemen Keperawatanm Aplikasi dalam Praktek Keperawatan Profesional*.Jakarta: Salemba Medika.
- Oktavia, Ngesti, Neni. 2017. Hubungan Pelaksanaan MAKp Kasus dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Intensif (IRI) RS Panti Waluya Sawahan Malang. *Nursing News*, 2 (3), 759-769

- Orienti, T. N., Indracahyani, A., & Rayatin, L. (2020). Analisis Situasi Dan Optimalisasi Pelaksanaan Metode Asuhan Keperawatan Primer Pada Rumah Sakit Anak dan Bunda di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 16(1), 90-98.
- Profesional (MAKP) Tim dengan Tingkat Kepuasan Kerja Perawat di Rumah Sakit Panti
- Rupisa, Rosdiana, Y., & Mudayatiningsih, S. (2018). Hubungan Model Asuhan Keperawatan
- Sihura, S. S. G., Purnama, A., & Rokhmiati, E. (2021). Optimalisasi Model Asuhan Keperawatan Profesional Tim Di Ruang S RS X Bogor. *Journal of Management Nursing*, 1(1), 17-22.
- Sirait, Y. (2012). Hubungan PenerapanMPKP Pemula dengan Tingkat Kepuasan Kerja Perawat dan Dokter pada Ruangan MPKP Pemula Di RS PGI Cikini Jakarta. Tesis FI KUI, 162. <https://doi.org/10.1192/bjp.122.5.573>
- Waluyo Malang. *Journal Nursing News*, 3(1), 287-300.

G. Glosarium

MAKP = Model Asuhan Keperawatan Profesional

CHAPTER 2

MANAJEMEN NYERI BERBASIS BUKTI: FARMAKOLOGIS, NONFARMAKOLOGIS, DAN *PATIENT-CENTERED CARE*

Ns. Imelda Rahmayunia Kartika, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Nyeri adalah salah satu gejala yang menjadi masalah kesehatan di dunia dan paling sering dialami oleh pasien serta telah menjadi salah satu alasan utama kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan (Katz, 2002; Mills et al., 2016). Dalam gambaran epidemiologi, prevalensi dari nyeri kronik diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sekitar 20% pada populasi dewasa di beberapa negara maju, dan gangguan rasa nyaman nyeri ini sering kali berlangsung lebih dari tiga bulan sehingga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup individu dan mengganggu aktifitas pasien. Hal ini menunjukkan bahwa nyeri bukan hanya sekadar gejala sementara, tetapi juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian klinis dan kebijakan yang memadai di sector kesehatan (IASP, 2020). Nyeri tidak hanya berkontribusi pada gangguan fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikologis pasien. Individu yang mengalami nyeri kronik secara signifikan sering kali melaporkan gejala kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan penurunan motivasi hidup. Dampak psikologis ini dapat memperburuk persepsi nyeri dan menciptakan siklus umpan balik negatif di mana nyeri dan kondisi mental saling memperkuat. (Crombez et al., 2023).

Dalam kondisi sosial, nyeri akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpartisipasi dan menjalani aktivitas sosial, berpengaruh dalam mempertahankan hubungan interpersonal, serta dalam menjalankan peran sosialnya. Pasien dengan nyeri kronik sering kali akan mengalami keterbatasan aktivitas, kesulitan dalam bekerja, dan penurunan produktivitas, yang secara tidak langsung akan memberikan beban ekonomi bagi keluarga dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat dikatakan, nyeri akan berdampak bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masyarakat maupun sistem sosial ekonomi (Rahmat Santoso et al., 2025). Oleh karena itu, perlu adanya manajemen nyeri yang optimal untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Meskipun manajemen nyeri telah menjadi fokus dalam penelitian dan praktik klinis Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak pasien mengalami perawatan yang

kurang optimal sehingga nyeri tidak tertangani secara adekuat. Kurangnya pengkajian yang tepat, sistem dokumentasi yang tidak konsisten dan memadai, serta penggunaan standar yang belum merata di berbagai fasilitas kesehatan menjadi faktor utama penyebab fenomena ini terjadi (AMA, 2020).

Masalah lain yang sering muncul dalam praktik klinis mengenai nyeri ini adalah stigma terhadap penggunaan obat-obatan jenis opioid sebagai terapi nyeri, terutama dalam kasus nyeri kronik yang berat dan nyeri kanker. Meskipun opioid tetap menjadi salah satu terapi modalitas farmakologis yang cukup efektif pada beberapa kondisi, kekhawatiran terkait penyalahgunaan dan ketergantungan obat jenis opioid ini telah menyebabkan pembatasan penggunaan serta sikap negatif dari tenaga kesehatan dan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan penanganan nyeri yang tidak optimal (Edwards et al., 2025). Selain stigma dari penggunaan opioid, keterbatasan edukasi baik pada tenaga Kesehatan maupun pasien turut memperburuk pengelolaan nyeri. Banyak tenaga kesehatan yang belum cukup terlatih dalam penilaian nyeri berbasis bukti, intervensi multimodal dan komplementer, serta pemilihan terapi yang tepat, sementara pasien sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang nyeri itu sendiri atau pilihan manajemennya (Grommi et al., 2023). Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan strategi perawatan dan ketidakpuasan pasien terhadap layanan yang diberikan (Rahmat Santoso et al., 2025).

Nyeri sebagai pengalaman yang multidimensional memperlihatkan bahwa penatalaksanaannya seharusnya tidak hanya berdasarkan pada pengobatan simptomatik semata. Pendekatan yang baik, optimal dan terintegrasi, termasuk pengkajian yang komprehensif serta pertimbangan terhadap faktor biologis, psikologis, dan sosial harus dilakukan untuk merancang strategi manajemen nyeri yang efektif dan berkelanjutan (*biopsychosocial model*). Pendekatan ini mendapatkan dukungan dari banyak literatur ilmiah serta organisasi internasional yang menekankan perlunya manajemen nyeri yang luas cakupannya (multimodal) untuk memaksimalkan outcome pasien (IASP, 2020).

Dalam konteks kebijakan kesehatan global, masih terdapat kesenjangan antara *evidence based* yang tersedia dan praktik klinis yang diterapkan di lapangan. Beberapa kebijakan yang restriktif dapat membatasi akses pasien terhadap terapi nyeri yang aman dan efektif, sementara kebijakan yang lemah justru malah akan meningkatkan risiko keselamatan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kebijakan dan pedoman klinis yang berbasis bukti (*evidence-based*) untuk mengarahkan praktik praktik klinis serta mengurangi variasi dalam manajemen nyeri di berbagai layanan kesehatan (*evidence-informed pain care*) (Shetty et al., 2025) Pendekatan *evidence-based pain management* menekankan

betapa pentingnya integrasi antara bukti riset terkini, pengalaman klinis profesional, dan nilai serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis dalam mengatasi nyeri yang mereka rasakan. Model ini tidak hanya meningkatkan efektivitas perawatan, tetapi juga menempatkan pasien sebagai mitra aktif dalam proses pengobatan, yang pada akhirnya mendukung hasil yang lebih bermakna bagi pasien (AMA, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjelaskan bahwa nyeri merupakan isu kesehatan global yang cukup kompleks dengan berbagai dampak seperti dampak fisik, psikologis, dan sosial yang luas. Dalam bab ini, kita akan mengkaji urgensi pendekatan berbasis bukti dalam manajemen nyeri, tantangan utama yang dihadapi praktik klinis saat ini, serta landasan teoretis yang mendukung strategi perawatan nyeri yang komprehensif dan tentunya berpusat pada pasien (*patient centered care*).

B. Konsep Dasar Nyeri dan *Evidence-Based Practice*

Nyeri yang sering didefinisikan oleh *International Association for the Study of Pain* (IASP) sebagai “pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial” (IASP, 2020). Definisi ini menegaskan bahwa nyeri bukan hanya sekadar respon fisiologis, tetapi merupakan pengalaman subjektif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial seorang individu. Dengan demikian, pendekatan terhadap nyeri tentunya tidak hanya mengandalkan dimensi biomedis saja, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang komprehensif serta sensitif menurut pengalaman dan persepsi pasien.

Secara klinis, nyeri dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi dan mekanisme. Berdasarkan durasi, nyeri terbagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut biasanya berlangsung singkat, terkait dengan kerusakan jaringan, dan memiliki fungsi protektif (kurang dari 6 bulan). Sebaliknya, nyeri kronik didefinisikan sebagai nyeri yang berlangsung lebih dari tiga bulan dan sering kali tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme protektif, melainkan menjadi kondisi penyakit tersendiri (Treede et al., 2019). Sementara itu, berdasarkan mekanismenya, nyeri dibedakan menjadi nyeri nosiseptif, neuropatik, dan *mixed pain*. Nyeri nosiseptif muncul akibat aktivasi reseptor nosiseptor karena inflamasi atau kerusakan jaringan, sedangkan nyeri neuropatik timbul akibat kerusakan atau disfungsi dari sistem saraf. Pada kondisi tertentu, kedua mekanisme dapat terjadi secara bersamaan sehingga menghasilkan nyeri campuran yang lebih kompleks dan sulit ditangani (Nicholas et al., 2019).

1. Mekanisme Fisiologis Nyeri

Secara fisiologis, ada empat tahapan proses terjadinya nyeri yakni: transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Pada tahap transduksi, rangsangan nyeri dikonversi menjadi impuls listrik oleh nosiseptor. Impuls ini kemudian ditransmisikan melalui serabut saraf perifer menuju medula spinalis dan selanjutnya ke otak. Pada tahap modulasi, sistem saraf pusat dapat memperkuat atau menurunkan sinyal nyeri melalui mekanisme inhibisi endogen. Tahap terakhir adalah persepsi, ketika otak memproses dan memberikan makna terhadap pengalaman nyeri (Goudet & Marchand, 2022). Pemahaman mekanisme ini penting karena menjadi dasar pengembangan intervensi farmakologis maupun nonfarmakologis yang menargetkan berbagai titik dalam jalur nyeri.

Nyeri tidak hanya pengalaman sensori, tetapi juga melibatkan dimensi emosional, kognitif, sosial, dan spiritual. Model biopsikososial menjelaskan bahwa nyeri dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis (kerusakan jaringan, proses inflamasi), psikologis (kecemasan, depresi, coping), dan sosial (dukungan keluarga, budaya, pekerjaan) (Gatchel, 2004; Gornitzky & Diab, 2021). Dengan demikian, dua pasien dengan intensitas nyeri yang sama dapat merasakan dampak yang sangat berbeda tergantung pada konteks psikososial yang melingkupinya. Konsekuensinya, pendekatan manajemen nyeri perlu disesuaikan dengan kebutuhan individual pasien, bukan hanya berdasarkan diagnosis medis, karena nyeri adalah pengalaman yang sangat subjektif tergantung pada setiap individu yang merasakannya.

Meskipun konsep nyeri sudah dipahami secara komprehensif, praktik klinis masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pasien mengalami penanganan yang tidak optima akibat pelaksanaan pengkajian nyeri yang tidak adekuat, keterbatasan waktu tenaga kesehatan, kurangnya pelatihan manajemen nyeri, serta stigma yang melekat pada terapi tertentu seperti opioid (Azizoddin et al., 2021). Selain itu, masih ditemukan variasi besar dalam praktik manajemen nyeri antar fasilitas kesehatan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara bukti ilmiah dan praktik klinis.

2. Evidence-Based Practice dalam Manajemen Nyeri

Evidence-Based Practice (EBP) merupakan pendekatan pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan nilai serta preferensi pasien (Barrie & Loughlin, 2014). Dalam konteks manajemen nyeri, EBP memastikan bahwa strategi perawatan tidak hanya didasarkan pada pengalaman klinisi atau kebiasaan praktik, tetapi juga pada

hasil penelitian terkini yang terbukti efektif dan aman. Pendekatan ini sangat relevan mengingat dinamika perkembangan ilmu nyeri dan banyaknya intervensi yang tersedia, baik farmakologis maupun nonfarmakologis. Prinsip utama dari *evidence-based pain (EBP) management* meliputi pengkajian nyeri yang akurat, pemilihan intervensi berbasis bukti, penggunaan pendekatan multimodal, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas dan keamanan terapi. Pengkajian nyeri harus bersifat holistik, meliputi intensitas nyeri, dampak fungsional, aspek psikologis, serta preferensi pasien. Intervensi multimodal menggabungkan berbagai modalitas terapi untuk memaksimalkan hasil klinis dan meminimalkan risiko efek samping (Barrie & Loughlin, 2014).

Patient-centered care (PCC) menjadi elemen penting dalam implementasi EBP. Pasien tidak diposisikan sebagai suatu objek terapi, melainkan sebagai mitra yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nilai, harapan, budaya, dan preferensi pasien harus menjadi bagian integral dalam perencanaan dalam intervensi nyeri. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan kepatuhan, kepuasan, dan hasil klinis, termasuk kualitas hidup pasien (Knaul et al., 2018). Bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, dokter, dan tenaga rehabilitasi, pemahaman mengenai konsep nyeri dan EBP bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi merupakan kompetensi klinis yang esensial. Tenaga kesehatan dituntut untuk mampu melakukan pengkajian komprehensif, memilih intervensi yang tepat, mengevaluasi dampak terapi, serta berkomunikasi efektif dengan pasien dan keluarga. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan klinis, dan dukungan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan implementasi *evidence-based pain management* baik secara farmakologis maupun non farmakologis berjalan optimal (Barrie & Loughlin, 2014; Hashefi et al., 2013).

Secara keseluruhan, nyeri merupakan pengalaman multidimensional yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan komprehensif berbasis bukti. Pemahaman tentang definisi, klasifikasi, dan mekanisme nyeri menjadi dasar penting untuk mengembangkan strategi manajemen yang efektif. Integrasi *Evidence-Based Practice* dan *patient-centered care* merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan intervensi, dan hasil yang diharapkan pasien dalam manajemen nyeri.

C. Evidence-Based Manajemen Nyeri Farmakologis

Manajemen nyeri secara farmakologis dilakukan berlandaskan pada prinsip efektivitas, keamanan, individualisasi, dan pendekatan multidimensi. Pemilihan obat harus mempertimbangkan jenis nyeri (*nociceptive, neuropathic*, atau *mixed*

pain), tingkat keparahan, kondisi komorbid, risiko efek samping, serta preferensi pasien. Pemberian beberapa jenis obat-obatan analgesik direkomendasikan untuk menggabungkan dua atau lebih agen dengan mekanisme berbeda agar meningkatkan efek analgesik dan mengurangi dosis tunggal obat, sehingga menurunkan risiko toksisitas (Asthana et al., 2019; World Health Organization, 2018)(Zendrato, 2020). Selain itu, konsep start low and go slow penting terutama pada pasien lanjut usia dan pasien dengan penyakit kronik. Evidence terkini juga menekankan bahwa terapi farmakologis tidak berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan pendekatan nonfarmakologis dan patient-centered care untuk hasil yang lebih optimal (Nicholas et al., 2019).

Pada negara berkembang termasuk Indonesia, manajemen nyeri farmakologis menghadapi tantangan struktural, ketersediaan obat, kebijakan, dan keterbatasan pengetahuan tenaga kesehatan. Nyeri masih sering undertreated, terutama pada pasien kanker, pasien terminal, dan populasi dengan akses terbatas layanan kesehatan. Paracetamol dan NSAID masih menjadi terapi utama yang paling mudah diakses, namun penggunaannya memerlukan peningkatan edukasi terkait keamanan dan risiko jangka panjang, khususnya pada pasien dengan komorbid (WHO, 2018). Adjuvant analgesics seperti antidepresan dan anticonvulsant sudah semakin digunakan di Indonesia, namun masih memerlukan penguatan standar praktik berbasis bukti dan panduan klinik yang lebih jelas. Diperlukan pendekatan yang realistis: memilih terapi yang efektif, cost-effective, tersedia, dan aman sesuai konteks sistem kesehatan (Jodi, 2025). Integrasi pain management dengan pendekatan patient-centered, family involvement, budaya lokal, dan spiritual care sangat relevan dalam konteks Indonesia.

Dalam manajemen nyeri secara farmakologis, yang utama dilakukan adalah pemberian analgesik (obat anti nyeri). Terdapat dua jenis analgesic yakni analgesic opioid dan non-opioid. Analgesik non-opioid merupakan lini pertama untuk manajemen nyeri ringan hingga sedang. Paracetamol banyak digunakan karena profil keamanannya yang baik dan efektif untuk berbagai kondisi nyeri, meskipun efektivitasnya terbatas pada beberapa kondisi kronik tertentu. *Nonsteroidal anti-inflammatory drugs* (NSAID) seperti ibuprofen dan diclofenac efektif dalam nyeri inflamasi dengan pengurangan nyeri yang signifikan, namun penggunaannya harus memperhatikan risiko gastrointestinal, kardiovaskular, dan renal, terutama pada penggunaan jangka Panjang (Bindu et al., 2020). COX-2 inhibitors seperti celecoxib memberikan alternatif yang lebih aman bagi pasien dengan risiko perdarahan gastrointestinal, meskipun tetap harus memperhatikan risiko kardiovaskular. Terlepas dari risiko kardiovaskular dan gastrointestinal dasar setiap pasien, pemantauan pasien disarankan pada status peningkatan tekanan darah,

perkembangan edema, penurunan fungsi ginjal, atau perdarahan gastrointestinal selama pengobatan jangka panjang dengan NSAID. Keputusan klinis harus menyeimbangkan manfaat analgesia dengan risiko jangka panjang, dan dilakukan evaluasi berkala (Fanelli et al., 2017).

Sementara itu, ada juga jenis analgesik opioid. Akses opioid di banyak fasilitas kesehatan Indonesia masih terbatas karena regulasi ketat, ketakutan tenaga kesehatan terhadap risiko adiksi, serta stigma yang kuat. Padahal, opioid sangat penting untuk nyeri kanker dan kondisi nyeri berat lainnya. WHO menegaskan bahwa negara berkembang harus memperkuat kebijakan opioid availability with safety, pelatihan tenaga kesehatan, dan kebijakan yang tidak menghalangi hak pasien untuk bebas dari nyeri (Knaul et al., 2018). Opioid direkomendasikan pada kondisi nyeri sedang hingga berat, terutama nyeri kanker, nyeri akut pascaoperasi, atau kondisi tertentu yang tidak responsif terhadap terapi lain. Namun, penggunaan opioid membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati karena risiko ketergantungan, toleransi, overdosis, dan gangguan fungsi psikososial. Evidence global menunjukkan bahwa penggunaan opioid harus didasarkan pada penilaian klinis komprehensif, tujuan terapi yang jelas, pemantauan ketat, serta pemilihan dosis terendah yang efektif (World Health Organization, 2020). Tantangan besar dalam praktik adalah stigma opioid, baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat, yang sering menyebabkan undertreatment of pain, khususnya pada pasien kanker dan kondisi terminal. Regulasi yang aman menekankan prinsip opioid stewardship, pemantauan risiko, edukasi pasien, serta kebijakan rasional yang tetap memastikan akses bagi pasien yang membutuhkan (Knaul et al., 2018).

Adjuvant analgesics digunakan untuk kondisi nyeri spesifik, terutama neuropatik dan nyeri kronik kompleks. Antidepressant seperti *duloxetine* dan *amitriptyline* efektif pada nyeri neuropatik dan nyeri muskuloskeletal tertentu karena modulasi neurotransmitter nyeri. Antikonvulsan seperti gabapentin dan pregabalin sering direkomendasikan pada neuropathic pain, dengan bukti kuat dalam menurunkan intensitas nyeri dan memperbaiki kualitas hidup (Nicholas et al., 2019). Steroid dapat digunakan pada kondisi nyeri inflamasi berat atau edema kompresi saraf, tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang karena risiko efek samping sistemik. Selain itu, terdapat kelompok obat lain seperti *muscle relaxant*, analgesic topikal, dan NMDA (*N-metil-D-aspartat*) antagonists yang digunakan sesuai indikasi klinik. Penggunaan adjuvan menuntut seleksi berbasis diagnosis dan monitoring ketat agar manfaat melebihi risiko (Vyvey, 2010; Yasir et al., 2023).

Bukti terbaru menegaskan kembali bahwa pendekatan farmakologis terbaik adalah rasional, terukur, dan berbasis bukti. Beberapa organisasi seperti WHO,

IASP, NICE, dan CDC (*Centers for Disease Control*) secara konsisten menyoroti integrasi farmakoterapi dalam pendekatan biopsikososial dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas dan keamanan terapi. Walaupun pedoman analgesic dari WHO tetap menjadi acuan utama, khususnya di negara berkembang, pedoman terkini yang dirilis oleh NICE (*National Institute for Health and Care Excellence*) mengkonfirmasi kriteria diagnostik untuk nyeri kronis primer dengan peringatan tegas untuk berhati-hati terhadap beberapa obat. CDC sudah memperbarui pedoman opioid untuk tahun 2023, mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang daripada pelarangan penggunaan opioid secara ketat, dengan penekanan pada keamanan, kemanusiaan, dan fokus pada kebutuhan pasien dalam penggunaan klinis obat. Secara umum, seluruh pedoman menekankan pada pengambilan keputusan kolaboratif, dokumentasi klinis yang komprehensif, pengobatan yang berfokus pada disabilitas dan kualitas hidup, serta tidak hanya pada penilaian nyeri (Cuomo et al., 2019)(Cuomo et al., 2019; El-Tallawy et al., 2021).

1. Manajemen Nyeri farmakologis fokus pada Cancer Pain

Pada konteks nyeri kanker, terapi farmakologis berbasis bukti didasarkan pada prinsip memastikan kontrol nyeri yang adekuat, kualitas hidup, dan meminimalkan penderitaan pasien. *WHO cancer analgesic ladder* yang menawarkan pedoman penanganan nyeri bertingkat (non-opioid, opioid lemah, opioid kuat) berdasarkan intensitas nyeri saat ini masih menjadi rujukan utama untuk manajemen nyeri kanker, masih menjadi rujukan penting, namun saat ini telah berkembang ke arah *WHO Analgesic Continuum*, yang lebih fleksibel dan menekankan individualisasi terapi. Non-opioid seperti paracetamol dan NSAID tetap dapat digunakan, terutama pada nyeri akibat inflamasi tumor atau metastasis tulang, namun penggunaannya harus memperhatikan risiko gastrointestinal dan renal, terutama pada pasien kanker dengan status terminal (Srikrajang et al., 2024; Yang et al., 2020).

Opioid merupakan komponen utama dalam manajemen nyeri kanker sedang hingga berat. Morfin, fentanyl, oxycodone, hydromorphone, dan methadone direkomendasikan tergantung karakteristik pasien, fungsi ginjal, rute pemberian, dan ketersediaan obat. Tantangan di negara berkembang termasuk keterbatasan akses opioid, kebijakan yang ketat, serta stigma ketergantungan sehingga menyebabkan penanganan nyeri kanker yang tidak optimal. Penggunaan opioid harus disertai prinsip opioid stewardship: penilaian komprehensif, titrasi yang tepat, monitoring sedasi, konstipasi, efek samping

gastrointestinal, dan risiko delirium, terutama pada pasien usia lanjut (Fallon et al., 2018).

Adjuvant analgesics sangat penting pada cancer-related neuropathic pain, misalnya akibat kemoterapi, infiltrasi saraf, atau tumor compression. Anticonvulsant seperti gabapentin dan pregabalin, serta antidepressant seperti duloxetine, terbukti efektif mengurangi neuropathic pain dan meningkatkan kualitas hidup. Kortikosteroid digunakan pada kondisi spesifik seperti *spinal cord compression* atau edema tumor (Shkodra & Caraceni, 2022). Integrasi terapi farmakologis dengan intervensi nonfarmakologis, dukungan psikososial, spiritual care, dan *patient-centered care* menjadi fondasi pendekatan manajemen nyeri kanker yang komprehensif.

2. Manajemen Nyeri farmakologis fokus pada Postoperative Pain (Klinis Bedah & Perawatan Akut)

Pada konteks nyeri post-operasi, prinsip utama dari terapi farmakologis adalah memastikan kontrol nyeri yang adekuat untuk mendukung kondisi umum, mobilisasi dini, fungsi pernapasan, pemulihan, dan mencegah perburukan kondisi menjadi nyeri kronik. Pendekatan multimodal analgesia sangat direkomendasikan, yaitu menggabungkan berbagai agen analgesik dengan mekanisme berbeda untuk meningkatkan efektivitas dan menurunkan kebutuhan opioid. Paracetamol dan NSAID merupakan agen lini pertama untuk sebagian besar prosedur bedah, kecuali terdapat kontraindikasi seperti risiko perdarahan, gangguan ginjal, atau risiko gastrointestinal (Ramtin, 2025).

Opioid tetap berperan dalam nyeri akut berat pascaoperasi, namun direkomendasikan short-term, lowest effective dose, dan dipantau ketat untuk mencegah sedasi berlebihan, depresi napas, dan ketergantungan. Strategi opioid-sparing menjadi rekomendasi terkini dengan mengoptimalkan non-opioid analgesics, regional anesthesia, dan teknik nerve block. Monitoring dilakukan secara berkala melalui pain scale, fungsi mobilisasi, efek samping, serta kepuasan pasien. Jika nyeri berlanjut berkepanjangan, evaluasi risiko nyeri kronis pasca operasi harus dilakukan (IASP, 2020). Terapi analgesik seperti gabapentin dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu untuk mencegah neuropathic component, terutama pada operasi ortopedi atau bedah saraf. Prinsip pemberian resep obat menjadi penting saat pasien memasuki fase pemulihan untuk mencegah penggunaan obat yang tidak lagi diperlukan (Peng et al., 2017). Pendekatan holistik termasuk edukasi pasien, reassurance, dan dukungan psikologis membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan hasil klinis pasca operasi.

D. *Evidence-Based* Manajemen Nyeri Non Farmakologis

Pendekatan non-farmakologis saat ini merupakan metode yang dianggap sangat penting dalam manajemen nyeri modern karena tidak hanya berfokus pada mekanisme fisiologis, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Prinsip multimodal dalam manajemen nyeri menekankan bahwa nyeri merupakan pengalaman kompleks seorang individu yang dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan sosial, sehingga strategi pengelolaannya tidak dapat bergantung pada satu jenis intervensi saja. Integrasi antara terapi non-farmakologis dengan farmakologis ternyata terbukti meningkatkan efektivitas kontrol nyeri, mengurangi kebutuhan opioid, menurunkan risiko efek samping, serta meningkatkan kualitas hidup dan kontrol nyeri pasien (Kartika & Rezkiki, 2025). Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan *patient-centered care* karena memberi ruang bagi preferensi, nilai, dan pengalaman subjektif pasien dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam buku ini akan dibahas intervensi non farmakologis dalam bentuk intervensi psikologis, intervensi secara fisiologis (fisik) dan intervensi komplementer. Berikut penjelasan masing-masing intervensi tersebut:

1. Intervensi Psikologis

Intervensi psikologis memainkan peran penting dalam manajemen nyeri karena komponen emosional dan kognitif sangat mempengaruhi persepsi nyeri. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) merupakan intervensi dengan bukti paling kuat dalam mengurangi nyeri kronik, meningkatkan coping strategy, dan menurunkan distress emosional melalui restrukturisasi pikiran negatif, peningkatan kontrol diri, dan pelatihan regulasi emosi (Paroli & Galdino, 2023; Sturgeon, 2014). Terapi relaksasi termasuk teknik pernapasan, relaksasi otot progresif, dan *relaxation training* terbukti menurunkan ketegangan otot, kecemasan, dan respons stres fisiologis yang berkontribusi pada peningkatan persepsi nyeri (Toussaint et al., 2021).

Mindfulness-based interventions seperti Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) membantu pasien menerima pengalaman nyeri dengan cara yang adaptif, mengurangi catastrophizing, dan meningkatkan kualitas hidup, terutama pada nyeri kronik dan cancer-related pain. *Guided imagery* juga menunjukkan manfaat pada pasien kanker, pasien pascaoperasi, dan kondisi nyeri kronik tertentu dengan membantu relaksasi, distraksi nyeri, dan meningkatkan kenyamanan emosional (Guerra-Martín et al., 2021; Kartika et al., 2022, 2024; Zisopoulou & Varvogli, 2023). Intervensi psikologis ini direkomendasikan dalam panduan secara global sebagai bagian integral dari manajemen nyeri dan bukan hanya sekadar bagian dari terapi komplementer.

2. Intervensi Fisik

Intervensi fisik memberikan kontribusi langsung terhadap perbaikan fungsi tubuh, penurunan nyeri, dan peningkatan mobilitas. Fisioterapi dan latihan fisik sangat direkomendasikan baik untuk nyeri post operasi maupun nyeri kronik, karena meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan sirkulasi, serta mencegah terjadinya immobilization-related pain dan disability. Penelitian menunjukkan bahwa latihan fisik terstruktur dapat memperbaiki fungsi dan menurunkan nyeri secara signifikan pada berbagai kondisi seperti (nyeri punggung bawah), nyeri muskuloskeletal, dan nyeri kanker yang melemahkan pasien (Gassner & Hofer, 2023; I Gusti Ayu Mirah Adhi et al., 2025).

Terapi akupresur atau terapi *massage* dapat membantu mengurangi spasme otot, meningkatkan relaksasi, dan memperbaiki kenyamanan, meskipun efektivitasnya bervariasi tergantung kondisi klinis dan frekuensi tindakan. *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation* (TENS) merupakan intervensi terbukti pada beberapa jenis nyeri, terutama muskuloskeletal pain dan postoperative pain tertentu, meskipun hasil penelitian masih bervariasi namun banyak menunjukkan manfaat dalam menurunkan intensitas nyeri dan kebutuhan analgesik. Intervensi fisik ini memerlukan penilaian individual sesuai kondisi pasien, status fungsional, dan tujuan rehabilitasi, sehingga tetap dalam kerangka evidence-based practice (Lei et al., 2025; Vance et al., 2022).

3. Intervensi Komplementer & Integratif yang Evidence-Based

Intervensi komplementer semakin banyak digunakan dalam praktik klinik, namun tidak semua memiliki bukti ilmiah yang kuat. Acupuncture merupakan salah satu intervensi dengan dukungan evidence yang cukup baik pada beberapa kondisi seperti low back pain, nyeri kronik tertentu, nyeri kanker, dan nyeri post operasi tertentu, dengan mekanisme yang berkaitan dengan stimulasi neuromodulator dan sistem endorfin (I Gusti Ayu Mirah Adhi et al., 2025; Kartika et al., 2022, 2023, 2024; Utami & Kartika, 2018). Yoga dan tai-chi terbukti membantu pada chronic muskuloskeletal pain, cancer survivorship pain, serta meningkatkan kualitas hidup, fleksibilitas, dan kesehatan mental (Ramadhana & Gayatri, 2023; Setiawan et al., 2021). *Aromatherapy* memiliki bukti moderat terutama pada konteks paliatif dan perawatan pendukung untuk membantu relaksasi, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kenyamanan emosional, meskipun efek langsung terhadap intensitas nyeri masih bervariasi (Suyanto & Nugroho, 2023). Prinsip penting dalam penggunaan intervensi komplementer adalah memastikan bahwa intervensi memiliki bukti ilmiah, aman, tidak menggantikan terapi utama, dan dikomunikasikan secara jelas kepada pasien

sebagai bagian dari pengambilan keputusan bersama yang memfasilitasi perawatan berfokus pada pasien (*patient center care*).

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi psikologis, fisik, dan komplementer dapat meningkatkan efektivitas terapi farmakologis, mengurangi ketergantungan opioid, dan memperbaiki outcome klinis termasuk kualitas hidup, fungsi fisik, dan well-being emosional (Norman-Nott et al., 2024). Implementasi praktis menuntut pengkajian holistik, pelatihan tenaga kesehatan, serta sistem layanan yang mendukung integrasi intervensi ini. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, pendekatan non-farmakologis juga memiliki keunggulan karena relatif cost-effective, dapat disesuaikan dengan budaya lokal, melibatkan keluarga, dan selaras dengan pendekatan spiritual care yang sering menjadi bagian penting dalam pengalaman nyeri pasien. Dengan demikian, evidence-based dalam penanganan nyeri non-farmakologis bukan hanya dijadikan terapi pelengkap saja, tetapi juga sebagai komponen esensial dalam kerangka implementasi berbasis pasien (*patient-centered*) dan intervensi holistic dalam penanganan pasien dengan kondisi nyeri.

E. *Patient-Centered* dalam Manajemen Nyeri

Pendekatan *patient-centered care* atau perawatan berfokus pada pasien dalam manajemen nyeri menempatkan pasien sebagai mitra utama dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sekadar sebagai penerima intervensi semata. Pada nyeri kanker dan nyeri pascaoperasi, pengalaman nyeri sangat subjektif, dipengaruhi oleh faktor biologis, emosional, sosial, spiritual, dan budaya. Karena itu, respons terapi tidak hanya dinilai dari penurunan intensitas nyeri, tetapi juga peningkatan fungsi, kualitas hidup, dan kemampuan beradaptasi. Organisasi seperti WHO dan IASP menegaskan bahwa pendekatan yang berorientasi pada pasien merupakan standar emas dalam manajemen nyeri modern, terutama untuk kondisi kronik dan kompleks seperti kanker (IASP, 2020; WHO, 2023). Dalam praktik di negara berkembang, pendekatan ini juga membantu mengatasi hambatan komunikasi, stigma terhadap obat opioid, serta kesenjangan literasi kesehatan.

Shared decision-making (SDM) atau pengambilan keputusan bersama merupakan komponen kunci dalam manajemen nyeri yang berfokus pada *patient-centered care* di mana tenaga kesehatan memberikan informasi yang jelas mengenai pilihan terapi, risiko, manfaat, dan alternatif intervensi, sedangkan pasien akan menyampaikan preferensi, nilai, serta harapan mereka terhadap terapi manajemen nyeri yang dilakukan. Pada pasien kanker, keputusan penggunaan opioid jangka panjang, terapi adjuvan, atau integrasi intervensi non-farmakologis perlu didiskusikan secara terbuka dan etis. Sementara pada pasien pascaoperasi,

SDM membantu menentukan target nyeri yang realistis, rencana mobilisasi, serta kesiapan pasien untuk pulang. Studi menunjukkan bahwa SDM meningkatkan kepuasan, kepatuhan, dan hasil klinis, sekaligus mengurangi kecemasan pasien (Elwyn et al., 2012). Di Indonesia, penerapan SDM juga melibatkan keluarga yang memiliki peran kuat dalam proses pengambilan keputusan.

Edukasi merupakan fondasi keberhasilan manajemen nyeri berbasis pasien. Edukasi yang baik tidak hanya menjelaskan tentang penyebab nyeri dan pilihan terapi, tetapi juga meluruskan mitos, seperti ketakutan berlebihan terhadap ketergantungan opioid atau anggapan bahwa nyeri adalah bagian alami yang harus diterima. Pada pasien kanker, edukasi membantu pasien memahami konsep kontrol nyeri, penggunaan obat secara tepat, pemantauan efek samping, serta strategi koping emosional (Yajnik et al., 2019). Pada pasien pascaoperasi, edukasi tentang analgesia multimodal, teknik pernapasan, mobilisasi dini, dan keamanan penggunaan obat meningkatkan pemulihan dan mengurangi komplikasi. Dalam konteks negara berkembang, edukasi harus disesuaikan dengan tingkat literasi, budaya, dan bahasa yang dipahami pasien serta keluarga.

Pendekatan *patient-centered care* juga menekankan pentingnya self-management, yaitu kemampuan pasien untuk berperan aktif dalam mengelola nyerinya. Pada pasien kanker, dukungan self-management dapat berupa penggunaan teknik relaksasi, mindfulness, pemantauan nyeri mandiri, manajemen kelelahan, dan strategi koping emosional. Pada nyeri pascaoperasi, kemampuan pasien memahami cara menggunakan analgesik secara aman, mengenali tanda bahaya, serta melakukan latihan mobilisasi sesuai anjuran menjadi sangat penting untuk mempercepat pemulihan. Empowerment memberikan rasa kendali pada pasien, meningkatkan kompetensi persepsi diri, dan terbukti meningkatkan kualitas hidup serta kepuasan layanan (Li et al., 2024). Di Indonesia, pemberdayaan pasien juga melibatkan pembekalan keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam manajemen perawatan penyakit pasien.

Dalam manajemen nyeri, baik di keluarga dan masyarakat, terdapat Cultural Sensitivity dengan kata lain budaya yang mempengaruhi. Budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi nyeri, ekspresi nyeri, serta penerimaan terhadap intervensi. Di banyak negara Asia termasuk Indonesia, pasien seringkali menahan ekspresi nyeri karena nilai ketabahan, rasa sungkan, atau persepsi bahwa mengeluh dianggap lemah. Selain itu, kepercayaan terhadap obat herbal, terapi tradisional, dan pendekatan spiritual juga sangat kuat. Oleh karena itu, model manajemen nyeri harus bersifat culturally sensitive, yaitu menghargai nilai budaya pasien namun tetap memastikan intervensi yang diberikan berbasis bukti. Tenaga kesehatan perlu membangun komunikasi empatik, menghargai preferensi pasien,

sekaligus memberikan klarifikasi ilmiah terhadap praktik yang berpotensi berisiko. Pendekatan sensitif budaya terbukti meningkatkan kepercayaan pasien, keterlibatan dalam perawatan, dan hasil klinis (Bernardi et al., 2019; IASP, 2020).

Keberhasilan manajemen nyeri berbasis pasien tidak hanya diukur dari penurunan skor nyeri, tetapi dari outcome yang lebih luas seperti peningkatan kualitas hidup, kepuasan terhadap pelayanan, peningkatan fungsi fisik dan sosial, serta bagaimana pasien memaknai pengalaman nyerinya. Pada pasien kanker, keberhasilan terapi sering tercermin dari kemampuan pasien menjalani aktivitas harian, tidur lebih baik, menurunkan distress emosional, dan mempertahankan martabat hidup (Davies, 2013). Pada pasien pascaoperasi, keberhasilan terlihat dari mobilisasi optimal, pemulihan cepat, penurunan lama rawat, serta pengalaman perawatan yang positif. Model patient-centered care terbukti meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban psikologis pasien (Ferrell et al., 2018). Dengan demikian, integrasi pendekatan ini menjadi esensial dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk di Indonesia.

F. Implementasi di Praktik Klinis

Implementasi manajemen nyeri berbasis bukti di praktik klinis membutuhkan model pelayanan yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Di rumah sakit, pendekatan yang banyak direkomendasikan adalah model manajemen nyeri multidisiplin, yang melibatkan dokter, perawat, fisioterapis, psikolog, farmasis, dan tim paliatif bekerja secara kolaboratif. Proses dimulai dengan skrining nyeri rutin menggunakan alat pengkajian valid (misalnya *Numeric Rating Scale* (NRS), *Visual Analog Scale* (VAS), atau alat penilaian nyeri khusus untuk pasien kanker dan pasien pascaoperasi). Setelah itu, dilakukan penentuan diagnosis, penetapan target terapi, perencanaan intervensi multimodal, monitoring berkala, dan evaluasi hasil. Di komunitas, implementasi dilakukan melalui program continuity of care, edukasi pasien dan keluarga, pendampingan self-management, serta koneksi antara fasilitas primer dengan layanan rujukan. Model pelayanan seperti ini terbukti meningkatkan kontrol nyeri, kualitas hidup, dan efisiensi pelayanan. Perawat berperan penting dalam manajemen nyeri berbasis bukti (Lewthwaite et al., 2011; Orujlu et al., 2023).

Perawat memiliki posisi strategis dalam manajemen nyeri karena berada paling dekat dengan pasien dan menjalankan kontinuitas perawatan. Peran perawat meliputi pengkajian nyeri komprehensif, pemberian intervensi farmakologis sesuai instruksi medis yang aman, penerapan intervensi nonfarmakologis, edukasi pasien dan keluarga, advokasi pasien, serta evaluasi respons terapi. Dalam konteks nyeri kanker dan nyeri post-operasi, perawat

berperan penting dalam memastikan analgesia adekuat, mencegah terapi yang tidak optimal, mengurangi kecemasan pasien, dan mendukung mobilisasi dini. Selain itu, perawat berperan dalam mengintegrasikan pendekatan *patient-centered care* melalui komunikasi empatik, shared decision making, dan pemberdayaan pasien. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi perawat dalam evidence-based pain management berdampak signifikan pada outcome klinis, kepuasan pasien, dan keselamatan terapi (Ferrell et al., 2018).

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi manajemen nyeri berbasis bukti masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap obat analgesik tertentu, terutama opioid, akibat regulasi ketat, stigma ketergantungan, dan ketakutan klinisi terhadap risiko penyalahgunaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, beban kerja tinggi, kurangnya sistem pengkajian nyeri yang konsisten, serta minimnya dukungan kebijakan juga menjadi hambatan signifikan. Faktor budaya turut berperan, misalnya anggapan bahwa nyeri adalah bagian alami dari penyakit atau operasi, sehingga pasien kurang proaktif melaporkan nyeri. Di sisi lain, aspek literasi kesehatan yang rendah membuat edukasi dan self-management belum optimal. Tantangan tersebut membuat kontrol nyeri pasien kanker dan pasien pascaoperasi seringkali masih belum sesuai standar internasional (IASP, 2020; Knaul et al., 2018).

Untuk memastikan implementasi manajemen nyeri ini berjalan efektif, diperlukan strategi multidimensi yang meliputi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan kebijakan, dan pengembangan sistem pelayanan. Dari aspek pendidikan, penting untuk memperkuat kurikulum manajemen nyeri berbasis bukti dalam pendidikan keperawatan dan kedokteran, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga klinis, serta pengembangan kompetensi dalam pengkajian, intervensi, dan evaluasi nyeri. Dari sisi kebijakan, pemerintah dan institusi kesehatan perlu mendukung ketersediaan analgesik yang aman dan terkontrol, kebijakan skrining nyeri serta mekanisme audit kualitas pelayanan nyeri yang optimal. Sementara itu, dari aspek sistem, diperlukan integrasi protokol klinis, guideline berbasis bukti, dokumentasi digital nyeri, serta model pelayanan kolaboratif antara rumah sakit dan komunitas. Jika strategi ini berjalan terpadu, maka kualitas manajemen nyeri, baik pada pasien kanker maupun pascaoperasi, akan meningkat secara signifikan dan lebih sesuai dengan standar global.

G. Simpulan

Manajemen nyeri merupakan komponen yang mendasar dan utama dalam pelayanan kesehatan modern. Hal ini dikatakan demikian karena nyeri pada pasien

atau individu yang sedang sakit, tidak hanya berdampak pada aspek fisiologis, tetapi juga akan memengaruhi kondisi psikologis, sosial, spiritual, serta kualitas hidup mereka. Pada pasien kanker dan pasien post-operasi, nyeri yang tidak tertangani dengan baik dapat menurunkan fungsi, meningkatkan kecemasan dan gangguan emosional, memperpanjang lama rawatan, serta menurunkan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan manajemen nyeri berbasis bukti menjadi sangat penting untuk memastikan intervensi yang diberikan aman, efektif, komprehensif, dan sesuai dengan standar ilmiah terkini. Hal ini akan berdampak pada kualitas hidup dan kepuasan pasien.

Pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis sangat diperlukan dan diintegrasikan dalam kerangka *multimodal pain management*, dengan mempertimbangkan karakteristik pasien, jenis nyeri, kondisi klinis, dan preferensi individu terhadap pilihan manajemen nyeri yang mereka inginkan. Penggunaan analgesik, termasuk opioid, perlu dikelola secara rasional dan aman, sementara intervensi non-farmakologis dan psikososial menjadi bagian penting dalam mendukung adaptasi pasien terhadap nyeri yang dirasakan. Dalam konteks ini, *patient-centered care* memiliki peran sentral yang memunculkan pasien sebagai kontrol utama sebagai pusat pemberian manajemen nyeri yang adekuat dan efektif. Melalui pengambilan keputusan bersama, edukasi kesehatan, pemberdayaan pasien dan keluarga, serta sensitivitas budaya, pelayanan nyeri tidak hanya berfokus pada penurunan skor nyeri, tetapi juga peningkatan fungsi, kualitas hidup, dan makna pengalaman pasien terhadap nyeri.

Namun, implementasi *Evidence-Based Pain Management* masih menghadapi tantangan, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Keterbatasan sumber daya, stigma opioid, variasi kompetensi tenaga kesehatan, dan hambatan budaya masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem melalui pendidikan tenaga kesehatan, dukungan kebijakan, peningkatan akses pelayanan, serta pengembangan model pelayanan kolaboratif di rumah sakit dan komunitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan manajemen nyeri dapat dilaksanakan secara optimal, humanistik, aman, dan berorientasi pada pasien, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup pasien.

H. Referensi

-
- AMA. (2020). Addressing Obstacles to Evidence-Informed Pain Care. *AMA Journal of Ethics*, 22(8), E709-717. <https://doi.org/10.1001/amajethics.2020.709>
- Asthana, R., Goodall, S., Lau, J., Zimmermann, C., Diaz, P. L., Wan, A. B., Chow, E., & De Angelis, C. (2019). Framing of the opioid problem in cancer pain

- management in Canada. *Current Oncology*, 26(3).
<https://doi.org/10.3747/co.26.4517>
- Azizoddin, D. R., Knoerl, R., Adam, R., Kessler, D., Tulsy, J. A., Edwards, R. R., & Enzinger, A. C. (2021). Cancer pain self-management in the context of a national opioid epidemic: Experiences of patients with advanced cancer using opioids. *Cancer*, 127(17). <https://doi.org/10.1002/cncr.33532>
- Barrie, J., & Loughlin, D. (2014). Managing chronic pain in adults. *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987)*, 29(7).
<https://doi.org/10.7748/ns.29.7.50.e9099>
- Bindu, S., Mazumder, S., & Bandyopadhyay, U. (2020). Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and organ damage: A current perspective. *Biochemical Pharmacology*, 180, 114147.
<https://doi.org/10.1016/j.bcp.2020.114147>
- Crombez, G., Veirman, E., Van Ryckeghem, D., Scott, W., & De Paepe, A. (2023). The effect of psychological factors on pain outcomes: lessons learned for the next generation of research. *PAIN Reports*, 8(6), e1112.
<https://doi.org/10.1097/PR9.0000000000001112>
- Cuomo, A., Bimonte, S., Forte, C. A., Botti, G., & Cascella, M. (2019). Multimodal approaches and tailored therapies for pain management: the trolley analgesic model. *Journal of Pain Research, Volume 12*, 711–714.
<https://doi.org/10.2147/JPR.S178910>
- Davies, P. S. (2013). Chronic pain management in the cancer survivor. *The Nurse Practitioner*, 38(6). <https://doi.org/10.1097/01.npr.0000429893.95631.63>
- Edwards, K. A., Merlin, J. S., Webster, F., Mackey, S. C., & Darnall, B. D. (2025). Breaking barriers: addressing opioid stigma in chronic pain and opioid use disorder. *Pain*, 166(6), 1268–1273.
<https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000003475>
- El-Tallawy, S. N., Nalamasu, R., Salem, G. I., LeQuang, J. A. K., Pergolizzi, J. V., & Christo, P. J. (2021). Management of Musculoskeletal Pain: An Update with Emphasis on Chronic Musculoskeletal Pain. *Pain and Therapy*, 10(1), 181–209.
<https://doi.org/10.1007/s40122-021-00235-2>
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., Cording, E., Tomson, D., Dodd, C., Rollnick, S., Edwards, A., & Barry, M. (2012). Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361–1367. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>
- Fallon, M., Giusti, R., Aielli, F., Hoskin, P., Rolke, R., Sharma, M., & Ripamonti, C. I. (2018). Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Annals of Oncology*, 29, iv166–iv191.
<https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152>

- Fanelli, A., Ghisi, D., Aprile, P. L., & Lapi, F. (2017). Cardiovascular and cerebrovascular risk with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and cyclooxygenase 2 inhibitors: latest evidence and clinical implications. *Therapeutic Advances in Drug Safety*, 8(6), 173–182. <https://doi.org/10.1177/2042098617690485>
- Ferrell, B. R., Twaddle, M. L., Melnick, A., & Meier, D. E. (2018). National Consensus Project Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care Guidelines, 4th Edition. In *Journal of Palliative Medicine* (Vol. 21, Issue 12). <https://doi.org/10.1089/jpm.2018.0431>
- Gassner, L., & Hofer, V. (2023). Osteopathy: effectiveness and safety for musculoskeletal pain – a systematic review. *26. Jahrestagung Der Österreichischen Gesellschaft Für Public Health (ÖGPH)*, 85. <https://doi.org/10.1055/s-0043-1773677>
- Gatchel, R. J. (2004). Comorbidity of chronic pain and mental health disorders: The biopsychosocial perspective. In *American Psychologist* (Vol. 59, Issue 8). <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.8.795>
- Gornitzky, A., & Diab, M. (2021). Coping Skills in Children: An Introduction to the Biopsychosocial Model of Pain Control as a Tool to Improve Postoperative Outcomes. *Journal of the Pediatric Orthopaedic Society of North America*, 3(1), 211. <https://doi.org/10.55275/JPOSNA-2021-211>
- Goudet, C., & Marchand, F. (2022). Editorial: Molecular mechanisms of nociception. In *Frontiers in Molecular Neuroscience* (Vol. 15). <https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.1025230>
- Grommi, S., Vaajoki, A., Voutilainen, A., & Kankkunen, P. (2023). Effect of Pain Education Interventions on Registered Nurses' Pain Management: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pain Management Nursing*, 24(4), 456–468. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2023.03.004>
- Guerra-Martín, M. D., Tejedor-Bueno, M. S., & Correa-Casado, M. (2021). Effectiveness of Complementary Therapies in Cancer Patients: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1017. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031017>
- Hashefi, M., Katz, J. D., & Reid, M. C. (2013). Nonpharmacologic, complementary, and alternative interventions for managing chronic pain in older adults. *Clinical Geriatrics*, 21(3).
- I Gusti Ayu Mirah Adhi, Ni Nyoman Santi Tri Ulandari, Suhartiningsih, Nurhayati, & Sri Masdiningsih Utami. (2025). PENGARUH TERAPI CORE STABILITY EXERCISE TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NYERI PADA PASIEN LOW BACK PAIN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GERUNG LOMBOK BARAT. *Prima: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11(1), 108–115. <https://doi.org/10.47506/bk3ar037>
- IASP. (2020). IASP Announces Revised Definition of Pain - IASP. *Pain*.

- Jodi, V. (2025). Improving Palliative Care in Indonesia: Bridging Coverage Gaps and Integrating Spirituality for Comprehensive Healthcare. *Trends in Bioethics*, 2(1), 001–008. <https://doi.org/10.17352/tb.000002>
- Kartika, I. R., & Rezkiki, F. (2025). Pain Management Knowledge and Pain Control: a Cross-Sectional Study among Cancer Patients. *Jurnal Ilmiah Ners Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.22437/jini.v6i1.41134>
- Kartika, I. R., Rezkiki, F., & Febrina, C. (2024). Guided Imagery in COMPACT Application to reduce Pain Level among Children with Cancer. *International Conference on Multidisciplinary Approaches in Health Science*, 2, 227–236.
- Kartika, I. R., Rezkiki, F., & Nugraha, H. (2022). Guided Imagery Pain Assessment, Stimulation and Healing Application (PASHA): Upaya Menurunkan Nyeri Menstruasi pada Remaja. *Jurnal Institut Riset Dan Publikasi Indonesia (IRPI) SENTIMAS: Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Kartika, I. R., Rezkiki, F., & Putri, W. A. (2023). Terapi Guided Imagery Berbasis Aplikasi Pasha (Pain Assessment, Stimulating and Healing Application) Dalam Menurunkan Nyeri Post Operasi. *Human Care Journal*, 8(3), 523–529.
- Katz, N. (2002). The Impact of Pain Management on Quality of Life. *Journal of Pain and Symptom Management*, 24(1), S38–S47. [https://doi.org/10.1016/S0885-3924\(02\)00411-6](https://doi.org/10.1016/S0885-3924(02)00411-6)
- Knaul, F. M., Farmer, P. E., Krakauer, E. L., De Lima, L., Bhadelia, A., Jiang Kwete, X., Arreola-Ornelas, H., Gómez-Dantés, O., Rodriguez, N. M., Alleyne, G. A. O., Connor, S. R., Hunter, D. J., Lohman, D., Radbruch, L., del Rocío Sáenz Madrigal, M., Atun, R., Foley, K. M., Frenk, J., Jamison, D. T., ... Zimmerman, C. (2018). Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—an imperative of universal health coverage: the Lancet Commission report. *The Lancet*, 391(10128), 1391–1454. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32513-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32513-8)
- Lei, T., Peng, Y., Liu, Y., Xie, Y., & Wang, J. (2025). Effectiveness of Non-Pharmacological Interventions for Pain Management After Laparoscopic Cholecystectomy: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. *Journal of Pain Research*, Volume 18, 6933–6946. <https://doi.org/10.2147/JPR.S566145>
- Lewthwaite, B. J., Jabusch, K. M., Wheeler, B. J., Schnell-Hoehn, K. N., Mills, J., Estrella-Holder, E., & Fedorowicz, A. (2011). Nurses' knowledge and attitudes regarding pain management in hospitalized adults. *Journal of Continuing Education in Nursing*, 42(6). <https://doi.org/10.3928/00220124-20110103-03>
- Li, Y., Chen, Y. Y., Wang, S. X., Dai, Z. Y., Cui, J. S., Xing, Y. F., Wu, Q., & Fang, Q. (2024). Empowerment-Led Guided Self-Help Intervention for Symptom Burden in Breast Cancer Women Treated With Ovarian Function Suppression: A Randomized Trial Protocol. *World Journal of Oncology*, 15(2), 325–336.

<https://doi.org/10.14740/wjon1817>

- Mills, S., Torrance, N., & Smith, B. H. (2016). Identification and Management of Chronic Pain in Primary Care: a Review. *Current Psychiatry Reports*, 18(2), 22. <https://doi.org/10.1007/s11920-015-0659-9>
- Nicholas, M., Vlaeyen, J. W. S., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Benoliel, R., Cohen, M., Evers, S., Giamberardino, M. A., Goebel, A., Korwisi, B., Perrot, S., Svensson, P., Wang, S.-J., & Treede, R.-D. (2019). The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic primary pain. *Pain*, 160(1), 28–37. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001390>
- Norman-Nott, N., Cashin, A. G., & Gustin, S. M. (2024). Chapter Thirteen - Psychological, physical and complementary therapies for the management of neuropathic pain. In J. Rosner & P. B. T.-I. R. of N. Karlsson (Eds.), *Neuropathic Pain* (Vol. 179, pp. 431–470). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/bs.irn.2024.10.010>
- Orujlu, S., Hassankhani, H., Rahmani, A., Sanaat, Z., Dadashzadeh, A., & Allahbakhshian, A. (2023). Pain Self-management Strategies in Patients with Cancer: A Qualitative Study. *Holistic Nursing Practice*, 37(2). <https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000571>
- Paroli, M., & Galdino, G. (2023). Editorial: Psychological therapies for the management of chronic pain. *Frontiers in Pain Research*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpain.2023.1219971>
- Peng, C., Li, C., Qu, J., & Wu, D. (2017). Gabapentin can decrease acute pain and morphine consumption in spinal surgery patients. *Medicine*, 96(15), e6463. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000006463>
- Rahmat Santoso, B., Kurniya, S., Hidyah.Andi, N., Indah Puspita Sari, L., Kharisma Ningtias, P., & Faturrahman, W. (2025). Edukasi Dan Implementasi Manajemen Nyeri: Terapi Non Farmakologi Aromaterapi Di RSUD Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Ramadhana, A., & Gayatri, D. (2023). Intervensi Latihan Tai-Chi pada Pasien Kanker yang Mengalami Fatigue. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2), 1447–1458. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i2.5675>
- Ramtin, S. (2025). Oral Multi-Modal Agents for Post-Operative Pain Management: A Current Concept. *SurgiColl*, 3(3). <https://doi.org/10.58616/001c.130902>
- Setiawan, H., Nantia Khaerunnisa, R., Ariyanto, H., Fitriani, A., Anisa Firdaus, F., & Nugraha, D. (2021). Yoga Meningkatkan Kualitas Hidup Pada Pasien Kanker: Literature Review. *Journal of Holistic Nursing Science*, 8(1), 75–88. <https://doi.org/10.31603/nursing.v8i1.3848>
- Shetty, A., Elneil, S., Delanerolle, G., Baskaran, A., Shi, J. qing, & Litchfield, I. (2025). *A Policy Brief; An Evidence-Based Approach in Pain Medicine*.

<https://doi.org/10.20944/preprints202507.0175.v1>

- Shkodra, M., & Caraceni, A. (2022). Treatment of Neuropathic Pain Directly Due to Cancer: An Update. *Cancers*, 14(8), 1992. <https://doi.org/10.3390/cancers14081992>
- Srikrajang, S., Komolsuradej, N., Chaovalit, S., & Chuaychoosakoon, C. (2024). Effects of the WHO analgesic ladder on pain severity, pain interference, and blood pressure control in hypertensive patients with chronic musculoskeletal pain: A cross-sectional study. *Primary Health Care Research and Development*, 25. <https://doi.org/10.1017/S1463423624000367>
- Sturgeon, J. A. (2014). Psychological therapies for the management of chronic pain. In *Psychology Research and Behavior Management* (Vol. 7). <https://doi.org/10.2147/PRBM.S44762>
- Suyanto, S., & Nugroho, R. K. (2023). Meta-Analisis Efektivitas Relaksasi Aromaterapi dalam Mengurangi Rasa Nyeri. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(3). <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i3.1700>
- Toussaint, L., Nguyen, Q. A., Roettger, C., Dixon, K., Offenbächer, M., Kohls, N., Hirsch, J., & Sirois, F. (2021). Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation, Deep Breathing, and Guided Imagery in Promoting Psychological and Physiological States of Relaxation. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2021, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2021/5924040>
- Treede, R.-D., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Bennett, M. I., Benoliel, R., Cohen, M., Evers, S., Finnerup, N. B., First, M. B., Giamberardino, M. A., Kaasa, S., Korwisi, B., Kosek, E., Lavand'homme, P., Nicholas, M., Perrot, S., Scholz, J., Schug, S., ... Wang, S.-J. (2019). Chronic pain as a symptom or a disease: the IASP Classification of Chronic Pain for the International Classification of Diseases (ICD-11). *Pain*, 160(1), 19–27. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001384>
- Utami, A. D., & Kartika, I. R. (2018). Terapi Komplementer Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Gastritis: A Literatur Review. *REAL in Nursing Journal*, 1(3), 123. <https://doi.org/10.32883/rnj.v1i3.341>
- Vance, C. G. T., Dailey, D. L., Chimenti, R. L., Van Gorp, B. J., Crofford, L. J., & Sluka, K. A. (2022). Using TENS for Pain Control: Update on the State of the Evidence. *Medicina*, 58(10), 1332. <https://doi.org/10.3390/medicina58101332>
- Vyvey, M. (2010). Steroids as pain relief adjuvants. *Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien*, 56(12).
- WHO, W. H. O. (2018). WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. In *World Health Organization*.
- World Health Organization. (2018). WHO guidelines for the pharmacological and

radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. In *World Health Organization*.

World Health Organization. (2020). WHO Cancer Regional Profile 2020. *International Agency for Research on Cancer, 2019*.

Yajnik, M., Hill, J. N., Hunter, O. O., Howard, S. K., Kim, T. E., Harrison, T. K., & Mariano, E. R. (2019). Patient education and engagement in postoperative pain management decreases opioid use following knee replacement surgery. *Patient Education and Counseling, 102*(2), 383–387. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.09.001>

Yang, J., Bauer, B. A., Wahner-Roedler, D. L., Chon, T. Y., & Xiao, L. (2020). The modified WHO analgesic ladder: Is it appropriate for chronic non-cancer pain? *Journal of Pain Research, 13*. <https://doi.org/10.2147/JPR.S244173>

Yasir, M., Goyal, A., & Sonthalia, S. (2023). Corticosteroid Adverse Effects. In *Statpearls*.

Zendrato, W. (2020). Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development, 8*(2), 242–248.

Zisopoulou, T., & Varvogli, L. (2023). Stress Management Methods in Children and Adolescents: Past, Present, and Future. In *Hormone Research in Paediatrics* (Vol. 96, Issue 1). <https://doi.org/10.1159/000526946>

I. Glosarium

AMA	: American Medical Association
CBT	: Cognitive Behavioral Therapy
CDC	: Centers for Disease Control
COX-2	: Cyclooxygenase-2
EBP	: Evidence Based Parctice
IASP	: International Association for the Study of Pain
NICE	: National Institute for Health and Care Excellence
NMDA	: N-metil-D-aspartat
NRS	: Numeric Rating Scale
NSAID	: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
PCC	: Patient Cantered Care
SDM	: Shared decision-making
TENS	: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
VAS	: Visual Analog Scale
WH	: World Health Organization

CHAPTER 3

PRAKTIK KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS (DM, HIPERTENSI, PPOK, GAGAL JANTUNG)

Ns. Asri Bashir, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Penyakit kronis merupakan tantangan utama dalam sistem pelayanan kesehatan global pada dekade terakhir. Penyakit tidak menular seperti Diabetes Mellitus (DM), hipertensi, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), dan gagal jantung berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka kesakitan, kematian, serta beban pembiayaan kesehatan jangka panjang. Kondisi ini menegaskan bahwa penyakit kronis tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah kesehatan individu semata, melainkan sebagai isu kesehatan masyarakat yang berdampak luas terhadap keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks kebutuhan perawatan jangka panjang dan peningkatan tuntutan terhadap sistem pelayanan keperawatan (Lorig et al., 2023).

Penyakit kronis dicirikan oleh perjalanan penyakit yang berlangsung lama, sering bersifat progresif, dan membutuhkan pengelolaan berkelanjutan sepanjang hidup pasien. Berbeda dengan penyakit akut yang berorientasi pada penyembuhan jangka pendek, penyakit kronis menuntut pendekatan perawatan jangka panjang yang terintegrasi, berfokus pada pengendalian gejala, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas hidup pasien. Ketidaksiapan sistem pelayanan kesehatan dalam merespons kebutuhan perawatan jangka panjang ini berpotensi meningkatkan angka rawat ulang dan memperburuk luaran kesehatan pasien (Nock et al., 2023).

Peningkatan prevalensi penyakit kronis berkaitan erat dengan perubahan gaya hidup modern, penuaan populasi, serta tingginya paparan faktor risiko perilaku seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Dampak penyakit kronis bersifat multidimensional, meliputi penurunan fungsi fisik, gangguan psikologis, keterbatasan peran sosial, serta beban ekonomi jangka panjang yang signifikan bagi pasien dan keluarga (Megari, 2024).

Dalam konteks tersebut, praktik keperawatan memegang peran yang semakin strategis dalam manajemen penyakit kronis. Perawat merupakan tenaga

kesehatan yang memiliki interaksi paling intens dan berkesinambungan dengan pasien, sehingga berperan penting dalam memfasilitasi perubahan perilaku kesehatan dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan penyakit jangka panjang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang terstruktur dan berkelanjutan mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, kemampuan self-management, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Arooj et al., 2025; Molina-Gil et al., 2024).

Pendekatan keperawatan pada penyakit kronis menuntut pergeseran paradigma dari perawatan yang berorientasi pada kondisi akut menuju perawatan berkelanjutan yang berpusat pada pasien. Dalam pendekatan ini, perawat berperan sebagai koordinator edukasi kesehatan, pemantau kondisi pasien, serta penghubung antara pasien, keluarga, dan tim interprofesional. Implementasi peran tersebut terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kontinuitas asuhan pada pasien dengan kondisi kronis kompleks (Kilfoy et al., 2025).

Selain aspek klinis, penyakit kronis juga menimbulkan dampak psikososial yang signifikan. Pasien sering mengalami stres emosional, kecemasan, serta kesulitan beradaptasi dengan perubahan peran sosial dan keterbatasan fungsional. Dalam hal ini, perawat berperan penting dalam memberikan dukungan psikososial, komunikasi terapeutik, serta edukasi yang berkesinambungan guna membantu pasien beradaptasi dan mempertahankan kualitas hidup yang optimal (Ahmed & Ahmad, 2024).

Berdasarkan kompleksitas tersebut, praktik keperawatan pada pasien dengan penyakit kronis memerlukan pendekatan holistik, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah terkini. Bab ini selanjutnya akan membahas praktik keperawatan pada pasien dengan Diabetes Mellitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung dengan menekankan peran perawat dalam proses keperawatan, edukasi kesehatan, pemberdayaan pasien, serta kolaborasi interprofesional.

B. Konsep Dasar Penyakit Kronis

Penyakit kronis didefinisikan sebagai kondisi kesehatan yang berlangsung dalam jangka waktu lama, sering bersifat progresif, dan memerlukan pengelolaan berkelanjutan sepanjang hidup pasien. Berbeda dengan penyakit akut yang umumnya bersifat self-limiting atau dapat disembuhkan dalam waktu relatif singkat, penyakit kronis menuntut pendekatan pengendalian penyakit yang berfokus pada stabilisasi kondisi, pencegahan komplikasi, dan pemeliharaan kualitas hidup pasien (Bernell et al., 2023).

Secara epidemiologis, penyakit kronis didominasi oleh penyakit tidak menular yang berkembang seiring dengan transisi demografi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern. Diabetes Mellitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung merupakan contoh utama penyakit kronis dengan prevalensi tinggi dan kontribusi signifikan terhadap beban morbiditas global. Peningkatan angka kejadian penyakit-penyakit ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan tekanan besar terhadap sistem pelayanan kesehatan akibat meningkatnya kebutuhan perawatan jangka panjang dan pembiayaan kesehatan (Megari, 2024).

Karakteristik utama penyakit kronis meliputi perjalanan penyakit yang panjang, fluktuasi kondisi klinis, serta potensi terjadinya eksaserbasi dan komplikasi. Pasien sering mengalami keterbatasan fungsi fisik, ketergantungan terhadap terapi jangka panjang, serta kebutuhan pemantauan kesehatan secara terus-menerus. Kondisi ini menjadikan penyakit kronis sebagai masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional dalam pengelolaannya (Nock et al., 2023).

Selain dampak fisik, penyakit kronis juga memiliki implikasi psikologis dan sosial yang signifikan. Pasien dengan penyakit kronis berisiko mengalami stres emosional, kecemasan, depresi, serta perubahan peran sosial dan ekonomi. Dampak psikososial ini sering kali memengaruhi kemampuan pasien dalam mengelola penyakitnya secara efektif dan beradaptasi dengan perubahan kondisi kesehatan yang dialami (Richard et al., 2024).

Penyakit kronis juga berkaitan erat dengan konsep perawatan jangka panjang dan self-management. Pasien dituntut untuk berperan aktif dalam pengelolaan kesehatannya melalui kepatuhan terhadap terapi, pengaturan gaya hidup, serta pengambilan keputusan sehari-hari terkait kesehatan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap konsep dasar penyakit kronis menjadi fondasi penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam merancang intervensi yang tepat dan berkelanjutan (Lorig et al., 2023).

Dengan memahami konsep dasar penyakit kronis secara komprehensif, perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien secara lebih holistik serta merencanakan asuhan keperawatan yang sesuai dengan karakteristik dan perjalanan penyakit kronis. Pemahaman ini menjadi landasan utama dalam pengembangan praktik keperawatan yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien penyakit kronis.

C. Peran dan Fungsi Perawat dalam Asuhan Pasien Penyakit Kronis

Perawat memiliki peran sentral dalam pengelolaan pasien dengan penyakit kronis karena keterlibatannya yang berkesinambungan sepanjang perjalanan penyakit. Penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung menuntut asuhan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada stabilisasi kondisi klinis, tetapi juga pada adaptasi pasien terhadap perubahan status kesehatan, gaya hidup, dan peran sosial. Dalam konteks ini, perawat berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang memastikan kesinambungan asuhan serta menjembatani kebutuhan klinis dan psikososial pasien (Reed et al., 2023).

Salah satu peran utama perawat pada pasien penyakit kronis adalah sebagai care provider, yaitu pemberi asuhan keperawatan langsung berdasarkan proses keperawatan yang sistematis. Perawat melakukan pengkajian komprehensif terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien, mengidentifikasi masalah keperawatan, merencanakan serta melaksanakan intervensi, dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap perburukan kondisi, pencegahan komplikasi, serta optimalisasi pengelolaan penyakit kronis (Nock et al., 2023).

Selain sebagai pemberi asuhan, perawat juga berperan sebagai educator dalam meningkatkan literasi kesehatan pasien dan keluarga. Penyakit kronis menuntut pemahaman yang baik mengenai penyakit, terapi, serta perubahan gaya hidup yang harus dijalani dalam jangka panjang. Edukasi yang diberikan perawat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pengobatan, kemampuan self-management, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh pasien dalam kehidupan sehari-hari (Lorig et al., 2023).

Peran perawat sebagai advocate juga menjadi sangat penting dalam perawatan pasien penyakit kronis. Perawat bertugas melindungi hak pasien, memastikan pasien memperoleh informasi yang memadai, serta membantu pasien menyuarakan kebutuhan dan preferensinya dalam pengambilan keputusan klinis. Dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks, peran advokasi perawat membantu mencegah terjadinya kesenjangan pelayanan dan meningkatkan keselamatan pasien (Richard et al., 2024).

Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, perawat juga menjalankan fungsi sebagai koordinator dan kolaborator interprofesional. Pasien penyakit kronis sering memerlukan keterlibatan berbagai tenaga kesehatan, seperti dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan pekerja sosial. Perawat berperan mengoordinasikan asuhan lintas profesi agar rencana perawatan berjalan terintegrasi dan berkesinambungan. Kolaborasi interprofesional yang efektif terbukti

meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi sistem kesehatan pada pengelolaan penyakit kronis (Molina-Gil et al., 2024).

Dengan demikian, peran dan fungsi perawat dalam asuhan pasien penyakit kronis bersifat multidimensional dan strategis. Perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana tindakan keperawatan, tetapi juga sebagai pendidik, advokat, serta koordinator asuhan yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup pasien dan keberhasilan pengelolaan penyakit kronis jangka panjang.

D. Proses Keperawatan pada Pasien Penyakit Kronis

Proses keperawatan merupakan pendekatan sistematis dan ilmiah yang menjadi fondasi utama praktik keperawatan profesional dalam memberikan asuhan kepada pasien dengan penyakit kronis. Penyakit kronis, seperti Diabetes Mellitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung, memiliki karakteristik perjalanan penyakit yang panjang, bersifat progresif, dan sering kali tidak dapat disembuhkan secara total. Oleh karena itu, tujuan utama proses keperawatan pada kondisi ini bukan hanya berfokus pada penyembuhan, tetapi lebih pada pengendalian penyakit, pencegahan komplikasi, peningkatan fungsi, serta pemeliharaan kualitas hidup pasien dalam jangka panjang (Alligood, 2023). Proses keperawatan memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan unik setiap individu.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, proses keperawatan pada penyakit kronis juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan pendekatan patient-centered care dan evidence-based practice. Perawat dituntut untuk tidak hanya mengandalkan pengalaman klinis, tetapi juga mengaplikasikan hasil penelitian mutakhir dalam setiap tahap proses keperawatan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan konsistensi asuhan, keselamatan pasien, serta efektivitas intervensi keperawatan dalam mengelola kondisi kronis yang kompleks (Kleinpell et al., 2024).

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan pada pasien penyakit kronis merupakan proses komprehensif yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu waktu tertentu. Pengkajian mencakup aspek fisik seperti tanda dan gejala penyakit, status hemodinamik, fungsi organ, serta hasil pemeriksaan penunjang. Namun demikian, pengkajian pada penyakit kronis harus melampaui dimensi biologis dengan menggali aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien, karena faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi kemampuan pasien dalam mengelola penyakitnya (Herdman & Kamitsuru, 2023).

Selain itu, perawat perlu mengkaji tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit yang dideritanya, kepatuhan terhadap terapi farmakologis dan nonfarmakologis, serta pola hidup sehari-hari seperti aktivitas fisik, pola makan, manajemen stres, dan kebiasaan merokok. Pengkajian terhadap kemampuan self-care dan self-management menjadi sangat penting karena keberhasilan pengelolaan penyakit kronis sangat bergantung pada keterlibatan aktif pasien dalam perawatan dirinya sendiri (Kleinpell et al., 2024). Pengkajian yang menyeluruh akan membantu perawat mengidentifikasi masalah aktual maupun potensial secara lebih akurat.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan keputusan klinis perawat mengenai respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual maupun risiko yang mungkin muncul. Pada pasien penyakit kronis, diagnosis keperawatan sering kali bersifat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi kehidupan pasien. Diagnosis tidak hanya mencerminkan gangguan fisiologis, tetapi juga mencakup masalah psikososial, emosional, dan perilaku yang muncul sebagai dampak dari penyakit jangka panjang (Herdman & Kamitsuru, 2023).

Diagnosis keperawatan yang sering ditemukan pada pasien penyakit kronis antara lain ketidakefektifan manajemen kesehatan, intoleransi aktivitas, risiko ketidakstabilan kondisi fisiologis, gangguan coping individu, serta kecemasan terkait kondisi kesehatan. Penetapan diagnosis yang tepat sangat penting karena menjadi dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan yang terarah dan individual. Dalam praktik klinis, diagnosis keperawatan pada penyakit kronis bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan penyakit, respons terhadap terapi, serta perubahan kondisi psikososial pasien.

3. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan pada pasien penyakit kronis bertujuan untuk menetapkan tujuan asuhan yang realistis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Berbeda dengan penyakit akut yang memiliki target pemulihan cepat, perencanaan pada penyakit kronis lebih menekankan pada stabilisasi kondisi, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kemandirian pasien dalam mengelola penyakitnya (Moorhead et al., 2024). Tujuan keperawatan dirumuskan bersama pasien dan keluarga untuk memastikan kesesuaian dengan nilai, preferensi, dan kemampuan pasien.

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan diagnosis yang telah ditetapkan serta mengacu pada klasifikasi intervensi keperawatan yang berbasis

bukti. Perencanaan yang baik juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik di tingkat individu, keluarga, maupun sistem pelayanan kesehatan. Dengan perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif, perawat dapat memfasilitasi keterlibatan aktif pasien dalam proses perawatan serta meningkatkan keberhasilan pengelolaan penyakit kronis.

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan tahap pelaksanaan dari rencana asuhan yang telah disusun. Pada pasien penyakit kronis, implementasi mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti tindakan terapeutik, pemantauan kondisi klinis, edukasi kesehatan, serta dukungan emosional dan psikososial. Perawat berperan penting dalam memastikan bahwa intervensi yang diberikan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Bulechek et al., 2023).

Edukasi kesehatan menjadi komponen utama dalam implementasi keperawatan penyakit kronis, karena pasien diharapkan mampu melakukan manajemen penyakit secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perawat juga berfungsi sebagai koordinator pelayanan dengan memfasilitasi komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Implementasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan terapi, menurunkan angka rawat inap berulang, serta memperbaiki luaran kesehatan jangka panjang.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan merupakan proses penilaian sistematis terhadap pencapaian tujuan asuhan keperawatan yang telah ditetapkan. Pada penyakit kronis, evaluasi dilakukan secara kontinu untuk memantau perkembangan kondisi pasien, efektivitas intervensi, serta kemampuan pasien dalam mengelola penyakitnya (Moorhead et al., 2024). Evaluasi tidak hanya berfokus pada parameter klinis, tetapi juga pada aspek kualitas hidup, tingkat kemandirian, dan kesejahteraan psikososial pasien.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan, memodifikasi, atau menyusun ulang rencana asuhan keperawatan. Proses evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasien. Dengan demikian, proses keperawatan pada penyakit kronis menjadi suatu siklus dinamis yang mendukung kesinambungan asuhan dan peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.

E. Praktik Keperawatan pada Pasien Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi tertinggi di dunia dan menjadi tantangan utama dalam praktik keperawatan modern. DM ditandai oleh gangguan metabolik kronis yang menyebabkan hiperglikemia akibat defisiensi sekresi insulin, resistensi insulin, atau kombinasi keduanya. Kondisi hiperglikemia kronis yang tidak terkontrol berkontribusi terhadap berbagai komplikasi jangka panjang, baik mikrovaskular maupun makrovaskular, yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup pasien dan meningkatkan angka morbiditas serta mortalitas (Davies et al., 2023). Oleh karena itu, praktik keperawatan pada pasien DM memegang peranan sentral dalam pengelolaan penyakit secara komprehensif dan berkelanjutan.

Praktik keperawatan pada DM tidak hanya berfokus pada pengendalian kadar glukosa darah, tetapi juga mencakup pencegahan komplikasi, peningkatan kemampuan self-management, serta dukungan psikososial bagi pasien dan keluarga. Perawat berperan sebagai pendamping jangka panjang yang membantu pasien memahami penyakitnya, menyesuaikan gaya hidup, serta mengelola terapi secara konsisten. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa keterlibatan aktif perawat dalam manajemen DM berhubungan dengan perbaikan kontrol glikemik, penurunan risiko komplikasi, dan peningkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Powers et al., 2024).

1. Pengkajian Keperawatan pada Pasien Diabetes Mellitus

Pengkajian keperawatan pada pasien DM dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mengidentifikasi kondisi klinis, faktor risiko, serta kebutuhan individual pasien. Pengkajian mencakup evaluasi status glikemik melalui pemantauan kadar glukosa darah puasa, glukosa postprandial, dan HbA1c, serta pengkajian tanda dan gejala hiperglikemia maupun hipoglikemia. Selain itu, perawat juga perlu mengkaji adanya komplikasi akut dan kronis, seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit kardiovaskular, serta gangguan integritas kulit (American Diabetes Association, 2024).

Aspek psikososial dan perilaku kesehatan juga menjadi bagian penting dalam pengkajian pasien DM. Perawat perlu menilai tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit dan terapinya, kepatuhan terhadap pengobatan, pola makan, aktivitas fisik, serta kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri. Faktor emosional seperti stres, kecemasan, dan kelelahan akibat penyakit kronis (diabetes distress) sering kali memengaruhi keberhasilan pengelolaan DM dan perlu diidentifikasi sejak dini (Young-Hyman et al., 2023).

2. Diagnosis Keperawatan pada Pasien Diabetes Mellitus

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menetapkan diagnosis keperawatan yang mencerminkan respons pasien terhadap kondisi DM dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Diagnosis keperawatan yang umum ditemukan pada pasien DM meliputi ketidakseimbangan kadar glukosa darah, risiko infeksi, gangguan integritas kulit, ketidakefektifan manajemen kesehatan, serta risiko komplikasi vaskular. Diagnosis ini tidak bersifat statis dan dapat berubah seiring perkembangan penyakit dan respons pasien terhadap terapi (Herdman & Kamitsuru, 2023).

Selain diagnosis yang berfokus pada aspek fisiologis, diagnosis psikososial seperti ansietas, gangguan citra tubuh, dan gangguan coping juga sering muncul pada pasien DM. Perawat perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menyusun asuhan keperawatan yang holistik. Penetapan diagnosis yang tepat menjadi dasar penting dalam merancang intervensi keperawatan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan individu pasien.

3. Perencanaan dan Intervensi Keperawatan

Perencanaan keperawatan pada pasien DM bertujuan untuk mencapai kontrol glikemik optimal, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola penyakitnya secara mandiri. Tujuan keperawatan dirumuskan secara realistis dan kolaboratif dengan melibatkan pasien dan keluarga. Intervensi keperawatan mencakup pemantauan kadar glukosa darah secara teratur, edukasi mengenai penggunaan obat antidiabetik dan insulin, serta bimbingan dalam penerapan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang sesuai (Davies et al., 2023).

Edukasi terapeutik merupakan intervensi kunci dalam praktik keperawatan DM. Perawat berperan dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai penyakit, terapi, serta tanda dan gejala komplikasi. Edukasi yang berkelanjutan terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan mendorong perubahan perilaku kesehatan jangka panjang. Selain itu, perawat juga berperan dalam memfasilitasi penggunaan teknologi kesehatan, seperti pemantauan glukosa darah mandiri dan aplikasi digital, yang semakin banyak digunakan dalam manajemen DM modern (Powers et al., 2024).

4. Pencegahan Komplikasi dan Dukungan Psikososial

Pencegahan komplikasi merupakan fokus utama dalam praktik keperawatan pada pasien DM. Perawat berperan aktif dalam melakukan skrining dini terhadap komplikasi kronis, memberikan edukasi perawatan kaki, serta

mendorong kontrol faktor risiko kardiovaskular seperti hipertensi dan dislipidemia. Intervensi ini bertujuan untuk menurunkan risiko amputasi, penyakit jantung, dan komplikasi serius lainnya yang sering dialami pasien DM (American Diabetes Association, 2024).

Selain aspek fisik, perawat juga memberikan dukungan psikososial untuk membantu pasien menghadapi tantangan emosional akibat penyakit kronis. Dukungan ini meliputi komunikasi terapeutik, konseling kesehatan, serta fasilitasi kelompok dukungan sebaya. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keperawatan yang memperhatikan aspek emosional dan sosial pasien berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan keberhasilan pengelolaan DM jangka panjang (Young-Hyman et al., 2023).

F. Praktik Keperawatan pada Pasien Hipertensi

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis paling umum dan menjadi faktor risiko utama terjadinya penyakit kardiovaskular, stroke, gagal ginjal, serta kematian dini. Kondisi ini sering disebut sebagai *silent killer* karena pada banyak kasus tidak menimbulkan gejala yang jelas, namun secara progresif menyebabkan kerusakan organ target. Tingginya prevalensi hipertensi secara global menjadikan kondisi ini sebagai prioritas utama dalam praktik keperawatan, khususnya dalam upaya pencegahan komplikasi jangka panjang dan pengendalian faktor risiko (Mills et al., 2023).

Praktik keperawatan pada pasien hipertensi menekankan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pengendalian tekanan darah, modifikasi gaya hidup, serta peningkatan kepatuhan terhadap terapi. Perawat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini hipertensi, memantau respons pasien terhadap pengobatan, serta memberikan edukasi berkelanjutan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang terstruktur mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan serta mengurangi risiko kejadian kardiovaskular (Burnier et al., 2024).

1. Pengkajian Keperawatan pada Pasien Hipertensi

Pengkajian keperawatan pada pasien hipertensi dilakukan secara komprehensif dengan menilai tekanan darah secara akurat dan berulang, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pemantauan mandiri di rumah. Selain pengukuran tekanan darah, perawat perlu mengkaji faktor risiko yang berkontribusi terhadap hipertensi, seperti riwayat keluarga, obesitas, pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, stres, serta kebiasaan merokok dan

konsumsi alkohol. Pengkajian ini penting untuk menentukan tingkat risiko kardiovaskular pasien secara keseluruhan (Williams et al., 2023).

Aspek klinis lain yang perlu dikaji meliputi adanya tanda dan gejala kerusakan organ target, seperti sakit kepala persisten, gangguan penglihatan, nyeri dada, atau penurunan fungsi ginjal. Selain itu, perawat juga perlu menilai kepatuhan pasien terhadap terapi farmakologis, pemahaman pasien mengenai penyakit hipertensi, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalani pengobatan jangka panjang. Pendekatan pengkajian yang holistik memungkinkan perawat merancang intervensi yang lebih individual dan efektif.

2. Diagnosis Keperawatan pada Pasien Hipertensi

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menetapkan diagnosis keperawatan yang mencerminkan respons pasien terhadap kondisi hipertensi. Diagnosis yang sering muncul antara lain ketidakefektifan manajemen kesehatan, risiko perfusi jaringan tidak efektif, risiko komplikasi kardiovaskular, serta ketidakpatuhan terhadap regimen terapeutik. Diagnosis ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan yang terarah dan berkelanjutan (Herdman & Kamitsuru, 2023).

Selain diagnosis fisiologis, aspek psikososial juga perlu diperhatikan. Pasien hipertensi sering mengalami stres kronis, kecemasan terkait risiko penyakit jantung, serta kelelahan dalam menjalani terapi jangka panjang. Diagnosis seperti ansietas atau koping individu tidak efektif dapat muncul dan memerlukan intervensi keperawatan yang tepat. Pendekatan ini menegaskan pentingnya peran perawat dalam memberikan asuhan yang holistik dan berpusat pada pasien.

3. Intervensi Keperawatan dan Pengendalian Tekanan Darah

Intervensi keperawatan pada pasien hipertensi berfokus pada pengendalian tekanan darah melalui kombinasi terapi farmakologis dan nonfarmakologis. Perawat berperan dalam memantau efektivitas obat antihipertensi, mengidentifikasi efek samping, serta memastikan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Edukasi mengenai waktu minum obat, dosis, dan pentingnya terapi jangka panjang menjadi bagian penting dari praktik keperawatan (Burnier et al., 2024).

Intervensi nonfarmakologis mencakup edukasi modifikasi gaya hidup, seperti penerapan diet rendah garam, peningkatan aktivitas fisik, pengendalian berat badan, serta manajemen stres. Perawat berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku dengan memberikan bimbingan yang realistis dan sesuai

dengan kondisi pasien. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keperawatan berbasis edukasi gaya hidup secara konsisten mampu meningkatkan kontrol tekanan darah dan kualitas hidup pasien hipertensi (Mills et al., 2023).

4. Pencegahan Komplikasi dan Tindak Lanjut Jangka Panjang

Pencegahan komplikasi merupakan fokus utama dalam praktik keperawatan pada pasien hipertensi. Perawat berperan dalam memantau tanda-tanda awal komplikasi kardiovaskular, serebrovaskular, dan ginjal, serta mendorong pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Tindak lanjut jangka panjang yang terstruktur, termasuk pemantauan tekanan darah dan evaluasi kepatuhan terapi, terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian stroke dan penyakit jantung koroner (Williams et al., 2023).

Selain itu, perawat juga berperan dalam memberdayakan pasien dan keluarga agar terlibat aktif dalam pengelolaan hipertensi. Dukungan keluarga terbukti meningkatkan kepatuhan terapi dan keberhasilan modifikasi gaya hidup. Dengan pendekatan keperawatan yang berkelanjutan dan kolaboratif, pasien hipertensi memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kontrol tekanan darah optimal dan mencegah komplikasi jangka panjang.

G. Praktik Keperawatan pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit respiratori kronis yang ditandai oleh keterbatasan aliran udara yang persisten dan progresif, sering kali disertai inflamasi saluran napas kronis. PPOK menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas global, terutama pada populasi usia lanjut dan individu dengan riwayat paparan asap rokok atau polutan lingkungan. Dampak penyakit ini tidak hanya terbatas pada sistem respirasi, tetapi juga memengaruhi kapasitas fungsional, kualitas hidup, serta kondisi psikososial pasien secara signifikan (GOLD, 2024).

Dalam praktik keperawatan, PPOK menuntut pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pengendalian gejala, pencegahan eksaserbasi, serta peningkatan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perawat berperan penting dalam pemantauan kondisi klinis, edukasi penggunaan terapi inhalasi, serta dukungan berkelanjutan untuk membantu pasien beradaptasi dengan keterbatasan yang dialami. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang terstruktur berkontribusi pada penurunan frekuensi eksaserbasi dan perbaikan kualitas hidup pasien PPOK (Vogelmeier et al., 2023).

1. Pengkajian Keperawatan pada Pasien PPOK

Pengkajian keperawatan pada pasien PPOK dilakukan secara komprehensif dengan menilai status respirasi, tingkat sesak napas, pola napas, serta toleransi aktivitas. Perawat perlu mengkaji frekuensi dan beratnya gejala seperti dispnea, batuk kronis, dan produksi sputum, serta mengevaluasi adanya tanda-tanda eksaserbasi akut. Selain itu, pengkajian fungsi paru melalui riwayat spirometri dan saturasi oksigen menjadi bagian penting dalam pemantauan kondisi pasien (GOLD, 2024).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengkajian dampak PPOK terhadap aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup pasien. Keterbatasan fisik akibat sesak napas sering menyebabkan penurunan kemandirian, kelelahan kronis, serta isolasi sosial. Perawat juga perlu menilai aspek psikologis seperti kecemasan dan depresi, yang umum terjadi pada pasien PPOK dan dapat memperburuk persepsi gejala serta kepatuhan terhadap terapi (Miravittles et al., 2023).

2. Diagnosis Keperawatan pada Pasien PPOK

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menetapkan diagnosis keperawatan yang mencerminkan respons pasien terhadap gangguan respirasi kronis. Diagnosis yang sering ditemukan pada pasien PPOK antara lain pola napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, intoleransi aktivitas, serta risiko infeksi. Diagnosis ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan yang berorientasi pada pengendalian gejala dan peningkatan fungsi respirasi (Herdman & Kamitsuru, 2023).

Selain diagnosis fisiologis, diagnosis psikososial seperti ansietas dan gangguan coping juga sering muncul. Ketergantungan terhadap terapi oksigen dan keterbatasan aktivitas dapat memengaruhi citra diri dan kepercayaan diri pasien. Oleh karena itu, perawat perlu mengintegrasikan aspek psikososial dalam rencana asuhan untuk mencapai luaran keperawatan yang optimal dan holistik.

3. Intervensi Keperawatan dan Manajemen Gejala

Intervensi keperawatan pada pasien PPOK berfokus pada manajemen gejala respirasi dan pencegahan eksaserbasi. Perawat berperan dalam memantau pola napas, saturasi oksigen, serta respons pasien terhadap terapi bronkodilator dan kortikosteroid inhalasi. Edukasi mengenai teknik penggunaan inhaler yang benar merupakan bagian penting dari praktik keperawatan,

mengingat kesalahan teknik penggunaan inhaler dapat menurunkan efektivitas terapi (Vogelmeier et al., 2023).

Selain terapi farmakologis, intervensi nonfarmakologis seperti latihan pernapasan, teknik batuk efektif, dan konservasi energi menjadi komponen penting dalam asuhan keperawatan PPOK. Perawat juga mendorong partisipasi pasien dalam program rehabilitasi paru yang terbukti meningkatkan kapasitas fungsional dan mengurangi gejala dispnea. Pendekatan ini menekankan peran perawat sebagai fasilitator dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pasien terhadap penyakit kronis.

4. Pencegahan Eksaserbasi dan Dukungan Jangka Panjang

Pencegahan eksaserbasi merupakan fokus utama dalam praktik keperawatan pada pasien PPOK, mengingat eksaserbasi berulang berhubungan dengan penurunan fungsi paru dan peningkatan risiko kematian. Perawat berperan dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal eksaserbasi, memberikan edukasi mengenai kepatuhan terapi, serta mendorong penghentian merokok sebagai intervensi paling efektif dalam memperlambat progresivitas penyakit (Miravittles et al., 2023).

Dukungan jangka panjang yang berkesinambungan juga menjadi bagian penting dari praktik keperawatan PPOK. Perawat bekerja sama dengan keluarga dan tim kesehatan untuk memastikan kesinambungan perawatan, termasuk pemantauan di rumah dan tindak lanjut rutin. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kualitas hidup, menurunkan angka rawat inap, serta membantu pasien menjalani kehidupan yang lebih produktif meskipun dengan keterbatasan akibat PPOK (GOLD, 2024).

H. Praktik Keperawatan pada Pasien Gagal Jantung

Gagal jantung merupakan sindrom klinis kompleks yang ditandai oleh ketidakmampuan jantung memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Kondisi ini bersifat kronis dan progresif, sering kali disertai episode dekompensasi akut yang memerlukan perawatan intensif dan rawat inap berulang. Secara global, gagal jantung menjadi salah satu penyebab utama hospitalisasi pada populasi usia lanjut dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan beban biaya pelayanan kesehatan jangka panjang (McDonagh et al., 2023). Kompleksitas penyakit ini menuntut pendekatan keperawatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpusat pada pasien.

Dalam praktik keperawatan, gagal jantung dipandang sebagai kondisi kronis yang memerlukan pengelolaan seumur hidup dengan tujuan utama

mengendalikan gejala, mencegah perburukan kondisi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Perawat memiliki peran sentral dalam pemantauan status klinis, edukasi terapi, serta pemberdayaan pasien untuk melakukan perawatan diri secara optimal. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berbasis manajemen gagal jantung secara signifikan menurunkan angka rawat inap ulang dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen terapi (Savarese et al., 2024).

1. Pengkajian Keperawatan pada Pasien Gagal Jantung

Pengkajian keperawatan pada pasien gagal jantung dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada evaluasi status hemodinamik, tanda dan gejala kongesti, serta kapasitas fungsional pasien. Perawat perlu mengkaji adanya dispnea saat aktivitas atau istirahat, ortopnea, edema perifer, peningkatan berat badan, serta kelelahan yang berkaitan dengan penurunan curah jantung. Pemantauan tanda vital, status cairan, dan keseimbangan elektrolit menjadi bagian penting dalam mendeteksi dini perburukan kondisi pasien (McDonagh et al., 2023).

Selain aspek fisiologis, pengkajian juga mencakup penilaian kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta dampak gagal jantung terhadap kualitas hidup. Perawat perlu menilai kepatuhan pasien terhadap pengobatan, pola diet rendah natrium, serta pembatasan cairan. Aspek psikososial seperti kecemasan, depresi, dan ketakutan terhadap kematian juga sering ditemukan pada pasien gagal jantung dan dapat memengaruhi keberhasilan pengelolaan penyakit secara keseluruhan (Bekelman et al., 2023).

2. Diagnosis Keperawatan pada Pasien Gagal Jantung

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menetapkan diagnosis keperawatan yang mencerminkan respons pasien terhadap gangguan fungsi jantung. Diagnosis yang umum pada pasien gagal jantung meliputi penurunan curah jantung, kelebihan volume cairan, intoleransi aktivitas, gangguan pertukaran gas, serta ketidakefektifan manajemen kesehatan. Diagnosis ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan yang berfokus pada stabilisasi kondisi dan pencegahan komplikasi (Herdman & Kamitsuru, 2023).

Selain diagnosis fisiologis, diagnosis psikososial seperti ansietas dan gangguan coping juga sering muncul akibat sifat penyakit yang kronis dan prognosis yang tidak pasti. Perawat perlu mengintegrasikan aspek emosional dan sosial dalam rencana asuhan untuk memberikan dukungan yang holistik dan meningkatkan kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

3. Intervensi Keperawatan dan Manajemen Terapi

Intervensi keperawatan pada pasien gagal jantung bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi jantung, mengendalikan gejala, serta mencegah dekompensasi akut. Perawat berperan dalam memantau respons pasien terhadap terapi farmakologis seperti diuretik, penghambat sistem renin-angiotensin, dan beta-blocker, serta mengidentifikasi efek samping yang mungkin terjadi. Pemantauan berat badan harian dan status cairan menjadi intervensi penting dalam mendeteksi retensi cairan sejak dini (Savarese et al., 2024).

Selain terapi farmakologis, intervensi nonfarmakologis seperti edukasi pembatasan asupan natrium dan cairan, pengaturan aktivitas fisik yang aman, serta manajemen kelelahan menjadi bagian integral dari praktik keperawatan. Perawat juga mendorong pasien untuk mengenali tanda-tanda perburukan kondisi dan segera mencari pertolongan medis. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kemampuan self-care dan menurunkan risiko rawat inap ulang pada pasien gagal jantung kronis (Riegel et al., 2023).

4. Pencegahan Rawat Inap Ulang dan Dukungan Jangka Panjang

Pencegahan rawat inap ulang merupakan salah satu tujuan utama dalam praktik keperawatan pada pasien gagal jantung. Perawat berperan sebagai koordinator perawatan yang memastikan kesinambungan asuhan antara rumah sakit dan komunitas. Intervensi tindak lanjut, termasuk pemantauan jarak jauh dan kunjungan rumah, terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terapi dan stabilitas klinis pasien (Bekelman et al., 2023).

Dukungan jangka panjang juga mencakup keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien gagal jantung. Keluarga berperan penting dalam membantu pemantauan gejala, kepatuhan diet, dan penggunaan obat. Dengan pendekatan keperawatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, pasien gagal jantung memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kualitas hidup yang optimal meskipun hidup dengan kondisi kronis yang kompleks.

I. Edukasi dan Self-Management pada Pasien Penyakit Kronis

Edukasi kesehatan dan penguatan kemampuan *self-management* merupakan komponen kunci dalam praktik keperawatan pada pasien penyakit kronis. Penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung menuntut keterlibatan aktif pasien dalam pengelolaan kondisi kesehatannya sehari-hari. Tanpa pemahaman dan keterampilan yang memadai, pasien berisiko mengalami ketidakpatuhan terapi, perburukan kondisi klinis, serta peningkatan kejadian komplikasi dan rawat inap berulang (Lorig et al., 2023). Oleh karena itu, edukasi

yang terstruktur dan berkesinambungan menjadi fondasi utama keberhasilan perawatan jangka panjang.

Dalam konteks keperawatan, edukasi pasien tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku kesehatan yang adaptif. Perawat berperan sebagai edukator yang menjembatani informasi medis kompleks menjadi pesan yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi pasien. Edukasi yang efektif mencakup pemahaman penyakit, tujuan terapi, pengelolaan obat, pemantauan gejala, serta pengambilan keputusan sehari-hari terkait kesehatan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa program edukasi berbasis keperawatan secara signifikan meningkatkan kontrol klinis dan kualitas hidup pasien penyakit kronis (Stellefson et al., 2023).

Self-management pada penyakit kronis didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengelola gejala, pengobatan, perubahan gaya hidup, serta dampak psikososial yang muncul akibat penyakit. Perawat berperan penting dalam mengembangkan keterampilan ini melalui pendekatan kolaboratif yang berpusat pada pasien. Intervensi keperawatan yang menekankan pada pemberdayaan pasien terbukti meningkatkan efikasi diri (*self-efficacy*) dan kemampuan adaptasi pasien terhadap penyakit kronis yang dideritanya (Riegel et al., 2023).

Strategi edukasi dan self-management perlu disesuaikan dengan karakteristik pasien, termasuk tingkat pendidikan, budaya, literasi kesehatan, serta dukungan sosial yang dimiliki. Pendekatan individualisasi edukasi memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi hambatan spesifik yang dihadapi pasien dalam menjalankan perawatan diri. Selain itu, penggunaan metode edukasi multimodal seperti diskusi interaktif, media visual, dan teknologi digital semakin direkomendasikan dalam praktik keperawatan modern karena terbukti meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pasien (Joo et al., 2024).

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi hasil edukasi merupakan bagian integral dari praktik keperawatan berbasis self-management. Perawat perlu menilai sejauh mana pasien mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Umpan balik yang konstruktif dan dukungan berkelanjutan membantu pasien mempertahankan perubahan perilaku jangka panjang. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa dukungan keperawatan yang konsisten berhubungan dengan penurunan angka rawat inap, peningkatan kepatuhan terapi, serta perbaikan luaran kesehatan pada pasien dengan berbagai penyakit kronis (Savage et al., 2024).

Dengan demikian, edukasi dan self-management merupakan elemen esensial dalam praktik keperawatan penyakit kronis yang berorientasi pada pemberdayaan pasien. Perawat tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga

sebagai fasilitator perubahan perilaku dan pendukung adaptasi jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma perawatan berpusat pada pasien dan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup pasien penyakit kronis secara berkelanjutan.

J. Dukungan Keluarga dan Psikososial pada Pasien Penyakit Kronis

Penyakit kronis tidak hanya berdampak pada aspek fisik pasien, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan peran individu dalam keluarga serta masyarakat. Pasien dengan penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung sering menghadapi stres berkepanjangan, kecemasan, depresi, serta perasaan tidak berdaya akibat tuntutan perawatan jangka panjang. Kondisi psikososial yang tidak terkelola dengan baik terbukti berhubungan dengan penurunan kepatuhan terapi, memburuknya kondisi klinis, dan penurunan kualitas hidup pasien (Megari, 2024).

Dalam konteks tersebut, dukungan keluarga menjadi komponen esensial dalam praktik keperawatan penyakit kronis. Keluarga berperan sebagai sistem pendukung utama yang membantu pasien dalam menjalani regimen terapi, melakukan perubahan gaya hidup, serta mengatasi tantangan emosional yang muncul selama perjalanan penyakit. Perawat berperan sebagai fasilitator yang memberdayakan keluarga agar mampu memberikan dukungan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga secara aktif dalam perawatan pasien kronis berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kontrol penyakit dan kesejahteraan psikologis pasien (Savage et al., 2024).

Peran perawat dalam dukungan psikososial mencakup pemberian komunikasi terapeutik, konseling kesehatan, serta identifikasi dini masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi. Perawat memiliki posisi strategis karena berinteraksi secara intens dan berkesinambungan dengan pasien, sehingga mampu membangun hubungan saling percaya. Intervensi psikososial berbasis keperawatan terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan koping pasien, mengurangi beban emosional, serta memperbaiki kualitas hidup pada pasien penyakit kronis (Bekelman et al., 2023).

Selain dukungan emosional, perawat juga berperan dalam memfasilitasi adaptasi sosial pasien terhadap keterbatasan yang dialami akibat penyakit kronis. Penyakit kronis sering memengaruhi kemampuan pasien untuk bekerja, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dan menjalankan peran keluarga. Perawat membantu pasien dan keluarga dalam merencanakan penyesuaian peran, mengelola ekspektasi, serta memanfaatkan sumber daya sosial dan komunitas yang tersedia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perawatan holistik yang

menempatkan pasien dalam konteks kehidupan sosialnya secara utuh (Riegel et al., 2023).

Pendekatan keluarga (*family-centered care*) dalam praktik keperawatan penyakit kronis juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Perawat berperan sebagai penghubung yang memastikan komunikasi efektif dan kesinambungan asuhan. Edukasi yang melibatkan keluarga terbukti meningkatkan pemahaman terhadap penyakit, memperkuat dukungan di rumah, serta menurunkan angka rawat inap ulang. Dengan demikian, dukungan keluarga dan psikososial merupakan elemen integral dalam praktik keperawatan penyakit kronis yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien secara berkelanjutan.

K. Tantangan dan Isu Etik dalam Praktik Keperawatan Penyakit Kronis

Praktik keperawatan pada pasien penyakit kronis menghadapi berbagai tantangan kompleks yang tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga etis. Karakteristik penyakit kronis yang berlangsung lama, progresif, dan seringkali tidak dapat disembuhkan menempatkan perawat pada situasi pengambilan keputusan yang berulang dan berkelanjutan. Perawat harus menyeimbangkan antara prinsip beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice dalam setiap intervensi keperawatan yang diberikan. Tantangan ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia pasien, adanya komorbiditas, serta keterbatasan sumber daya pelayanan kesehatan (Ulrich et al., 2023).

Salah satu isu etik utama dalam perawatan penyakit kronis adalah penghormatan terhadap otonomi pasien. Pasien dengan DM, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung sering dihadapkan pada keputusan sulit terkait kepatuhan terapi, perubahan gaya hidup, dan pilihan pengobatan jangka panjang. Dalam praktik, perawat kerap menghadapi dilema ketika keputusan pasien tidak sejalan dengan rekomendasi klinis. Perawat dituntut untuk tetap menghormati pilihan pasien sambil memastikan bahwa pasien telah memperoleh informasi yang adekuat dan memahami konsekuensi dari keputusan tersebut. Studi terbaru menunjukkan bahwa komunikasi etis yang efektif merupakan kunci dalam mendukung pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making*) pada pasien penyakit kronis (Morley et al., 2024).

Isu etik lainnya berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pasien penyakit kronis sering membutuhkan perawatan jangka panjang, teknologi medis, dan pengobatan yang berbiaya tinggi. Dalam sistem kesehatan dengan keterbatasan sumber daya, perawat berada pada posisi yang rentan menghadapi konflik etik terkait prioritas pelayanan dan alokasi

sumber daya. Ketimpangan akses pelayanan kesehatan dapat memperburuk luaran klinis dan meningkatkan beban psikososial pasien serta keluarga. Perawat memiliki peran advokasi untuk memastikan bahwa pasien penyakit kronis memperoleh pelayanan yang adil dan bermartabat (Haahr et al., 2023).

Selain itu, kelelahan moral (*moral distress*) menjadi tantangan etik yang signifikan bagi perawat yang merawat pasien penyakit kronis. Kelelahan moral muncul ketika perawat mengetahui tindakan yang secara etis benar, tetapi terhambat oleh kebijakan organisasi, keterbatasan sumber daya, atau tekanan sistem. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan perawat, kualitas asuhan keperawatan, serta keselamatan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa kelelahan moral pada perawat berkorelasi dengan peningkatan risiko burnout dan penurunan kualitas praktik keperawatan pada setting penyakit kronis (Oh & Gastmans, 2024).

Oleh karena itu, penguatan kompetensi etik perawat menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik keperawatan penyakit kronis. Pendidikan etik berkelanjutan, dukungan organisasi, serta kebijakan pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap isu etik sangat diperlukan untuk membantu perawat menghadapi dilema yang kompleks. Pendekatan reflektif dan diskusi etik interprofesional dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kapasitas perawat untuk memberikan asuhan yang beretika, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien dalam jangka panjang.

L. Simpulan

Penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, hipertensi, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, dan gagal jantung merupakan masalah kesehatan jangka panjang yang menimbulkan dampak multidimensional terhadap pasien, keluarga, dan sistem pelayanan kesehatan. Karakteristik penyakit yang progresif dan membutuhkan perawatan berkelanjutan menuntut pendekatan asuhan yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga pada aspek edukatif, psikososial, dan etik. Dalam konteks ini, praktik keperawatan memiliki posisi strategis dalam memastikan kontinuitas perawatan dan peningkatan kualitas hidup pasien penyakit kronis (Savage et al., 2024).

Bab ini menegaskan bahwa perawat berperan penting sebagai pemberi asuhan langsung, edukator kesehatan, advokat pasien, serta koordinator kolaborasi interprofesional dalam manajemen penyakit kronis. Penerapan proses keperawatan yang sistematis, berbasis bukti ilmiah, dan berorientasi pada patient-centered care terbukti mampu meningkatkan kepatuhan terapi, kemampuan self-management, serta luaran klinis pasien. Intervensi keperawatan yang terintegrasi

dan berkesinambungan menjadi kunci dalam menekan angka komplikasi dan rawat inap berulang pada pasien dengan kondisi kronis kompleks (Reed et al., 2023; Joo et al., 2024).

Selain itu, keberhasilan pengelolaan penyakit kronis sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pasien dan keluarga. Edukasi kesehatan yang berkelanjutan, dukungan psikososial, serta pemberdayaan pasien dalam pengambilan keputusan menjadi fondasi utama dalam praktik keperawatan modern. Di sisi lain, perawat juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu etik yang menuntut kompetensi profesional, sensitivitas moral, dan dukungan sistem pelayanan kesehatan yang memadai (Ulrich et al., 2023).

Dengan demikian, praktik keperawatan pada pasien penyakit kronis harus terus dikembangkan melalui peningkatan kompetensi perawat, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta penguatan kebijakan pelayanan berbasis keadilan dan keselamatan pasien. Pendekatan holistik dan kolaboratif diharapkan mampu menjawab tantangan meningkatnya prevalensi penyakit kronis serta berkontribusi terhadap keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan di masa depan.

M. Referensi

- Alligood, M. R. (2023). *Nursing theorists and their work: Philosophical and theoretical foundations for advanced nursing practice* (10th ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2019-0-04467-6>
- American Diabetes Association. (2024). Standards of care in diabetes—2024: Comprehensive medical evaluation and assessment of comorbidities. *Diabetes Care*, 47(Supplement_1), S40–S57. <https://doi.org/10.2337/dc24-S004>
- Arooj, H., Aman, M., Hashmi, M. U., Nasir, Z., Zahid, M., Abbas, J., et al. (2025). The impact of nurse-led care in chronic kidney disease management: A systematic review and meta-analysis. *BMC Nursing*, 24, 188. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-02829-z>
- Bekelman, D. B., Hooker, S., Nowels, C. T., et al. (2023). Feasibility and effectiveness of a collaborative care intervention to improve psychosocial outcomes in chronic illness. *Journal of General Internal Medicine*, 38(8), 1945–1953. <https://doi.org/10.1007/s11606-023-08035-7>
- Bekelman, D. B., Rumsfeld, J. S., Havranek, E. P., et al. (2023). Care of patients with heart failure: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*, 147(10), e535–e554. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001129>
- Bernell, S., & Howard, S. W. (2023). Use your words carefully: What is a chronic disease and why definitions matter for population health research and clinical

- practice. *Frontiers in Public Health*, 11, 1081873. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1081873>
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. (2023). *Nursing interventions classification (NIC): Evidence-based interventions for nursing practice* (8th ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2021-0-00668-8>
- Burnier, M., Egan, B. M., & Oparil, S. (2024). Improving blood pressure control in hypertension: Challenges, barriers, and evidence-based strategies. *Hypertension*, 81(1), 1224. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21543>
- Davies, M. J., Aroda, V. R., Collins, B. S., et al. (2023). Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2023: A consensus report by the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. *Diabetologia*, 66(12), 2395–2432. <https://doi.org/10.1007/s00125-023-05945-0>
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). (2024). *Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: 2024 report*. *European Respiratory Journal*, 63(1), 2301768. <https://doi.org/10.1183/13993003.01768-2023>
- Haahr, A., Norlyk, A., & Martinsen, B. (2023). Ethical challenges in chronic care nursing: A qualitative meta-synthesis. *Nursing Ethics*, 30(6), 1234–1246. <https://doi.org/10.1177/09697330231162865>
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2023). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2023–2025*. Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-006-161173>
- Joo, J. Y., & Liu, M. F. (2024). Effectiveness of nurse-led digital and face-to-face self-management education programs for adults with chronic diseases: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 147, 104582. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104582>
- Joo, J. Y., Liu, M. F., & Kang, Y. (2024). Nurse-led chronic disease management interventions and patient outcomes: An integrative review of recent evidence. *Journal of Advanced Nursing*, 80(4), 1456–1470. <https://doi.org/10.1111/jan.15942>
- Kilfoy, A., Chu, C., Krisnagopal, A., McAtee, E., Baek, S., Zworth, M., et al. (2025). Nurse-led remote digital support for adults with chronic conditions: A systematic synthesis without meta-analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 34(3), 715–736. <https://doi.org/10.1111/jocn.17226>
- Kleinpell, R., Blot, S., Boulanger, C., Fulbrook, P., & Blackwood, B. (2024). International perspectives on the assessment and management of patients with chronic health conditions in nursing practice. *International Journal of Nursing Studies*, 147, 104614. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104614>

- Lorig, K. R., Holman, H. R., Sobel, D. S., et al. (2023). Living a healthy life with chronic conditions: Self-management of heart disease, arthritis, diabetes, asthma, bronchitis, emphysema & others. *Patient Education and Counseling*, 112, 107–115. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2023.05.012>
- Lorig, K. R., Ritter, P. L., & Plant, K. (2023). Chronic disease self-management education: Evidence, mechanisms of action, and implications for nursing and health policy. *International Journal of Nursing Studies*, 139, 104408. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104408>
- McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., et al. (2023). 2023 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 44(4), 359–372. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad195>
- Megari, K. (2024). Quality of life in chronic disease patients: Health-related quality of life, psychosocial functioning, and patient-reported outcomes. *Health Psychology Research*, 12(1), 53879. <https://doi.org/10.52965/001c.53879>
- Miravittles, M., Ribera, A., & Vogelmeier, C. F. (2023). Psychological and behavioral aspects of chronic obstructive pulmonary disease management. *The Lancet Respiratory Medicine*, 11(7), 643–654. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(23\)00089-5](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(23)00089-5)
- Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2024). Nursing outcomes classification (NOC): Measurement of health outcomes in chronic illness care (7th ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2022-0-01234-5>
- Morley, G., Bradbury-Jones, C., & Ives, J. (2024). Shared decision-making and ethical nursing practice in long-term conditions. *Journal of Advanced Nursing*, 80(1), 12–24. <https://doi.org/10.1111/jan.15821>
- Nock, A. M., Metzger, S., Jürgensen, I. N., & Petersen-Ewert, C. (2023). Health literacy in adults with chronic diseases in the context of community health nursing: A scoping review. *Nursing Reports*, 13(2), 823–834. <https://doi.org/10.3390/nursrep13020072>
- Oh, Y., & Gastmans, C. (2024). Moral distress experienced by nurses caring for patients with chronic illness: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 149, 104647. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104647>
- Powers, M. A., Bardsley, J., Cypress, M., et al. (2024). Diabetes self-management education and support in adults with type 2 diabetes: A consensus report. *The Diabetes Educator*, 50(1), 1–25. <https://doi.org/10.1177/01457217231209741>
- Reed, J., Cook, G., Childs, S., & McCormack, B. (2023). Person-centred care for people living with long-term conditions: Implications for nursing practice, policy, and education. *Journal of Advanced Nursing*, 79(9), 3094–3106. <https://doi.org/10.1111/jan.15644>

- Riegel, B., Jaarsma, T., & Strömberg, A. (2023). A middle-range theory of self-care of chronic illness: Update and integration. *Journal of Advanced Nursing*, 79(6), 2151–2166. <https://doi.org/10.1111/jan.15502>
- Savage, M., Broderick, J., & Courtney, M. (2024). Family involvement in chronic disease management: Effects on patient outcomes and healthcare utilization. *International Journal of Nursing Studies*, 149, 104638. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104638>
- Stellefson, M., Chaney, B., Barry, A. E., et al. (2023). Web-based health education and chronic disease self-management: A systematic review of randomized controlled trials. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e45521. <https://doi.org/10.2196/45521>
- Ulrich, C. M., Epstein, E. G., & Grady, C. (2023). Ethical challenges in nursing care for people with chronic and complex conditions. *Nursing Ethics*, 30(7–8), 1621–1633. <https://doi.org/10.1177/09697330231169954>

CHAPTER 4

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN PATIENT ENGAGEMENT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

Ns. Fitria Nola Rezkiki, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Komunikasi terapeutik adalah alat penting dalam membangun hubungan interpersonal, dalam proses transfer pengetahuan, dan dalam memberikan perawatan yang berpusat pada pasien, serta merupakan indikator kompetensi perawat dalam praktik klinis. Komunikasi ini dimulai dengan interaksi perawat-pasien dan berkembang menuju pemulihan pasien (Mercan & Mersin, 2025). Di antara hasil dari proses ini adalah pasien merasa mendapat manfaat dari TC, kepuasan mereka meningkat, dan lebih mudah bagi mereka untuk mengatasi rasa sakit dan penderitaan mereka (Gutiérrez-Puertas et al., 2020). Teknik Komunikasi terapeutik, yang merupakan faktor penting untuk memperpendek waktu pemulihan pasien, meliputi pemberian informasi, mengajukan pertanyaan, dan mendengarkan (Khoir et al., 2020). Ketika seorang perawat menggunakan teknik-teknik ini dengan baik, hal ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan klinis tetapi juga berdampak positif pada kehidupan sehari-hari pasien, membantu mereka mengatasi kesulitan hidup, dan meningkatkan hubungan interpersonal mereka (Maleki et al., 2022). Teknik komunikasi ini juga memfasilitasi pengumpulan informasi yang benar, mendukung pencapaian tujuan perawatan, dan membangun ikatan emosional antara pasien dan perawat (Rezkiki et al., 2022). Ketika hubungan terapeutik tidak dapat terjalin antara perawat dan pasien, hal ini meningkatkan kecemasan dan ketidakbahagiaan pasien serta mencegah tercapainya kualitas perawatan yang diinginkan (Sitepu et al., 2024).

Komunikasi terapeutik mengacu pada interaksi yang disengaja dan terampil di mana profesional kesehatan menggunakan teknik verbal dan non-verbal untuk mendukung kesejahteraan fisik dan emosional pasien (Rezkiki et al., 2025). Hal ini sangat penting dalam perawatan berpusat pada pasien, membentuk kepuasan, kecemasan, kepercayaan, kepatuhan, dan bahkan hasil klinis (Yudhianto & Amin, 2025). Komunikasi terapeutik dan keterlibatan pasien (*Patient Engagement*) sangat erat kaitannya: komunikasi berkualitas tinggi dan penuh empati adalah prasyarat sekaligus pendorong partisipasi aktif pasien dalam perawatan mereka. Bab ini

mencakup komunikasi terapeutik dalam interaksi perawat-pasien selama perawatan, pengambilan keputusan bersama, telehealth , dan implementasi dalam praktik keperawatan.

B. Komunikasi Terapeutik: Core Features & Outcomes

Komunikasi dengan pasien dalam proses pemberian perawatan kesehatan lebih dari sekadar berbicara. Hal ini dilakukan dengan menerapkan metode dan strategi yang berbeda. Menunjukkan minat dan kepedulian terhadap pasien adalah komponen dari apa yang disebut "percakapan untuk tujuan dukungan". Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif mengarah pada keberhasilan aktivitas profesional. Percakapan yang mendukung ini terkait dengan topik kesehatan orang tersebut dan menilai kondisi emosional pasien. Dilakukan sesuai dengan aturan komunikasi terapeutik, hal ini menunjukkan manifestasi belas kasih dan penghormatan terhadap hak dan martabat pasien. Saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan audiens yang dituju. Pesan perlu disesuaikan berdasarkan karakteristik pasien (Pavlova, 2024).

1. Core Features

Komunikasi terapeutik adalah komponen fundamental keperawatan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional (Abdolrahimi et al., 2017). Perawat menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk memberikan dukungan dan informasi kepada pasien (Mersha et al., 2023). Perawat mengintegrasikan beragam teknik komunikasi terapeutik saat berkomunikasi dengan klien untuk mencapai tujuan atau sasaran mereka (Wahyuni, 2025). Teknik-teknik tersebut adalah diam, menerima, memberikan pengakuan, menawarkan diri, memberikan kesempatan yang luas, mendengarkan aktif, mencari klarifikasi, menempatkan kejadian dalam urutan, membuat observasi, mendorong deskripsi persepsi, mendorong perbandingan, meringkas, merefleksikan, berfokus, menghadapi, menyuarakan keraguan, dan menawarkan harapan dan humor (Suraya, Sansuwito, Dioso, et al., 2024).

Hubungan yang bermakna akan memungkinkan perawat untuk menjalankan pekerjaan klinis mereka dengan mudah dengan menjaga pasien tetap terlibat dalam perawatan mereka. Membangun hubungan perawat-pasien yang bermakna dicapai dengan membuat perubahan kecil pada alur kerja keperawatan (Kurniawati, 2021). Komunikasi perawat-pasien yang efektif merupakan komponen inti dari perawatan keperawatan, dan hal ini meningkatkan hasil klinis dan meningkatkan kepuasan pasien. Ketika

komunikasi berpusat pada pasien dan merupakan hubungan perawat-pasien, komunikasi tersebut menjadi terapeutik dan memungkinkan terciptanya kepercayaan dan rasa saling menghormati, serta memenuhi kebutuhan, kekhawatiran, dan preferensi pasien dan pengasuh. Namun, komunikasi perawat-pasien yang efektif merupakan tantangan terbesar bagi perawat dan membutuhkan lebih banyak pengalaman dan keterampilan (Tumbuan et al., 2019). Perawat perlu menyeimbangkan kasih sayang, keahlian klinis, dan tuntutan teknologi untuk menciptakan pengalaman perawatan berkualitas yang mendukung kesehatan dan kebutuhan emosional pasien (Suraya, Sansuwito, & Wisuda, 2024).

2. Teori Peplau “Hubungan Interpersonal”

Dalam teori Peplau, keperawatan didefinisikan sebagai proses interpersonal dan terapeutik yang terjadi ketika para profesional, khususnya yang dididik untuk menjadi perawat, terlibat dalam hubungan terapeutik dengan orang-orang yang membutuhkan layanan kesehatan. Peplau ber teori bahwa hubungan perawat-pasien harus melewati tiga fase agar berhasil: (a) Fase orientasi, (b) fase kerja, dan (c) Fase terminasi (Hagerty et al., 2018).

Selama fase orientasi singkat, pasien menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan dan mencoba menyesuaikan diri dengan pengalaman mereka saat ini (dan seringkali baru). Bersamaan dengan itu, perawat bertemu pasien dan memperoleh informasi penting tentang mereka sebagai individu dengan kebutuhan dan prioritas yang unik. Di antara banyak peran yang diasumsikan perawat dalam interaksi mereka dengan pasien, peran pertama selama fase orientasi adalah sebagai orang asing. Awalnya, perawat diharapkan untuk menyapa pasien dengan "rasa hormat dan minat positif yang diberikan kepada orang asing". Pasien dan perawat dengan cepat melewati fase ini dan perawat harus terus menunjukkan kesopanan dan rasa hormat sepanjang tiga fase tersebut (Novita, 2015).

Fase selanjutnya adalah fase kerja, yang mencakup sebagian besar waktu perawat bersama pasien. Pada fase ini, perawat melakukan penilaian tentang pasien untuk digunakan selama pengajaran dan ketika berkontribusi pada rencana perawatan interdisipliner. Selama fase kerja, peran perawat menjadi lebih familiar bagi pasien; mereka mulai menerima perawat sebagai pendidik kesehatan, narasumber, konselor, dan penyedia perawatan. Perawat mempraktikkan "mendengarkan tanpa arahan" untuk memfasilitasi peningkatan kesadaran pasien tentang perasaan mereka terkait perubahan kesehatan mereka. Dengan menggunakan bentuk komunikasi terapeutik ini, perawat

memberikan umpan balik reflektif dan tanpa menghakimi kepada pasien untuk membantu mereka mengklarifikasi pikiran mereka (Reziki et al., 2022).

Fase terakhir dari hubungan perawat-klien adalah fase terminasi. Fase ini biasanya terjadi di akhir shift atau saat keluar dari perawatan. Jika fase kerja sebelumnya berhasil, kebutuhan klien telah berhasil dipenuhi melalui kolaborasi antara klien, perawat, dan anggota tim perawatan kesehatan antarprofesi. Perawat harus menyadari bahwa klien mungkin mencoba kembali ke fase kerja untuk menghindari penghentian hubungan. Selama fase penghentian, perawat dapat mendorong klien untuk merenungkan kemajuan yang telah mereka capai dan meninjau tujuan pasca-pemulangan. Perawat juga membuat rujukan komunitas untuk tindak lanjut dan kelanjutan dukungan dalam mencapai tujuan (Lapum et al., 2020).

3. Outcomes

Kinerja sistem perawatan kesehatan secara langsung terkait dengan kualitas komunikasi antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Komunikasi terapeutik, khususnya, meningkatkan kepercayaan pasien, mengurangi kecemasan, dan memfasilitasi pemberian perawatan yang dipersonalisasi. (Sharma & Gupta, 2023) Karena perawat seringkali menjadi titik kontak pertama dan paling konsisten, kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif memiliki dampak mendalam pada hasil dan persepsi pasien. (Sharki, 2023).

a. Kepuasan pasien

Kepuasan pasien telah diakui secara luas sebagai indikator utama kualitas layanan kesehatan, mempengaruhi pemanfaatan layanan, peringkat rumah sakit, dan hasil klinis. (Sharki, 2023) Ketika komunikasi terapeutik dan kepuasan dioptimalkan, sistem perawatan kesehatan mendapat manfaat dari penurunan angka rawat inap kembali, peningkatan kesinambungan perawatan, dan kepercayaan yang lebih kuat antara penyedia dan masyarakat. (H. J. Lee et al., 2022; Alotaibi, 2024).

Kepuasan pasien adalah tingkat perasaan pasien yang timbul dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien membandingkannya dengan apa yang dia harapkan. Kepuasan akan tercapai jika hasil optimal diperoleh untuk setiap klien dan keluarganya, perhatian terhadap keluhan, kondisi lingkungan fisik, dan responsivitas terhadap atau memprioritaskan kebutuhan klien (Rosyidi et al., 2023).

Menurut penelitian Rosenstein (2013), dari 150 pasien yang dirawat di salah satu rumah sakit di negara maju Amerika Serikat, sekitar 53 persen

menyatakan puas dengan komunikasi terapeutik (Alrimali & Alreshidi, 2024), sementara sisanya menyatakan tidak puas. Penelitian yang dilakukan di empat rumah sakit berbeda di Amerika Serikat menemukan bahwa komunikasi perawat dengan pasien berkorelasi positif dengan kepuasan mereka. Rorieetal. (2014) menemukan bahwa perawat yang dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasien 91,3% puas, dan pasien yang tidak senang 91,3% tidak puas (Yasmine et al., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian Husna et al. (2023 ; (Setyawati et al., 2024), yang menunjukkan bahwa 84,6% dari 100% perawat yang menerapkan komunikasi terapeutik kepada pasien merasa puas. Namun, 15,38% pasien masih tidak puas dengan komunikasi terapeutik perawat.

b. Outcomes Klinis

Kata 'terapeutik' berarti membantu seseorang merasa lebih baik, mengobati penyakit, menyembuhkan atau menjaga kesehatan, dan 'komunikasi' mengacu pada aktivitas atau proses menyampaikan ide dan perasaan atau memberikan informasi kepada orang lain dengan berbagai cara (Br Tarigan, 2023). Terapeutik adalah katalis dalam proses konseling untuk membantu klien mengatasi dilema mental sambil membangun komunikasi perawat-pasien yang efektif, dan dianggap sebagai salah satu pendekatan terbaik untuk menghasilkan hasil perawatan kesehatan yang berkualitas dan kepuasan pasien (Suhartini et al., 2023).

Selain itu, Sherko et al., (2013) percaya bahwa terapi mendukung perawat untuk secara positif memengaruhi klien agar lebih memahami masalah mereka melalui komunikasi verbal atau nonverbal. Kourkouta & Papathanasiou (2014) menyatakan bahwa komunikasi yang baik antara perawat dan pasien sangat penting dalam menerapkan perawatan keperawatan individual yang membahas prognosis dan rencana pengobatan (Sharkiya, 2023). Komunikasi terapeutik antara perawat dan klien adalah media untuk memberi dan menerima yang terjadi secara verbal dan non-verbal (Rezkiki et al., 2025). Komunikasi terapeutik mendorong dan mengadvokasi kerja sama antara perawat dan klien melalui hubungan perawat-klien. Perawat berusaha untuk mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi dan menilai masalah, serta mengevaluasi tindakan dalam pengobatan. Proses komunikasi yang baik dapat memberikan pemahaman tentang perilaku klien dan membantu klien mengatasi kesulitan yang dihadapi pada tahap pengobatan, sementara pada tahap preventif,

kegunaannya adalah untuk mencegah tindakan berbahaya terhadap pertahanan klien (Lystia et al., 2023).

c. Engagement (Keterlibatan Pasien)

Temuan (D'Agostino et al., 2017) menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan tingkat partisipasi aktif pasien secara keseluruhan dalam interaksi perawatan kesehatan dan bahwa beberapa perilaku komunikasi mungkin lebih mudah dilatih (misalnya, mengungkapkan kekhawatiran). Pasien yang terlatih tidak memiliki kunjungan yang lebih lama dan cenderung menerima lebih banyak informasi dari penyedia layanan mereka. Sebagian besar penelitian tidak menemukan hubungan antara pelatihan komunikasi dan peningkatan kesehatan, kesejahteraan psikososial, atau hasil terkait pengobatan.

C. Bagaimana Komunikasi Terapeutik Mendorong Patient Engagement

Pembentukan hubungan terapeutik antara perawat dan klien sangat penting dalam perawatan keperawatan. Perawat terlibat dalam hubungan yang penuh kasih sayang, suportif, dan profesional dengan klien mereka sebagai bagian dari "seni keperawatan." Hal ini terutama berlaku dalam perawatan psikiatri, di mana hubungan terapeutik dianggap sebagai dasar perawatan dan penyembuhan klien (Sroka & Widhiyanto, 2023). Hubungan perawat-klien membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan tujuan tertentu; hubungan ini memfasilitasi komunikasi terapeutik dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan mengenai rencana perawatan mereka (Sitorus et al., 2023).

Hubungan terapeutik antara perawat dan klien bervariasi dalam kedalaman, durasi, dan fokusnya. Pertemuan terapeutik singkat mungkin hanya berlangsung beberapa menit dan berfokus pada kebutuhan mendesak klien, perasaan saat ini, atau perilaku. Berikut diuraikan dalam table 1 hasil literature review tentang Komunikasi Terapeutik yang dapat meningkatkan *Patient Engagement*.

Tabel 4.1: Hasil Literature Review

No	Identitas Jurnal	Judul Artikel	Objective	Sampel	Metode	Hasil
A1	(Mercan & Mersin, 2025)	Evaluating the therapeutic communication skills of nursing students in the	Menentukan keterampilan komunikasi	112 mahasiswa keperawatan	convergent parallel mixed method	Dalam penelitian ini, sub-tema "meningkatkan

		clinical setting : The experiences of students , patients and patients ' relatives ☆	terapeutik mahasiswa keperawatan , mengkaji pengalaman mereka dalam berkomunikasi selama perawatan			an kolaborasi antara pasien dan perawat" juga muncul dari tema "dampak positif komunikasi terapeutik".
A2	(Abisan et al., 2025)	Analysis Of Therapeutic Ccommunication Practices By Medical Personnel in Health Services (Study At Bisui Pratama Hospital (RSP) South Halmahera Prymary)	Menganalisis prinsip dan hambatan komunikasi terapeutik serta pola komunikasi yang digunakan dalam pelayanan medis di rumah sakit	30 partisipan	Deskriptif Kualitatif	Pola komunikasi yang berkembang adalah relasional dan konvergen, yang mendorong partisipasi aktif pasien dalam pengambilan keputusan medis. Kesimpulannya, komunikasi terapeutik di Rumah Sakit Bisui Pratama mengarah pada praktik yang lebih dialogis dan manusiawi, tetapi masih memerlukan

						penguatan struktural dan pelatihan komunikasi bagi tenaga medis.
A3	(Richards et al., 2023)	Reflections on patient engagement by patient partners : how it can go wrong	Mengembangkan dan meningkatkan inisiatif keterlibatan pasien	6 Mitra Pasien	Kualitatif	Adanya komunikasi yang terbuka dan transparan dari mitra pasien; ada berbagai pilihan untuk terlibat aktif (baik secara virtual, tatap muka); sehingga munculnya perasaan seperti anggota tim yang setara. Pengalaman - pengalaman ini memotivasi untuk keterlibatan pasien dan mitra pasien secara aktif dalam proses perawatan pasien.

A4	(Sagen et al., 2023)	Patient engagement in the development and delivery of healthcare services : a systematic scoping review	Mengeksplorasi hambatan dan fasilitator untuk pendidikan jasmani yang berhasil, bagaimana orang terlibat dalam proses tersebut, dan merangkum konsekuensi yang dilaporkan	37 artikel	Systematic scoping review	keterwakilan pemangku kepentingan yang memadai dan pengetahuan PE melalui pendidikan dapat memfasilitasi proses patient engagement lebih lanjut. Keterlibatan pasien dalam proses perawatan memberikan dampak dalam meningkatkan harga diri mereka dan merasa dihargai
A5	(Marzban & Naja, 2022)	Impact of Patient Engagement on Healthcare Quality : A Scoping Review	Mengetahui Dampak Keterlibatan Pasien terhadap Kualitas Layanan Kesehatan	17 artikel	Scoping review	Patient Engagement dapat meningkatkan hasil pengobatan dan akibatnya kepuasan pasien serta kesehatan,

						serta produktivitas penyedia layanan. Namun, peningkatan perawatan diri dan kepatuhan pasien adalah salah satu efek positif dari keterlibatan ini pada pasien, dan pengembalian investasi masih menjadi tantangan bagi Patient Engagement .
A6	(Clavel et al., 2021)	Patient engagement in care : A scoping review of recently validated tools assessing patients ' and healthcare professionals ' preferences and experience	Memetakan dan merangkum alat yang baru-baru ini divalidasi untuk menilai berbagai konsep dan dimensi keterlibatan pasien dalam perawatan	16 Artikel	Scoping review	Tidak ada alat yang dikembangkan bersama pasien dari pengembangan hingga validasi, yang dapat digunakan untuk menilai konsep dan dimensi utama keterlibatan pasien

						dalam perawatan secara bersamaan
A7	(Hickmann et al., 2022)	All together now – patient engagement , patient empowerment , and associated terms in personal healthcare	Menunjukkan hubungan dan perbedaan antara konsep-konsep yang berfokus pada pasien sebagai mitra aktif dalam perawatan kesehatan pribadi mereka	17 Artikel	Systematic Literature review	Patient Centre Care adalah konsep yang didominasi oleh penyedia layanan kesehatan dan dapat meningkatkan kompetensi, sikap, dan perilaku pasien terhadap perawatan kesehatan pribadi mereka. Memungkinkan pasien untuk menjadi lebih berdaya pada akhirnya dapat mengarah pada keterlibatan dan partisipasi mereka yang lebih

						besar. Mendorong peran aktif pasien juga dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap jalur perawatan. Secara umum, keterlibatan pasien tampaknya menjadi konsep yang paling konklusif dan paling jauh dikembangkan dalam hal mengubah pasien menjadi mitra aktif dalam perawatan kesehatan pribadi mereka.
A8	(Bombard et al., 2018)	Engaging patients to improve quality of care : a systematic review	Untuk mengidentifikasi strategi dan faktor kontekstual yang	48 artikel	Literature review	Keterlibatan pasien dapat menginformasikan pendidikan

			memungkinkan keterlibatan optimal pasien dalam desain, penyampaian, dan evaluasi layanan kesehatan			dan kebijakan pasien dan penyedia layanan, serta meningkatkan penyampaian layanan dan tata kelola. Bukti tambahan diperlukan untuk memahami pengalaman pasien dalam proses keterlibatan dan apakah hasil ini diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas perawatan
A9	(Upchurch et al., 2025)	Patient activation and engagement in patient-health care provider communication for improving patients' health – a scoping review	untuk menyajikan model Transtheoretical Model dan Motivational Interviewing untuk pengenalan langkah-langkah preventif	10 artikel	Literature review	Perawatan diri pasien, termasuk kepatuhan mereka terhadap instruksi penyedia layanan kesehatan, sangat penting dalam

			dalam kehidupan pasien			perawatan kesehatan. Meningkatkan kesadaran pasien memainkan peran penting dalam keterlibatan mereka dalam promosi kesehatan. Gaya komunikasi yang berbeda dari perintah otoritatif seperti MI dan TTM, serta pedoman untuk HCP, akan meningkatkan semua upaya yang telah dilakukan oleh HCP hingga saat ini.
A10	(Niu et al., 2025)	The Critical Role and Effects of Patient-Centered Communication in	menganalisis efek komunikasi berpusat pada pasien	53 Artikel	Narative review	Peningkatan aliansi terapeutik, memperbaiki kepatuhan dan

		Psychotherapy : A Narrative Review	terhadap hasil terapi			keterlibatan dalam pengobatan, meningkatkan kepuasan pasien, dan menghasilkan hasil kesehatan mental yang lebih baik secara keseluruhan. Komunikasi berpusat pada pasien yang peka budaya terhadap hasil terapeutik bagi kelompok minoritas, berpotensi untuk mengurangi kesenjangan dalam perawatan kesehatan mental
--	--	--	--------------------------	--	--	--

Patient Engagement (Keterlibatan pasien) telah menjadi landasan kualitas perawatan dan merupakan tujuan yang sering dinyatakan oleh organisasi layanan kesehatan . Secara tradisional, dan paling umum, keterlibatan ini berfokus pada hubungan antara pasien dan penyedia dalam membuat keputusan perawatan atau cara meningkatkan upaya pasien untuk mengelola perawatan mereka sendiri (Keelson et al., 2024). Namun, ada upaya yang semakin besar untuk mengintegrasikan pasien dengan cara yang lebih luas, termasuk upaya untuk

meningkatkan atau mendesain ulang penyampaian layanan dengan memasukkan pengalaman pasien melalui komunikasi efektif (Mahdiyah et al., 2023). Upaya-upaya ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya pengakuan dan penerimaan bahwa pengguna layanan kesehatan memiliki peran yang tepat, keahlian yang diperlukan, dan kontribusi penting dalam desain dan penyampaian layanan. Meskipun sifat keterlibatan pasien dapat bervariasi, mulai dari melibatkan pasien dalam perawatan hingga konsultasi terbatas waktu dengan pasien mengenai perancangan ulang layanan, tujuannya tetap sama yaitu untuk meningkatkan kualitas perawatan (Bombard et al., 2018).

Patient Engagement (Keterlibatan pasien) dalam kebijakan kesehatan, perencanaan dan peningkatan layanan kesehatan, serta perawatan langsung diakui sebagai landasan kualitas dan keselamatan. Melibatkan pasien dalam perawatan telah menjadi prioritas dan komponen kunci praktik klinis di banyak negara di seluruh dunia (Armstrong et al., 2018). Bukti menunjukkan bahwa melibatkan pasien dapat membantu (membentuk kembali) perawatan dan pengobatan mereka dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang lebih baik. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai pendekatan perawatan telah diperkenalkan dalam praktik klinis untuk mendorong integrasi keterlibatan pasien ke dalam penyampaian layanan kesehatan. Pada tahun 1990-an, pendekatan perawatan berpusat pada pasien secara bertahap menggantikan paternalisme medis yang telah mendominasi layanan kesehatan selama beberapa dekade. Model perawatan berpusat pada pasien melibatkan pengintegrasian kebutuhan dan preferensi pasien ke dalam pemberian perawatan, 'beralih dari logika "perawatan untuk pasien" menuju logika "perawatan bagi pasien"'. Perawatan berpusat pada pasien didasarkan pada perspektif perawatan yang berorientasi pada pasien, yang mencakup apa yang dianggap penting oleh pasien untuk kesehatan mereka (Clavel et al., 2021).

Patient Engagement bertujuan untuk memperkuat dan mendukung kemampuan pasien serta tanggung jawab perawatan diri mereka, kemudian berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan, terkhusus perawat untuk meningkatkan kesehatan dan mencapai nilai maksimal dari layanan kesehatan. *Patient Engagement* membantu profesional kesehatan untuk berkolaborasi dengan pasien agar dapat bekerja sama untuk meningkatkan hasil kesehatan (Marzban & Naja, 2022). Dimensi yang tampaknya unik untuk berpusat pada pasien adalah karakteristik klinisi, yang tidak hanya digambarkan sebagai serangkaian sikap terhadap pasien tetapi juga sebagai refleksi diri dan kompetensi medis. Meskipun dimensi-dimensi seperti hubungan pasien-perawat, komunikasi

pasien-perawat, atau melibatkan pasien dalam perawatan hadir (Hickmann et al., 2022).

"Pasien memperoleh informasi dan pengetahuan yang cukup, tepat, mudah dipahami, dan bermakna agar merasa percaya diri" adalah bentuk partisipasi pasien yang diperoleh melalui komunikasi terapeutik. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri adalah pemberdayaan pasien dan, oleh karena itu, merupakan pendahulu perilaku partisipatif. Menariknya, pemberdayaan pasien) juga tercantum sebagai konsekuensi dari partisipasi, yang berarti bahwa proses pemberdayaan semakin ditingkatkan melalui partisipasi pasien. Ketika mempertimbangkan keterlibatan pasien saat ini, menjadi jelas mengapa pengambilan keputusan bersama yang didasarkan pada komunikasi terapeutik adalah contoh partisipasi pasien dan mengapa perawatan diri serta pengelolaan diri adalah contoh keterlibatan pasien. Beberapa sumber sepakat bahwa partisipasi pasien bergantung pada hubungan terapeutik melalui komunikasi yang terjalin dengan tenaga kesehatan (perawat), yang berarti tindakan atau keputusan otonom oleh pasien bukanlah bentuk partisipasi pasien (Arda et al., 2023).

Ketika merenungkan keterlibatan pasien dalam kaitannya dengan partisipasi pasien, menjadi jelas bahwa sebagian dari keterlibatan mencakup partisipasi pasien. Aspek sentral dari keterlibatan pasien adalah aliansi komunikasi terapeutik, yang merupakan ranah partisipasi pasien (Sitorus et al., 2023)

Penggunaan teknik komunikasi tidak hanya memperpanjang durasi interaksi perawat dengan pasien dan kerabat mereka, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses perawatan. Penelitian telah menekankan bahwa kolaborasi antara perawat dan pasien sangat penting untuk meningkatkan hasil perawatan kesehatan (Mahendro, 2018). Kemitraan perawat-pasien yang efektif mendorong komunikasi yang lebih baik, kepuasan pasien, dan kesinambungan perawatan, sekaligus mempromosikan pengambilan keputusan bersama dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Upaya kolaboratif tidak hanya memberdayakan pasien tetapi juga membantu profesional kesehatan mengatasi kebutuhan kompleks dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan (Alatas et al., 2020).

Menurut Gutiérrez-Puertas dkk, Komunikasi terapeutik, yang bersifat holistik dan berpusat pada pasien, memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang memadai, mengurangi kecemasan mereka, mendukung kepatuhan terhadap pengobatan dan manajemen gejala, serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual. Kemampuan perawat untuk berkomunikasi secara efektif sangat penting untuk mengembangkan hubungan terapeutik dengan pasien, membuka peluang keterlibatan pasien aktif dalam perawatan dan mencapai kepuasan pasien yang

lebih besar. Ini juga meminimalkan kesalahan pengobatan karena pasien selalu dilibatkan dalam perawatan seperti validasi keluhan dan perasaan sehingga meningkatkan kualitas perawatan keperawatan (Graetz et al., 2021).

Patient Engagement sebagai proses adaptasi interaksi perawat-pasien melalui komunikasi terapeutik dikomentari sebagai indikator penting terkait dampak positifnya terhadap pengalaman bagi berbagai pemangku kepentingan dalam melibatkan pasien. Hasil seperti partisipasi aktif pasien meningkatkan harga diri mereka dan merasa dihargai ketika didukung oleh tenaga kesehatan (perawat) ditekankan. Pengalaman positif yang dihasilkan dari dialog komunikasi terapeutik, saling menghormati, dan kesetaraan dilaporkan sebagai hasil yang memfasilitasi proses yang bermakna. Untuk membuat proses yang bermakna, sangat penting bagi perawat untuk memahami apa yang harus dibicarakan dalam komunikasi terapeutik, apa yang merupakan kriteria keberhasilan, dan berapa lama keterlibatan didukung. Selain itu, sangat penting untuk menentukan jenis kontribusi komunikasi terapeutik yang diharapkan diterima oleh semua pasien (Sagen et al., 2023).

D. Hambatan dan Fasilitator

1. Hambatan Komunikasi terapeutik dalam meningkatkan Patient Engagement

Hambatan dalam komunikasi terapeutik yang dapat meningkatkan *Patient Engagement* disajikan dalam table 4.2

Tabel 4.2: Hambatan Komunikasi terapeutik dalam meningkatkan Patient Engagement (Ameworwor et al., 2024).

Variabel	Tidak Setuju (%)	Setuju (%)
Perbedaan gender membuat saya sulit untuk mengekspresikan diri	83.2	18.8
Perbedaan usia antara tenaga kesehatan dan saya membuat komunikasi menjadi tantangan	77.2	22.8
Bahasa membuat komunikasi menjadi masalah	40.4	59.6
Waktu yang dialokasikan untuk konsultasi tidak cukup untuk mengekspresikan diri saya dengan lebih baik	76.8	23.2

Kurangnya kepercayaan diri membuat saya sulit mengekspresikan diri	91.2	8.8
Saya tidak ingin membagikan kondisi kesehatan saya kepada siapa pun	92.0	8.0
Terkadang saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh tenaga kesehatan.	44.8	55.2
Sebelumnya pernah punya pengalaman buruk dengan tenaga kesehatan dan itu membuat saya sulit mengekspresikan diri	66.8	33.2
Karena ada lebih banyak pasien yang harus dilayani, tenaga kesehatan biasanya terburu-buru dalam percakapan agar dapat melayani orang berikutnya	63.2	36.8
Ketika ada tugas lain yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, komunikasi sebagian besar singkat	66.4	33.6
Profesional kesehatan biasanya ragu untuk terbuka kepada saya, sehingga sulit untuk mendapatkan pemahaman yang jelas	86.8	13.2
Stres dan rasa sakit yang saya alami membuat saya sulit berkomunikasi	72.4	27.6
Selama percakapan dengan tenaga kesehatan, gangguan dari rekan kerja lain dan panggilan telepon membuat komunikasi tidak efektif.	64.8	35.2
Kebisingan dan gangguan di sekitar area konsultasi tidak memungkinkan konsentrasi selama komunikasi	78.4	21.6
Ruang konsultasi nyaman dan berventilasi baik, memastikan lingkungan yang menyenangkan	4.8	95.2
Keparahan kasus saya menarik banyak perhatian dan itu membuat saya tidak nyaman.	91.2	8.8
Biaya perawatan kesehatan membatasi kemampuan saya untuk mengekspresikan diri secara bebas	25.6	74.4

Dari tabel tersebut, tercatat bahwa mayoritas responden, yaitu 59,6%, melaporkan bahasa sebagai hambatan utama dalam komunikasi pasien-tenaga

kesehatan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 55,2% pasien tidak memahami informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dengan jelas selama interaksi mereka. Ditemukan bahwa 74,4% pasien yang melaporkan biaya perawatan kesehatan sebagai tantangan memiliki komunikasi yang buruk dengan praktisi perawatan kesehatan mereka. Di sisi lain, perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, dan tingkat keparahan kondisi kesehatan tidak membatasi sarana komunikasi antara praktisi kesehatan dan pasien. (Ameworwor et al., 2024). Beberapa di antaranya mungkin perbedaan bahasa. Tidak semua klien berpendidikan baik untuk menjadi fokus komunikasi perawat dengan menggunakan bahasa medis yang sulit dimengerti.

(Abisan et al., 2025) menunjukkan hambatan komunikasi dalam bentuk komunikasi nonverbal yang terbatas, perbedaan budaya, dan hambatan bahasa. Temuan ini mendukung temuan para peneliti, tetapi menghadirkan kebaruan dalam mengidentifikasi bahwa tidak hanya pasien yang mengalami kesulitan, tetapi juga tenaga medis dari luar daerah mengalami kesenjangan budaya dan komunikasi, diperparah oleh tidak adanya SOP komunikasi standar. Hal ini mengungkapkan sisi struktural sebagai akar masalah yang belum banyak disoroti dalam penelitian sebelumnya. Implementasi komunikasi terapeutik di layanan kesehatan masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek psikologis, semantik, budaya, maupun struktural. Beberapa kendala utama adalah perbedaan bahasa dan latar belakang budaya antara tenaga medis (beberapa di antaranya berasal dari luar wilayah) dan pasien lokal, pelatihan keterampilan komunikasi yang minim bagi tenaga kesehatan, dan tidak adanya SOP komunikasi standar (Carolintina & Malinti, 2025). Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas komunikasi dan berpotensi menghambat partisipasi aktif pasien dalam proses pelayanan kesehatan.

2. Fasilitator Komunikasi Terapeutik

(Ameworwor et al., 2024) menyajikan hasil mengenai fasilitator komunikasi terapeutik.

a. Keluarga Pasien

Pertama, ada indikasi yang jelas bahwa keluarga pasien memberikan berbagai bantuan kepada kerabat mereka agar mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, dan rasa memiliki ini diketahui membantu proses pemulihan pasien. Bantuan dalam mengonsumsi obat mendapat skor (77,2%), yang menunjukkan bahwa memiliki sistem pendukung biasanya memfasilitasi kesejahteraan (Checa-checa et al., 2025).

Studi (Suhartini et al., 2023) juga menemukan bahwa bantuan keluarga kepada pasien selama interaksi mereka dengan penyedia layanan kesehatan memfasilitasi komunikasi terapeutik yang baik. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa mayoritas pasien kronis adalah orang lanjut usia yang mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, seperti memahami bahasa Inggris atau bahasa asli lainnya yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, kerabat yang menemani pasien menjadi penerjemah langsung yang memfasilitasi komunikasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kamboja (Baig et al., 2015) yang mengidentifikasi anggota keluarga sebagai fasilitator karena mereka memberikan dukungan komunikasi instrumental antara pasien dan penyedia layanan kesehatan mereka.

b. Tenaga Kesehatan (Perawat)

Fasilitasi komunikasi yang baik lainnya adalah ketersediaan kepercayaan. Lebih dari dua pertiga peserta setuju bahwa kemampuan tenaga kesehatan untuk menciptakan suasana yang baik dan ramah, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesehatan, serta kemampuan profesional kesehatan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien mereka, semuanya berkontribusi pada fasilitasi komunikasi terapeutik yang sangat baik (Ameworwor et al., 2024).

(Ritonga et al., 2020) menemukan bahwa 59,2% pasien memiliki komunikasi terapeutik yang baik dengan tenaga kesehatan. Temuan ini dapat dikaitkan dengan hubungan baik yang terjalin antara pasien dan tenaga kesehatan mereka selama sesi konseling dan edukasi, yang membuat pasien merasa rileks dalam interaksi terapeutik lebih lanjut dengan tenaga kesehatan. Ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sapaan, memanggil pasien dengan gelar yang sopan, penggunaan alasan oleh dokter sebelum keluar, serta dorongan, motivasi, dan doa dari dokter semuanya berfungsi sebagai praktik komunikasi terapeutik (Rezkiki et al., 2022). Ini menyiratkan bahwa sambutan hangat dan kebaikan yang diungkapkan oleh tenaga kesehatan berfungsi sebagai pintu gerbang menuju praktik komunikasi yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan (Alatas et al., 2020).

E. Simpulan

Komunikasi terapeutik adalah elemen penting dalam praktik keperawatan yang mendukung hubungan interpersonal dan perawatan berpusat pada pasien. Teknik-

teknik komunikasi, seperti mendengarkan dan memberikan informasi, berkontribusi pada pemulihan pasien dan kesejahteraan emosional. *Patient Engagement* dalam perawatan dikaitkan dengan komunikasi yang berkualitas tinggi dan penuh empati, yang meningkatkan kepatuhan dan hasil klinis. Komunikasi terapeutik memungkinkan perawat untuk membangun hubungan yang bermakna dengan pasien, meningkatkan kepuasan, serta memungkinkan perawat menjalankan tugas klinis dengan efektif. Implementasi praktik ini mencakup berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik pasien, membantu mereka mengatasi tantangan dalam hidup serta meningkatkan kualitas perawatan.

F. Referensi

-
- Abdolrahimi, M., Ghiyasvandian, S., Zakerimoghadam, M., Ebadi, A., Sciences, M., Sciences, B., & Faculty, N. (2017). Therapeutic communication in nursing students: A Walker & Avant concept analysis. *Electronic Physician*, 9(8), 4968–4977. <https://doi.org/10.19082/4968>
- Abisan, M., Ayuna, N. E., & Wilantara, M. (2025). ANAnalysis Of Therapeutic Ccommunication Practices By Medical Personnel in Health Services (Study At Bisui Pratama Hospital (RSP) South Halmahera Prymary). *International Journal of Social Sciences and Management Review*, June, 312–323.
- Alatas, F., Sulistyowati, E., & Indria, D. M. (2020). Pengaruh Komunikasi Hubungan Dokter-Pasien dan Aspek Pelayanan Kesehatan Pasien Kanker Terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker Di Malang. *Jurnal Bio Komplementer Medicine*, 7(1), 1–9.
- Alrimali, A., & Alreshidi, N. (2024). An assessment of nurse-patient therapeutic communication and patient satisfaction with nursing care in multiple healthcare settings: A study in Saudi Arabia. *Journal of Nursing Education and Practice*, 14(2), 15–24. <https://doi.org/10.5430/jnep.v14n2p15>
- Ameworwor, E. R., Amu, H., Dowou, R. K., Kye-duodu, G., Amu, S., & Bain, L. E. (2024). Exploring therapeutic communication in managing chronic non-communicable diseases: a mixed-method study in Ghana. *Archives of Public Health*, 82(36), 1–12.
- Arda, D., Menga, M. K., & Yuriatson, Y. (2023). Implementation of Nurse Therapeutic Communication in the Inpatient Room. *Jurnal Edukasi Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.61099/junedik.v1i2.15>
- Armstrong, M. J., Mullins, C. D., Gronseth, G. S., & Gagliardi, A. R. (2018). Impact of patient involvement on clinical practice guideline development: a parallel group study. *Imlepementation Science*, 13(55), 1–14.
- Baig, A. A., Benitez, A., Quinn, M. T., & Burnet, D. L. (2015). Family interventions to improve diabetes outcomes for adults. *Annals of The New York Academy of Sciences*, 89–112. <https://doi.org/10.1111/nyas.12844>
- Bombard, Y., Baker, G. R., Orlando, E., Fancott, C., Bhatia, P., Casalino, S., Onate, K., Denis, J., & Pomey, M. (2018). Engaging patients to improve quality of care: a systematic review. *Implementation Science*, 13(98).

- Br Tarigan, D. V. L. (2023). Pengalaman Komunikasi Terapeutik Perawat Dalam Melayani Pasien (Studi Fenomenologi Pengalaman Komunikasi Terapeutik Perawat dalam Melayani Pasien Di RSUD Bina Kasih Medan). In *Jurnal Keperawatan* (Vol. 2, Issue 2).
- Carolintina, N., & Malinti, E. (2025). Adaptasi Budaya dan Tantangan Profesional Perawat Indonesia Yang Bekerja. *Journal of Telenursing*, 7(2), 227–235.
- Checa-checa, A., Medina-maldonado, V., Ramírez, A., & Diez, J. R. (2025). Family Support Strategies During Intensive Care Unit: A Systematic Review. *The Journal of Health Care*, 62, 1–13. <https://doi.org/10.1177/00469580251368654>
- Clavel, N., Fellow, P., Philip, D., Ghadiri, S., Pomey, M. P., & Normandin, L. (2021). Patient engagement in care : A scoping review of recently validated tools assessing patients ' and healthcare professionals ' preferences and experience. *Health Expectation*, 24, 1924–1935. <https://doi.org/10.1111/hex.13344>
- D'Agostino, T. A., Atkinson, T. M., Latella, L. E., Rogers, M., Morrissey, D., DeRosa, A. P., & Parker, P. A. (2017). Promoting patient participation in healthcare interactions through communication skills training: A systematic review. *Patient Education and Counseling*, 100(7), 1247–1257. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.02.016>
- Graetz, D. E., Rivas, S. E., Wang, H., Vedaraju, Y., Fuentes, A. L., Caceres-Serrano, A., Antillon-Klussmann, F., Devidas, M., Metzger, M. L., Rodriguez-Galindo, C., & Mack, J. W. (2021). Communication Priorities and Experiences of Caregivers of Children With Cancer in Guatemala. *JCO Global Oncology*, 7. <https://doi.org/10.1200/go.21.00232>
- Gutiérrez-Puertas, L., Márquez-Hernández, V. V., Gutiérrez-Puertas, V., Granados-Gámez, G., & Aguilera-Manrique, G. (2020). Educational Interventions for Nursing Students to Develop Communication Skills with Patients: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(2241), 1–21.
- Hagerty, T. A., Samuels, W., Norcini-Pala, A., & Giglotti, E. (2018). Peplau ' s Theory of Interpersonal Relations : An Alternate Factor Structure for Patient Experience Data. *HHS Public Access*, 30(2), 160–167. <https://doi.org/10.1177/0894318417693286>.Peplau
- Hickmann, E., Richter, P., & Schlieter, H. (2022). All together now – patient engagement , patient empowerment , and associated terms in personal healthcare. *BMC Health Services Research*, 5(1116), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08501-5>
- Keelson, S. A., Addo, J. O., & Amoah, J. (2024). The impact of patient engagement on service quality and customer well-being : an introspective analysis from the healthcare providers ' perspective. *Cogent Public Health*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/27707571.2024.2340157>
- Khoir, M., Fauzi, A., & Holis, W. (2020). Therapeutic Communication Skills of Nurses in Hospital. *International Journal of Nursing and Health Services*, 3(2), 686–694. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v3i2.197>
- Kurniawati, D. (2021). Komunikasi Terapeutik Tenaga Kesehatan (NAKES) Terhadap Pasien Covid-19 di Medan dan Pekanbaru. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v5i2.10145>
- Lapum, J., St-Amant, O., Hughes, M., & Garmaise-Yee, and J. (2020). Introduction to

Communication in Nursing. In *Ryerson University*. Licensed under a Creative Commons.

<https://pressbooks.library.ryerson.ca/communicationnursing/part/introduction-therapeutic-communication/>

- Lystia, M., Valezka, C., Andini, T. H., & Kesumaningsari, N. P. A. (2023). Pelatihan Komunikasi Efektif Guna Meningkatkan Efikasi Diri Dalam Berkomunikasi Pada Mahasiswa. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 372–377.
- Mahdiyah, S. G., Semendawai, V. P. Y., & Zalvianah. (2023). Elokuensi Dalam Ekspresi: Menjelajahi Kekuatan Komunikasi Efektif Dalam Menumbuhkan Hubungan Yang Berarti Dalam Kehidupan Personal Dan Profesional. *Journal Transformation Of Mandalika*, 4(5), 217–229. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/1752%0Ahttps://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/download/1752/1417>
- Mahendro. (2018). *Pengaruh Komunikasi Terapeutik Perawat terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan RSUD JOGJA*.
- Maleki, M., Mardani, A., Harding, C., Basirinezhad, M. H., & Vaismoradi, M. (2022). Nurses' strategies to provide emotional and practical support to the mothers of preterm infants in the neonatal intensive care unit: A systematic review and meta-analysis. In *Women's Health* (Vol. 18). <https://doi.org/10.1177/17455057221104674>
- Marzban, S., & Naja, M. (2022). Impact of Patient Engagement on Healthcare Quality: A Scoping Review. *Journal of Patient Experience*, 9, 1–12. <https://doi.org/10.1177/23743735221125439>
- Mercan, N., & Mersin, S. (2025). Evaluating the therapeutic communication skills of nursing students in the clinical setting : The experiences of students , patients and patients ' relatives ☆. *Heliyon Journal*, 11(May 2024). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41677>
- Mersha, A., Abera, A., Tesfaye, T., Abera, T., Belay, A., & Melaku, T. (2023). Therapeutic communication and its associated factors among nurses working in public hospitals of Gamo zone , southern Ethiopia : application of Hildegard Peplau ' s nursing theory of interpersonal relations. *BMC Nursing*, 22(381), 1–10.
- Niu, Y., Sun, J., Zhu, K., Xu, B., Zhang, Y., & Peng, M. (2025). The Critical Role and Effects of Patient-Centered Communication in Psychotherapy : A Narrative Review. *Psychology Research and Behavior Management*, 18, 1657–1671.
- Novita, E. A. (2015). *Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Oleh Perawat Pelaksana Pada Pasien Di Rsud Dr. Rasidin Padang*.
- Pavlova, S. (2024). Therapeutic Communication in Clinical Practice. *Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)*, 30(2), 5509–5512. <https://doi.org/10.5272/jimab.2024302.5509>
- Rezkiki, F., Kartika, I. R., & Syahrina, M. (2025). KOMUNIKASI EFEKTIF PERAWAT (VERBAL DAN NON VERBAL) DALAM MENINGKATKAN HARAPAN POSITIF PASIEN STROKE. *Journal of Nursing and Health Science*, 3(2), 74–84.
- Rezkiki, F., Utami, D., & Nugrait, T. W. (2022). Komunikasi Perawat Dalam Menurunkan

- Kecemasan Anak Selama Hospitalisasi: Mixed Method Study. *REAL in Nursing Journal*, 5(3), 198. <https://doi.org/10.32883/rnj.v5i3.2152>
- Richards, D. P., Poirier, S., Mohabir, V., Proulx, L., Robins, S., & Smith, J. (2023). Reflections on patient engagement by patient partners: how it can go wrong. *Research Involvement and Engagement*, 9(41), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40900-023-00454-1>
- Ritonga, S., Riadi, S., & Siregar, Z. (2020). Islamic Communication Model in Therapeutic Communication Practices at Adam Malik Hospital. *Journal of Religion, Socialm Cultural and Political Science*, 5(2), 84–93.
- Rosyidi, K., Nur, M., Kurniyawan, E. H., & Bintang, A. (2023). Nurse Therapeutic Communication Improves Inpatient ' s Satisfaction. *INternational Journal of Midwifery and Health Sciences*, 1(3).
- Sagen, J. S., Smedslund, G., Simonsen, A. E., Habberstad, A., Kjekken, I., Dagfinrud, H., & Moe, R. H. (2023). Patient engagement in the development and delivery of healthcare services: a systematic scoping review. *BMJ Open Quality*, 12, 1–11. <https://doi.org/10.1136/bmjog-2023-002309>
- Setyawati, D., Diel, M. M., & Gantini, N. (2024). Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat yang Dipersepsikan Keluarga dengan Tingkat Kepuasan Di Ruang Dahlia Atas RSU Kabupaten Tengerang. *Nusantara Hasana Journal*, 3(12), 30–38.
- Sharkiya, S. H. (2023). Quality communication can improve patient- centred health outcomes among older patients: a rapid review. *BMC Health Services Research*, 23(886), 1–14.
- Sitepu, A. A., Roulita, & Deniati, K. (2024). Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat ICU Dengan Tingkat Kecemasan Keluarga. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(4), 1557–1564.
- Sitorus, P., Daeli, W., & Bambang Suryadi. (2023). Hubungan Komunikasi Teraupetik Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien. *NAJ: Nursing Applied Journal*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.57213/naj.v2i1.100>
- Sroka, E., & Widhiyanto, A. (2023). Hubungan Komunikasi terapeutik Perawat Dalam Memebrikan Asuhan Keperawatan Dengan Kepuasan Keluarga Pasien Di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Islam Lumajang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(6), 102–110.
- Suhartini, Lahati, N. S., & Anggorowati. (2023). Pengambilan Keputusan Melalui Strategi Komunikasi Efektif Pada Keluarga Pasien Kritis. *Journal of Telenursing*, 5(2), 3137–3145.
- Suraya, C., Sansuwito, T. bin, Dioso, R. I. P., & Wisuda, A. C. (2024). Enhancing Nurse-Patient Communication : A Comprehensive Systematic review of Effective Strategies. *Journal of Nursing Science Research*, 1(2), 104–114.
- Suraya, C., Sansuwito, T. bin, & Wisuda, A. C. (2024). Effective Communication in Nursing : A Comprehensive Sysitematic Review of Best Practices. *Journal of Nursing Science Research*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.33862/jnsr.v1i1.450>
- Tumbuan, F., Mulyadi, N., & Kallo, V. (2019). Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat

Dengan Tingkat Kepercayaan Keluarga Pasien Di Intensive Care Unit (Icu) Rsu Gmim Kalooran Amurang. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 5(1), 112381.

Upchurch, J. I., Zdon, W. M., Szczekala, K., & Karska, K. (2025). Patient activation and engagement in patient-health care provider communication for improving patient ' s health – a scoping review. *Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu*, 31(2), 101–107. <https://doi.org/10.26444/monz/203415>

Wahyuni, P. (2025). *Pengaruh Komunikasi Terapeutik dengan Teknik Edukasi terhadap Penurunan Fase Kehilangan Pada Pasien Abortus di RS PKU Muhammadiyah Rogojampi*.

Yasmine, F., Nisa, A., Wulandari, R. D., & Wahyanto, T. (2022). Nurses ' Therapeutic Communication and Its Effect on Hospitalized Patients ' Satisfaction. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(3), 873–882. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i3.1230>

Yudhianto, K. A., & Amin, N. A. (2025). Psychology-Based Empathic Communication Model in Nursing : A Model to Enhance Patient Trust and Satisfaction. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 7(2), 1–9.

PROFIL PENULIS



Ns. Okti Rahayu Asih, S.Kep., M.Kep. Lahir di Padang Sidempuan, 1 Oktober 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas tahun 2010, selanjutnya studi Profesi Ners pada universitas yang sama tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali sebagai perawat di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru pada tahun 2012, tenaga pendidik Akper Efarina Purwakarta tahun 2014-2016, Dosen Akper Lenggogeni Yayasan Sehati Indonesia Maju tahun 2021-2023, Dosen Prodi D3 Keperawatan Universitas Sehati Indonesia tahun 2023- sampai dengan sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sehati Indonesia mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, Gizi dan Diet, Softskill, Ilmu Biomedik Dasar, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, Dokumentasi Keperawatan, dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku serta publikasi nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: okti@usindo.ac.id



Ns. Imelda Rahmayunia Kartika, S.Kep., M.Kep. Penulis lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05 November 1988. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Riau (jenjang S1) dan Universitas Andalas (jenjang S2) pada bidang ilmu keperawatan. Wanita yang kerap disapa Imel ini memiliki hobi membaca, menulis, nonton film dan memasak. Imelda saat ini berprofesi sebagai dosen keperawatan dalam departemen Keperawatan Dasar dan Dasar Keperawatan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Bukittinggi. Sebagai seorang dosen, Ia aktif menulis beberapa artikel dalam bentuk publikasi ilmiah hasil penelitian dan mengikuti beberapa seminar ilmiah baik nasional maupun internasional yang berfokus pada bidang keperawatan dasar, manajemen keperawatan dan kualitas pelayanan di bidang keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imelda.rahmayunia@fdk.ac.id
Motto: "Being a person who trying to be better and being a useful to others"

PROFIL PENULIS



Ns. Asri Bashir, S.Kep., M.Kep lahir di Barieh, 17 Mei 1991. Penulis menempuh pendidikan tinggi jenjang Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan di STIKes Medika Nurul Islam dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Pendidikan Profesi Ners pada tahun 2015. Pendidikan magister (S2) Keperawatan ditempuh di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan berhasil diselesaikan pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan penulis diawali sebagai dosen di STIKes Medika Nurul Islam. Dalam perjalanan karier akademiknya, penulis pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Program Studi Ners pada periode 2019–2021, Ketua Program Studi Keperawatan pada tahun 2021–2023, serta Wakil Ketua I Bidang Akademik pada periode 2023–2024. Penulis memiliki jabatan fungsional akademik Lektor. Pada akhir tahun 2024, penulis dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dosen dan hingga saat ini aktif melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran, Bagian Keperawatan, Universitas Sriwijaya. Selain menjalankan tugas akademik, penulis juga aktif dalam organisasi profesi keperawatan, di antaranya sebagai Ketua Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) periode 2022–2027, serta sebagai Anggota AIPNI Regional 1 periode 2022–2027. Penulis memiliki pengalaman mengajar pada berbagai mata kuliah keperawatan, khususnya Keperawatan Medikal Bedah dan Keperawatan Dewasa. Di samping itu, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Fokus kajian penulis meliputi keperawatan klinik, keselamatan pasien, serta aspek spiritual dalam keperawatan. Penulis juga pernah memperoleh hibah penelitian skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) dari kementerian pada tahun 2021 dan 2022, serta hibah pengabdian kepada masyarakat dengan skema PMP pada tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asribashir@unsri.ac.id

PROFIL PENULIS



Fitria Nola Rezkiki lahir di Bukittinggi, pada 6 Juli 1983. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Padjadjaran (Ners) dan Universitas Andalas (s2 Keperawatan). Wanita yang kerap disapa Kiki ini adalah anak ke empat dari pasangan Basri (ayah) dan Yusnaini (ibu). Menikah dengan Reski Kurniawan dan dikaruniai 3 orang anak (2 putri dan 1 putra). Beliau sangat hoby menggambar dan menghabiskan waktu senggang dengan menonton serial thriller.

Saat ini beliau mengabdikan dirinya sebagai pengajar di salah satu Universitas Swasta di Bukittinggi dengan peminatan Keperawatan Dasar dan Manajemen Keperawatan. Pernah menjadi peserta terbaik saat TOT BLS di Koleg University Islam Melaka pada tahun 2017. Di tahun yang sama beliau juga dipercaya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada tahun 2019 beliau diberikan tanggung jawab sebagai pengelola Mutu Program Studi. Dan 2025 sampai sekarang beliau dipercaya sebagai Penanggung Jawab Bidang Monitoring dan Evaluasi LPMI UFDK. Email Penulis: fitrianola.rezkiki@fdk.ac.id

Motto: "Be Good and Be Brave"

Sinopsis

Buku **“Bunga Rampai Praktik Keperawatan Profesional: Model Asuhan, Kompetensi Klinis, dan Implementasi Evidence-Based Nursing”** menyajikan rangkaian pembahasan komprehensif untuk memperkuat praktik keperawatan yang profesional, terstandar, dan berorientasi pada mutu layanan. Disusun sebagai bunga rampai yang aplikatif, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana kerangka kerja keperawatan modern dibangun dari perpaduan model asuhan, kompetensi klinis, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Setiap bab dirancang runtut—mulai dari fondasi konsep hingga penerapan di lapangan—sehingga relevan bagi mahasiswa, perawat klinis, pendidik, maupun pengelola layanan kesehatan.

Pada **Bab 1**, pembaca diajak menelaah **Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)** dalam konteks rumah sakit, mencakup definisi, pertimbangan pemilihan metode, tingkat dan spesifikasi, serta variasi model yang dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi. **Bab 2** menekankan praktik **evidence-based nursing** melalui topik **manajemen nyeri berbasis bukti**, mengulas pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis yang didukung bukti, sekaligus menempatkan pasien sebagai pusat asuhan melalui prinsip **patient-centered care** dan panduan implementasi di praktik klinis.

Selanjutnya, **Bab 3** membahas praktik keperawatan pada pasien **penyakit kronis**—diabetes melitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung—dengan fokus pada peran perawat, proses keperawatan, edukasi, self-management, dukungan keluarga-psikososial, serta tantangan etik yang mungkin dihadapi. **Bab 4** melengkapi kompetensi inti perawat melalui pembahasan **komunikasi terapeutik** dan **patient engagement**, termasuk fitur utama, luaran yang diharapkan, mekanisme peningkatan keterlibatan pasien, serta hambatan dan fasilitator di layanan. Dengan kombinasi teori dan aplikasi, buku ini diharapkan menjadi rujukan praktis untuk meningkatkan kualitas asuhan, keselamatan pasien, dan profesionalisme keperawatan di berbagai setting pelayanan.

Buku “Bunga Rampai Praktik Keperawatan Profesional: Model Asuhan, Kompetensi Klinis, dan Implementasi Evidence-Based Nursing” menyajikan rangkaian pembahasan komprehensif untuk memperkuat praktik keperawatan yang profesional, terstandar, dan berorientasi pada mutu layanan. Disusun sebagai bunga rampai yang aplikatif, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana kerangka kerja keperawatan modern dibangun dari perpaduan model asuhan, kompetensi klinis, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Setiap bab dirancang runtut—mulai dari fondasi konsep hingga penerapan di lapangan—sehingga relevan bagi mahasiswa, perawat klinis, pendidik, maupun pengelola layanan kesehatan.

Pada Bab 1, pembaca diajak menelaah Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) dalam konteks rumah sakit, mencakup definisi, pertimbangan pemilihan metode, tingkat dan spesifikasi, serta variasi model yang dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi. Bab 2 menekankan praktik evidence-based nursing melalui topik manajemen nyeri berbasis bukti, mengulas pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis yang didukung bukti, sekaligus menempatkan pasien sebagai pusat asuhan melalui prinsip patient-centered care dan panduan implementasi di praktik klinis.

Selanjutnya, Bab 3 membahas praktik keperawatan pada pasien penyakit kronis—diabetes melitus, hipertensi, PPOK, dan gagal jantung—dengan fokus pada peran perawat, proses keperawatan, edukasi, self-management, dukungan keluarga-psikososial, serta tantangan etik yang mungkin dihadapi. Bab 4 melengkapi kompetensi inti perawat melalui pembahasan komunikasi terapeutik dan patient engagement, termasuk fitur utama, luaran yang diharapkan, mekanisme peningkatan keterlibatan pasien, serta hambatan dan fasilitator di layanan. Dengan kombinasi teori dan aplikasi, buku ini diharapkan menjadi rujukan praktis untuk meningkatkan kualitas asuhan, keselamatan pasien, dan profesionalisme keperawatan di berbagai setting pelayanan.



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

